ΕΚΑΒ ΣΠΟΥΔΗ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ — ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πλήρη πραγματικά κείμενα των 71 κεφαλαίων, SOS, επεξηγήσεις, ασκήσεις και ενδεικτικές απαντήσεις από τις έξι ενότητες της υπάρχουσας εφαρμογής.

Εκπαιδευτικό υλικό, όχι ανεξάρτητα πιστοποιημένο ιατρικό εγχειρίδιο. Η ύλη και οι εικόνες μπορεί να χρειάζονται επιστημονική επικύρωση. Δεν υποκαθιστά πρακτική διδασκαλία ή τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Πρόγραμμα: Επίσημος Οδηγός Κατάρτισης Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, Σεπτέμβριος 2024.

Περιεχόμενα

01 Ανατομία

01 · Ανατομική θέση και προσανατολισμός

02 · Οστά του κορμού και των άκρων

03 · Θώρακας και αναπνευστικό σύστημα

04 · Κοιλιακά όργανα

05 · Νευρικό και κυκλοφορικό σύστημα

06 · Κύτταρο, ιστοί και όργανα

07 · Σπονδυλική στήλη και νωτιαίος μυελός

08 · Κρανίο, εγκέφαλος και μήνιγγες

09 · Αρθρώσεις, σύνδεσμοι και μύες

10 · Καρδιά, μεγάλα αγγεία και βαλβίδες

11 · Ανώτεροι και κατώτεροι αεραγωγοί

12 · Πεπτικό σύστημα και αδένες

13 · Ουροποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα

14 · Ανατομικοί χώροι και τεταρτημόρια κοιλιάς

02 Φυσιολογία

01 · Ομοιόσταση και ανατροφοδότηση

02 · Φυσιολογία της αναπνοής

03 · Κυκλοφορία και αιμάτωση

04 · Νευρική ρύθμιση και μεταβολισμός

05 · Μεμβράνες και μεταφορά ουσιών

06 · Νευρική ώση και αντανακλαστικά

07 · Καρδιακός κύκλος και ηλεκτρική αγωγή

08 · Πίεση, αντίσταση και μικροκυκλοφορία

09 · Αερισμός, διάχυση και μεταφορά αερίων

10 · Οξεοβασική ισορροπία

11 · Νεφρική λειτουργία και ισοζύγιο υγρών

12 · Πέψη, απορρόφηση και θρέψη

13 · Ενδοκρινής ρύθμιση και γλυκόζη

03 Ο Διασώστης – Επαγγελματίας Υγείας

01 · Αποστολή και επαγγελματικά όρια

02 · Επικοινωνία, αξιοπρέπεια και εμπιστευτικότητα

03 · Ασφάλεια πληρώματος και συνεχής εκπαίδευση

04 · Το σύστημα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας

05 · Συναίνεση και λήψη αποφάσεων

06 · Επαγγελματικό απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

07 · Ασφαλής μετακίνηση και εργονομία

08 · Ψυχολογική υποστήριξη και επικοινωνία

09 · Συνεργασία ομάδας και παράδοση περιστατικού

10 · Επαγγελματική ανθεκτικότητα και όρια

04 Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας

01 · Τι είναι δημόσια υγεία

02 · Αλυσίδα μετάδοσης λοιμώξεων

03 · Πρόληψη και ευάλωτοι πληθυσμοί

04 · Υγεία, νόσος και κοινωνικοί προσδιοριστές

05 · Βασικές έννοιες επιδημιολογίας

06 · Βακτήρια, ιοί και μύκητες

07 · Υγιεινή χεριών και ατομική προστασία

08 · Καθαρισμός, απολύμανση, αποστείρωση

09 · Ανοσία και εμβολιασμός

10 · Ασφαλής διαχείριση αιχμηρών και βιολογικών υλικών

05 Εισαγωγή στην Προνοσοκομειακή Εκτίμηση και Υποστήριξη του Ασθενούς

01 · Ασφάλεια σκηνής — βασική εισαγωγή

02 · ABCDE — συνοπτική εισαγωγή

03 · Ζωτικά σημεία — πρώτη γνωριμία

04 · Ιστορικό — αρχικό πλαίσιο

05 · Προσέγγιση σκηνής — αναλυτική αξιολόγηση

06 · Γρήγορη αναγνώριση απειλής για τη ζωή

07 · Πρωτογενής εκτίμηση ABCDE — αναλυτικά

08 · Αεραγωγός και αναπνευστική προσπάθεια

09 · Κυκλοφορία, σφυγμός και αιμορραγία

10 · Επίπεδο συνείδησης και νευρολογική παρατήρηση

11 · Ζωτικά σημεία — μεθοδολογία και τεκμηρίωση

12 · Λήψη ιστορικού — δομή SAMPLE

13 · Εκτίμηση πόνου και OPQRST

14 · Επανεκτίμηση και ασφαλής διακομιδή

06 Βασική Αγγλική Ορολογία Προνοσοκομειακής Φροντίδας

01 · Ζωτικά σημεία – vital signs

02 · Συμπτώματα και ερωτήσεις

03 · Ασφάλεια και μεταφορά

04 · Ανατομικές κατευθύνσεις – English terms

05 · Οστά και αρθρώσεις – terminology

06 · Αναπνευστικό σύστημα – terminology

07 · Καρδιά και κυκλοφορία – terminology

08 · Βασικά συμπτώματα – symptoms

09 · Αρχική εκτίμηση – assessment

10 · Μεταφορά και παράδοση – handover

01 · Ανατομία

01.01 — Ανατομική θέση και προσανατολισμός

Η ανατομική θέση περιγράφει το σώμα όρθιο, με τα άνω άκρα στο πλάι και τις παλάμες στραμμένες προς τα εμπρός. «Άνω» σημαίνει προς την κεφαλή, «κάτω» προς τα πόδια, «πρόσθιο» προς την κοιλιά και «οπίσθιο» προς τη ράχη. Οι όροι «έσω» και «έξω» προσδιορίζουν αν μια δομή βρίσκεται κοντά ή μακριά από τη μέση γραμμή. Η κοινή ορολογία βοηθά το πλήρωμα να περιγράφει με ακρίβεια τραύματα και ευρήματα.

SOS · Ανατομική θέση: όρθιο σώμα, παλάμες εμπρός· οι κατευθύνσεις δεξιά/αριστερά αναφέρονται στον ασθενή.

Αναλυτική κατανόηση

Ο ανατομικός προσανατολισμός λειτουργεί ως κοινή «γλώσσα» μεταξύ διασώστη, διαβιβαστή και ΤΕΠ. Κεντρικά σημαίνει πλησιέστερα στον άξονα του σώματος, περιφερικά μακρύτερα από αυτόν· εγγύς και άπω συγκρίνουν σημεία στο ίδιο άκρο. Το μέσο επίπεδο χωρίζει το σώμα σε δεξιό και αριστερό τμήμα, το μετωπιαίο σε πρόσθιο και οπίσθιο και το εγκάρσιο σε άνω και κάτω. Το δεξί και αριστερό αναφέρονται πάντοτε στην πλευρά του ασθενούς, όχι του παρατηρητή.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Για τραύμα περιγράφουμε συγκεκριμένα θέση, πλευρά, μέγεθος και γειτονικό ανατομικό σημείο. «Άπω τμήμα δεξιού αντιβραχίου, ραχιαία επιφάνεια» είναι ακριβέστερο από «πίσω από το χέρι».

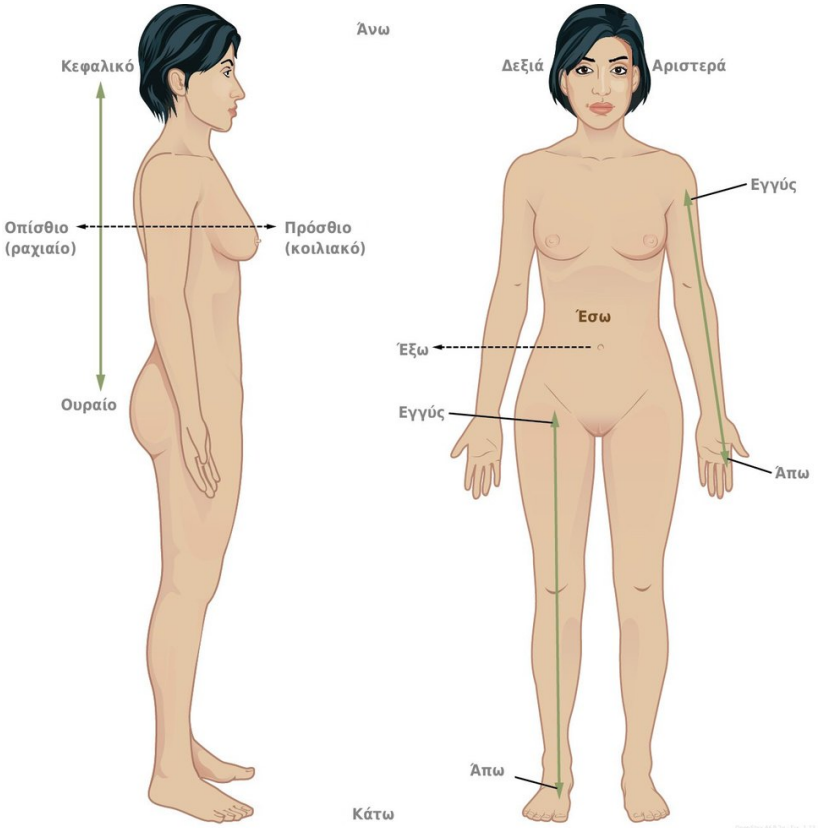
Ποια είναι η διαφορά «εγγύς» και «άπω»;

Εγγύς = κοντά στην πρόσφυση ή στην αρχή του άκρου· άπω = μακριά από αυτή.

Σε βάθος — επεξήγηση

Αφετηρία όλων των ανατομικών περιγραφών είναι το σώμα του ίδιου του ασθενούς: το δεξί του δεν αλλάζει όταν τον κοιτάζουμε από απέναντι. Το οβελιαίο επίπεδο χωρίζει δεξιά/αριστερά, το μετωπιαίο πρόσθια/οπίσθια και το εγκάρσιο άνω/κάτω. Ο όρος εγγύς σημαίνει πλησιέστερα στη ρίζα ενός άκρου, ενώ άπω σημαίνει μακρύτερα. Αυτή η συνέπεια προστατεύει από λανθασμένη καταγραφή του σημείου τραυματισμού.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Ανατομικοί προσανατολισμοί. Κατευθυντικοί όροι στο ανθρώπινο σώμα (προσθίως, οπισθίως, άνω, κάτω, εγγύς, άπω).. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-6-anatomical-terminology.

01.02 — Οστά του κορμού και των άκρων

Ο αξονικός σκελετός περιλαμβάνει το κρανίο, τη σπονδυλική στήλη, τις πλευρές και το στέρνο. Ο σκελετός των άκρων περιλαμβάνει την ωμική ζώνη, τα οστά των άνω άκρων, την πύελο και τα οστά των κάτω άκρων. Στο άνω άκρο αναγνωρίζουμε βραχιόνιο, κερκίδα και ωλένη· στο κάτω άκρο μηριαίο, επιγονατίδα, κνήμη και περόνη. Η σωστή αναγνώριση βοηθά στην περιγραφή κακώσεων και στην αποφυγή ακατάλληλων χειρισμών.

SOS · Αξονικός σκελετός: κρανίο, σπονδυλική στήλη, πλευρές, στέρνο· σκελετός άκρων: ζώνες και οστά άνω/κάτω άκρων.

Αναλυτική κατανόηση

Ο αξονικός σκελετός περιλαμβάνει κρανίο, σπονδυλική στήλη και θωρακικό κλωβό. Ο σκελετός των άκρων περιλαμβάνει την ωμική ζώνη, τα άνω άκρα, την πυελική ζώνη και τα κάτω άκρα. Η σπονδυλική στήλη περιγράφεται σε αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή, ιερή και κοκκυγική μοίρα. Η κερκίδα είναι στην πλευρά του αντίχειρα όταν το αντιβράχιο βρίσκεται σε ανατομική θέση, η ωλένη στην πλευρά του μικρού δακτύλου. Η κνήμη εντοπίζεται έσω και η περόνη έξω στην κνήμη-περόνη του κάτω άκρου.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Στην εκτίμηση κατάγματος εξετάζουμε παραμόρφωση, τραύμα, πόνο, κυκλοφορία, αισθητικότητα και κινητικότητα περιφερικά της κάκωσης πριν και μετά από ακινητοποίηση σύμφωνα με την εκπαίδευση.

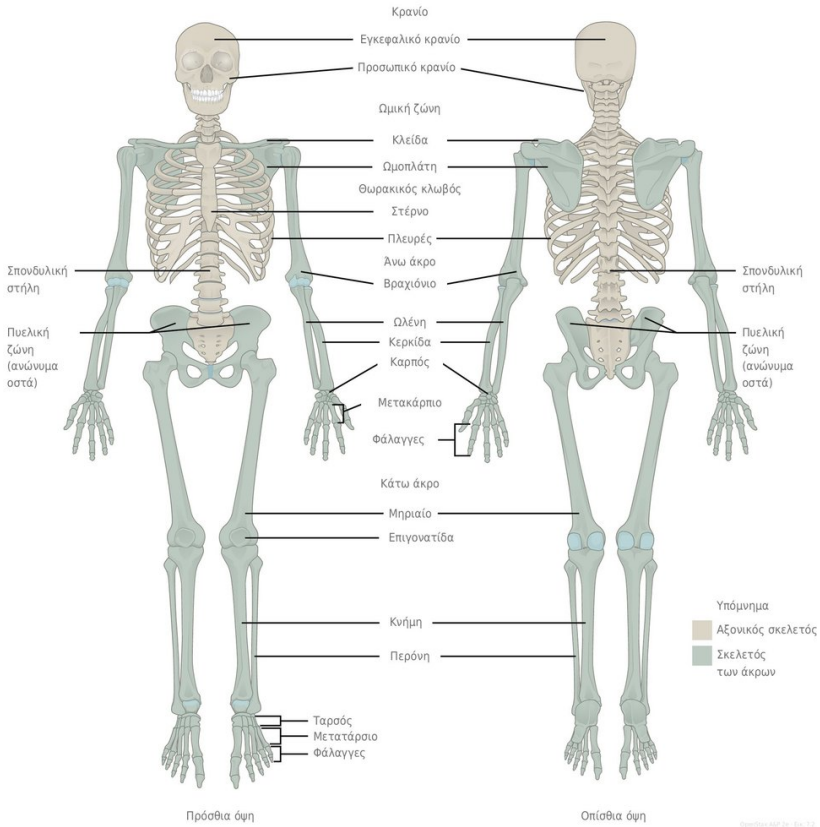
Ποια δύο οστά σχηματίζουν το αντιβράχιο;

Η κερκίδα και η ωλένη.

Σε βάθος — επεξήγηση

Ο αξονικός σκελετός περιλαμβάνει το κρανίο, τη σπονδυλική στήλη και τον θώρακα. Ο σκελετός των άκρων περιλαμβάνει ωμική και πυελική ζώνη μαζί με τα οστά των άνω και κάτω άκρων. Στο άνω άκρο αναγνωρίζουμε βραχιόνιο, κερκίδα και ωλένη· στο κάτω, μηριαίο, επιγονατίδα, κνήμη και περόνη. Σε οποιαδήποτε κάκωση εξετάζουμε παράλληλα την περιφερική αιμάτωση και την αισθητικότητα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Αξονικό και άκρο σκελετός. Αξονικός και επικουρικός σκελετός με ελληνικές ονομασίες οστών.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/7-1-divisions-of-the-skeletal-system.

01.03 — Θώρακας και αναπνευστικό σύστημα

Η θωρακική κοιλότητα προστατεύεται από πλευρές, στέρνο και θωρακικούς σπονδύλους. Οι πνεύμονες βρίσκονται στον θώρακα, εκατέρωθεν του μεσοθωρακίου, ενώ η καρδιά βρίσκεται κυρίως πίσω από το στέρνο, ελαφρώς προς τα αριστερά. Η τραχεία διακλαδίζεται στους κύριους βρόγχους και αυτοί οδηγούν στον πνευμονικό ιστό. Το διάφραγμα χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά και συμμετέχει αποφασιστικά στην εισπνοή.

SOS · Η τραχεία καταλήγει στους κύριους βρόγχους· οι κυψελίδες είναι ο τόπος ανταλλαγής αερίων και το διάφραγμα κύριος εισπνευστικός μυς.

Αναλυτική κατανόηση

Ο θώρακας περικλείει τους πνεύμονες και, στο μεσοθωράκιο, την καρδιά, μεγάλα αγγεία, τραχεία και οισοφάγο. Ο αέρας εισέρχεται από ρινική ή στοματική κοιλότητα, περνά από φάρυγγα, λάρυγγα, τραχεία, βρόγχους και βρογχιόλια και καταλήγει στις κυψελίδες. Εκεί πραγματοποιείται ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα με τα πνευμονικά τριχοειδή. Το διάφραγμα συσπάται και κατέρχεται στην εισπνοή,

αυξάνοντας τον όγκο της θωρακικής κοιλότητας.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Η πλευρά και το ύψος μιας κάκωσης θώρακα βοηθούν στην υπόθεση πιθανών βλαβών, αλλά η ανατομική θέση μόνη της δεν αποτελεί διάγνωση.

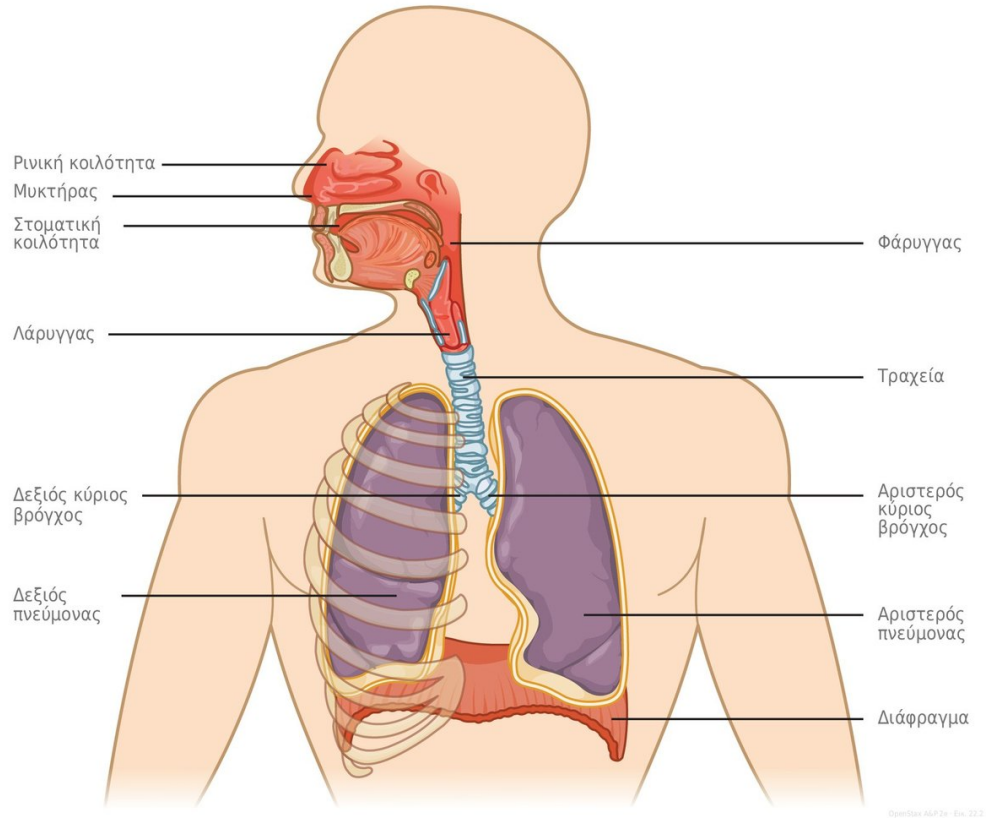
Ποια ανατομική δομή χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά;

Το διάφραγμα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Ο θώρακας περικλείει τους πνεύμονες, την καρδιά και μεγάλα αγγεία. Το στέρνο, τα πλευρά και οι θωρακικοί σπόνδυλοι σχηματίζουν τον οστέινο κλωβό. Ο δεξιός πνεύμονας έχει συνήθως τρεις λοβούς και ο αριστερός δύο. Το διάφραγμα χωρίζει θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα και αποτελεί τον κύριο μυ της ήρεμης εισπνοής. Η ανατομία εξηγεί γιατί η βλάβη πλευρών ή πνευμόνων δυσκολεύει τον αερισμό.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Κύριες δομές αναπνευστικού. Ρινική κοιλότητα, φάρυγγας, λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι, πνεύμονες, διάφραγμα.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/22-1-organs-and-structures-of-the-respiratory-system.

01.04 — Κοιλιακά όργανα

Στην άνω κοιλιά βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το ήπαρ κυρίως δεξιά, το στομάχι κυρίως αριστερά και ο σπλήνας αριστερά. Το λεπτό και το παχύ έντερο καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της κοιλιάς. Οι νεφροί βρίσκονται οπισθοπεριτοναϊκά, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης. Οι περιγραφές «δεξιό άνω τεταρτημόριο» ή «αριστερό κάτω τεταρτημόριο» επιτρέπουν σαφή καταγραφή της εντόπισης άλγους.

SOS · Ήπαρ κυρίως δεξιά άνω, σπλήνας και στομάχι κυρίως αριστερά άνω· οι νεφροί είναι οπισθοπεριτοναϊκοί.

Αναλυτική κατανόηση

Η κοιλιακή χώρα περιγράφεται πρακτικά σε τέσσερα τεταρτημόρια. Στο δεξιό άνω βρίσκεται κυρίως το ήπαρ και η χοληδόχος κύστη· στο αριστερό άνω βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο σπλήνας και τμήμα του στομάχου. Οι νεφροί βρίσκονται στο οπίσθιο κοιλιακό διαμέρισμα, δηλαδή οπισθοπεριτοναϊκά. Το λεπτό έντερο επιτελεί το μεγαλύτερο μέρος της απορρόφησης θρεπτικών ουσιών, ενώ το παχύ έντερο συμβάλλει στην απορρόφηση νερού. Η ουροδόχος κύστη βρίσκεται στην πύελο.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Πόνος ή τραύμα σε συγκεκριμένο τεταρτημόριο πρέπει να καταγράφεται μαζί με τη γενική εικόνα, τον μηχανισμό κάκωσης και τα ζωτικά σημεία, όχι να οδηγεί σε αυθαίρετη διάγνωση οργάνου.

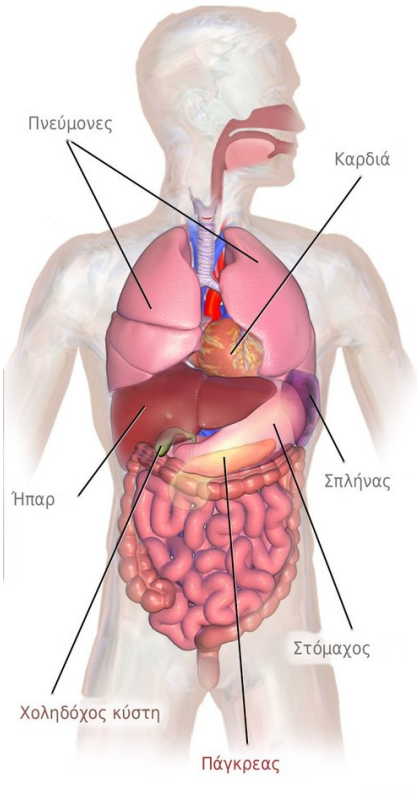
Πού βρίσκεται κυρίως ο σπλήνας;

Στο αριστερό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το ήπαρ βρίσκεται κυρίως στο δεξιό άνω τεταρτημόριο, το στομάχι και ο σπλήνας προς το αριστερό άνω, και το έντερο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της κοιλιάς. Οι νεφροί είναι οπισθοπεριτοναϊκοί. Η θέση ενός οργάνου δεν αρκεί για διάγνωση κοιλιακού πόνου, επειδή ο σπλαχνικός πόνος μπορεί να προβάλλεται αλλού. Η αναφορά θέσης, ποιότητας πόνου και συνοδών συμπτωμάτων πρέπει να είναι συγκεκριμένη.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Όργανα της κοιλιάς. Θέση των κοιλιακών οργάνων (ήπαρ, στόμαχος, έντερα, νεφροί κ.ά.).. Δημιουργός: BruceBlaus (Blausen.com staff). Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abdominal_Organs_Anatomy.png.

01.05 — Νευρικό και κυκλοφορικό σύστημα

Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός αποτελούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η καρδιά είναι τετράχωρο όργανο με δύο κόλπους και δύο κοιλίες· οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά και οι φλέβες προς αυτή. Η αορτή εκφύεται από την αριστερή κοιλία, ενώ η πνευμονική αρτηρία μεταφέρει αίμα προς τους πνεύμονες. Η σύνδεση ανατομίας και λειτουργίας βοηθά στην κατανόηση των σημείων shock, εγκεφαλικού και αναπνευστικής ανεπάρκειας.

SOS · ΚΝΣ = εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός· οι αρτηρίες απομακρύνουν αίμα από την καρδιά, οι φλέβες το επιστρέφουν.

Αναλυτική κατανόηση

Το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό· το περιφερικό τα νεύρα που μεταφέρουν αισθητικά και κινητικά σήματα. Η καρδιά έχει τέσσερις κοιλότητες: δεξιό/αριστερό κόλπο και δεξιά/αριστερή κοιλία. Στην πνευμονική κυκλοφορία αίμα πηγαίνει από τη δεξιά κοιλία στους πνεύμονες και επιστρέφει στον αριστερό κόλπο. Στη συστηματική κυκλοφορία αίμα φεύγει από την αριστερή κοιλία μέσω της αορτής. Οι στεφανιαίες αρτηρίες τροφοδοτούν το μυοκάρδιο με αίμα.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Η αιφνίδια εστιακή αδυναμία μπορεί να υποδηλώνει νευρολογικό επείγον και ο θωρακικός πόνος καρδιολογικό επείγον· και τα δύο απαιτούν συστηματική αρχική εκτίμηση και έγκαιρη ενημέρωση.

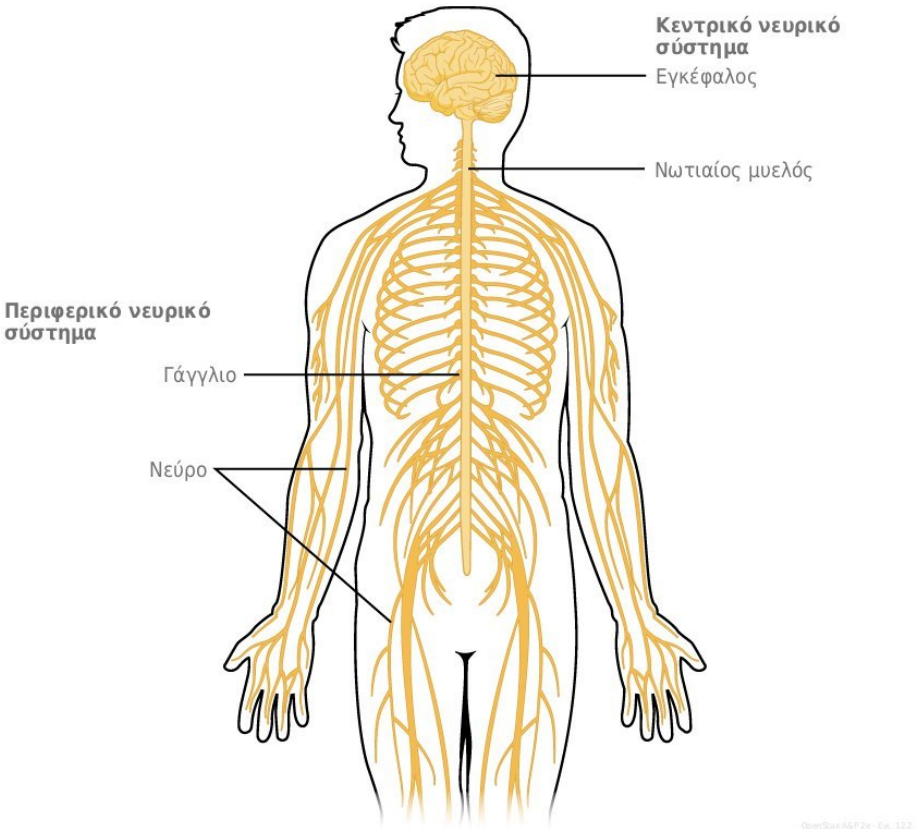
Από ποια κοιλία αρχίζει η συστηματική κυκλοφορία;

Από την αριστερή κοιλία, μέσω της αορτής.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό, ενώ το περιφερικό νεύρα και γάγγλια. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα μακριά από την καρδιά και οι φλέβες προς αυτήν, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους σε οξυγόνο. Εξαίρεση στην απλοϊκή σύνδεση «αρτηρία = οξυγονωμένο» αποτελούν η πνευμονική αρτηρία και οι πνευμονικές φλέβες. Χρειάζεται σαφήνεια στη διάκριση ανατομής και λειτουργίας.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Διαχωρισμός ΚΝΣ (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός) και ΠΝΣ (νεύρα, γάγγλια).. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-1-basic-structure-and-function-of-the-nervous-system.

01.06 — Κύτταρο, ιστοί και όργανα

Το κύτταρο είναι η βασική λειτουργική μονάδα του ανθρώπινου σώματος. Η κυτταρική μεμβράνη ρυθμίζει την ανταλλαγή ουσιών, ο πυρήνας περιέχει το γενετικό υλικό και τα μιτοχόνδρια συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας. Όμοια κύτταρα με κοινό ρόλο συγκροτούν ιστούς.

SOS · Κύτταρο → ιστός → όργανο → σύστημα· διαφορετικοί ιστοί συνεργάζονται για τη λειτουργία του οργάνου.

Θεωρία & κατανόηση

Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες ιστών είναι ο επιθηλιακός, ο συνδετικός, ο μυϊκός και ο νευρικός. Όργανο είναι μια δομή που αποτελείται από περισσότερους ιστούς και επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία. Το όργανο συμμετέχει σε σύστημα οργάνων, όπως το αναπνευστικό ή το κυκλοφορικό.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Τέσσερις βασικοί ιστοί: επιθηλιακός, συνδετικός, μυϊκός, νευρικός.

Ποια είναι η διαφορά ιστού και οργάνου;

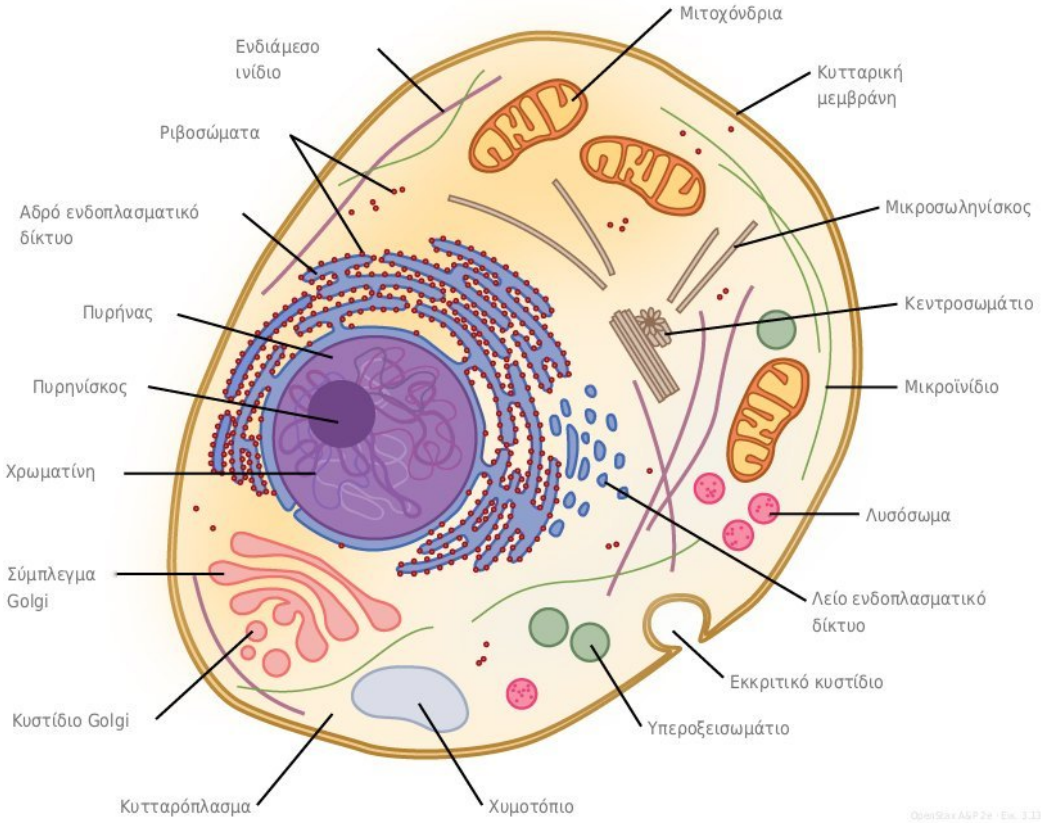
Ο ιστός περιλαμβάνει κύτταρα με κοινά γνωρίσματα, ενώ το όργανο συνδυάζει διαφορετικούς ιστούς για μία λειτουργία.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το κύτταρο διατηρεί δικό του μεταβολισμό, ενώ η λειτουργία του εξαρτάται από την παροχή οξυγόνου, θρεπτικών ουσιών και την απομάκρυνση αποβλήτων. Ο επιθηλιακός ιστός καλύπτει επιφάνειες, ο συνδετικός στηρίζει, ο μυϊκός παράγει κίνηση και ο νευρικός μεταδίδει πληροφορία. Η σχέση

κύτταρο–ιστός–όργανο–σύστημα είναι ο βασικός «χάρτης» για να καταλάβουμε τη δυσλειτουργία πολλών οργάνων μαζί.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Τυπικό ανθρώπινο κύτταρο. Οργανίδια του κυττάρου (πυρήνας, μιτοχόνδρια, ΕΔ, σύμπλεγμα Golgi κ.ά.).. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/3-2-the-cytoplasm-and-cellular-organelles.

01.07 — Σπονδυλική στήλη και νωτιαίος μυελός

Η σπονδυλική στήλη αποτελεί τον άξονα στήριξης του κορμού και σχηματίζεται από αυχενικούς, θωρακικούς, οσφυϊκούς, ιερούς και κοκκυγικούς σπονδύλους. Μεταξύ των περισσότερων γειτονικών σπονδύλων υπάρχουν μεσοσπονδύλιοι δίσκοι που συμβάλλουν στην απορρόφηση φορτίσεων.

SOS · Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί σπόνδυλοι· ο νωτιαίος μυελός μεταφέρει νευρικά σήματα.

Θεωρία & κατανόηση

Ο σπονδυλικός σωλήνας προστατεύει τον νωτιαίο μυελό, ενώ τα νωτιαία νεύρα περνούν προς τον κορμό και τα άκρα. Η βλάβη του νωτιαίου μυελού μπορεί να προκαλέσει διαταραχές κίνησης, αισθητικότητας και αυτόνομων λειτουργιών. Σε τραυματία, η προστασία της σπονδυλικής στήλης καθορίζεται από τη συνολική εκτίμηση και το ισχύον πρωτόκολλο.

Βασικό σημείο για επανάληψη

7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί και 5 οσφυϊκοί σπόνδυλοι στον τυπικό ανθρώπινο σκελετό.

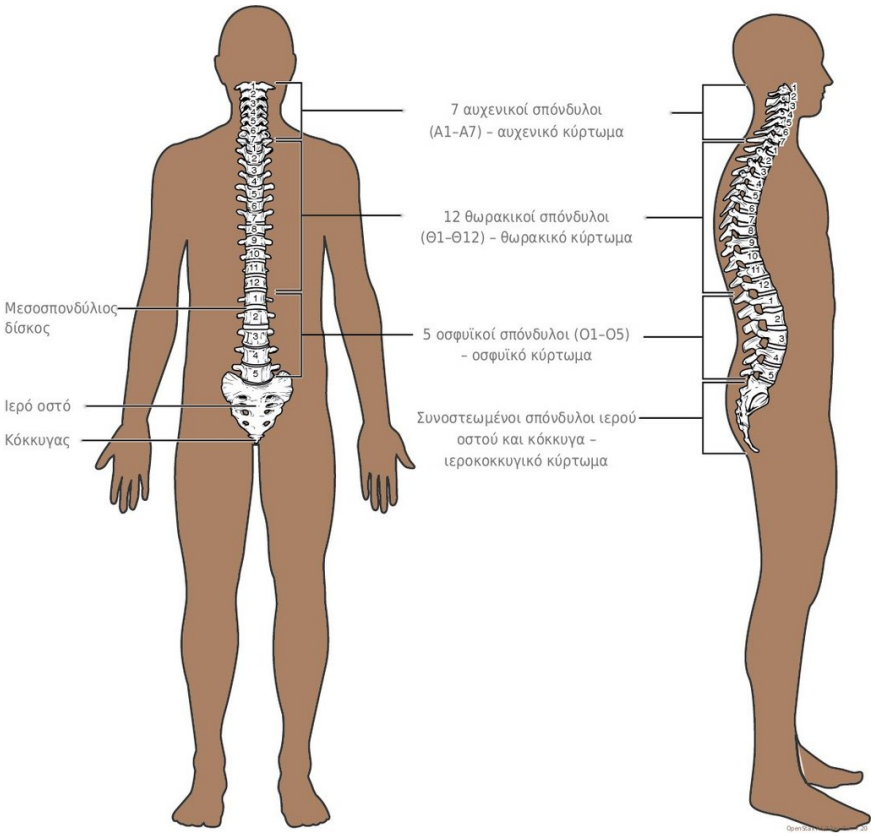
Ποια δομή προστατεύεται μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα;

Ο νωτιαίος μυελός.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η αυχενική μοίρα περιλαμβάνει 7 σπονδύλους, η θωρακική 12 και η οσφυϊκή 5. Ο νωτιαίος μυελός μεταφέρει κινητικές και αισθητικές οδούς· οι ρίζες των νωτιαίων νεύρων νευρώνουν συγκεκριμένες περιοχές. Μια κάκωση μπορεί να συνδυάζει οστική βλάβη και νευρολογικό έλλειμμα χωρίς το ένα να είναι πάντοτε ορατό. Ακολουθούμε την τεκμηριωμένη εκτίμηση και τις κατά τόπο διαδικασίες διακομιδής, όχι αυθαίρετη ακινητοποίηση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Σπονδυλική στήλη. Αυχενικό, θωρακικό, οσφυϊκό και ιεροκοκκυγικό τμήμα, κυρτώσεις, μεσοσπονδύλιοι δίσκοι.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/7-3-the-vertebral-column.

01.08 — Κρανίο, εγκέφαλος και μήνιγγες

Το κρανίο περιλαμβάνει οστά που σχηματίζουν τον εγκεφαλικό θόλο και το προσωπικό κρανίο. Ο εγκεφαλικός θόλος προστατεύει τον εγκέφαλο. Η κάτω γνάθος είναι κινητό οστό του προσώπου, ενώ ο ινιακός οστέινος σχηματισμός βρίσκεται πίσω και κάτω στον θόλο.

SOS · Το κρανίο προστατεύει τον εγκέφαλο· οι τρεις μήνιγγες είναι σκληρά, αραχνοειδής και χοριοειδής.

Θεωρία & κατανόηση

Οι μήνιγγες είναι τρεις υμένες: σκληρά, αραχνοειδής και χοριοειδής. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό συμβάλλει στη μηχανική προστασία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η αναγνώριση κρανιοπροσωπικών δομών βοηθά στην περιγραφή τραύματος, όχι στην αυτόνομη διάγνωση ενδοκράνιας βλάβης.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Οι τρεις μήνιγγες είναι σκληρά, αραχνοειδής, χοριοειδής.

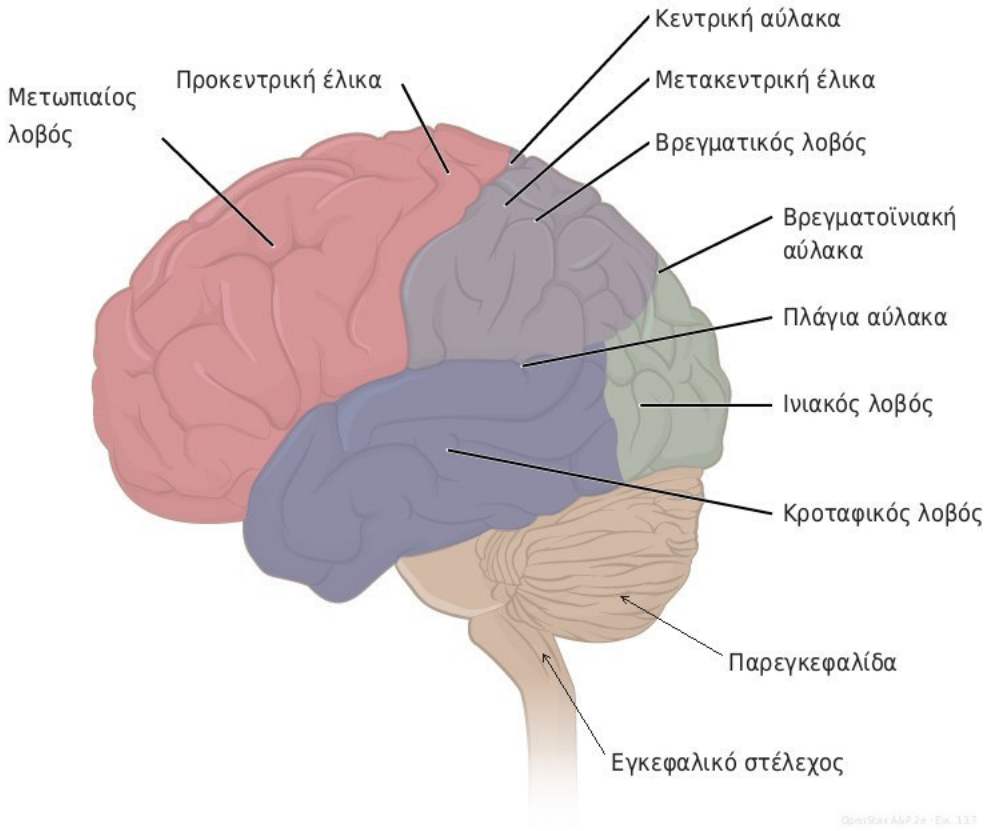
Ποια δομή εντοπίζεται γύρω από τον εγκέφαλο κάτω από τα οστά;

Οι μήνιγγες.

Σε βάθος — επεξήγηση

Ο εγκέφαλος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, την παρεγκεφαλίδα και το εγκεφαλικό στέλεχος. Η παρεγκεφαλίδα συμβάλλει στον συντονισμό, ενώ το εγκεφαλικό στέλεχος σε βασικές λειτουργίες ζωής. Οι μήνιγγες προστατεύουν το ΚΝΣ και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί σε ειδικούς χώρους. Αλλαγές στην εγρήγορση μετά από τραύμα απαιτούν επείγουσα εκτίμηση ακόμη και χωρίς εμφανές κάταγμα κρανίου.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Λοβοί του εγκεφαλικού φλοιού. Μετωπιαίος, βρεγματικός, ινιακός, κροταφικός λοβός, αύλακες και παρεγκεφαλίδα.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/13-2-the-central-nervous-system.

01.09 — Αρθρώσεις, σύνδεσμοι και μύες

Οι αρθρώσεις συνδέουν τα οστά και επιτρέπουν από μικρή έως μεγάλη κινητικότητα, ανάλογα με τον τύπο τους. Οι σύνδεσμοι σταθεροποιούν μια άρθρωση συνδέοντας οστά, ενώ οι τένοντες συνδέουν μύες με οστά. Η άρθρωση του ώμου είναι ιδιαίτερα κινητή, ενώ η άρθρωση του ισχίου συνδυάζει κινητικότητα και σταθερότητα.

SOS · Τένοντας = μυς προς οστό· σύνδεσμος = οστό προς οστό· άρθρωση συνδέει οστά.

Θεωρία & κατανόηση

Οι σκελετικοί μύες συσπώνται υπό εκούσιο έλεγχο και προκαλούν κίνηση. Οι λείοι μύες βρίσκονται στα τοιχώματα σπλάχνων και αγγείων, ενώ το μυοκάρδιο αποτελεί εξειδικευμένο μυϊκό ιστό της καρδιάς. Μια

κάκωση άρθρωσης περιγράφεται με θέση, παραμόρφωση, κινητικότητα, πόνο και περιφερικά νευροαγγειακά ευρήματα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ο σύνδεσμος συνδέει οστά· ο τένοντας συνδέει μυ με οστό.

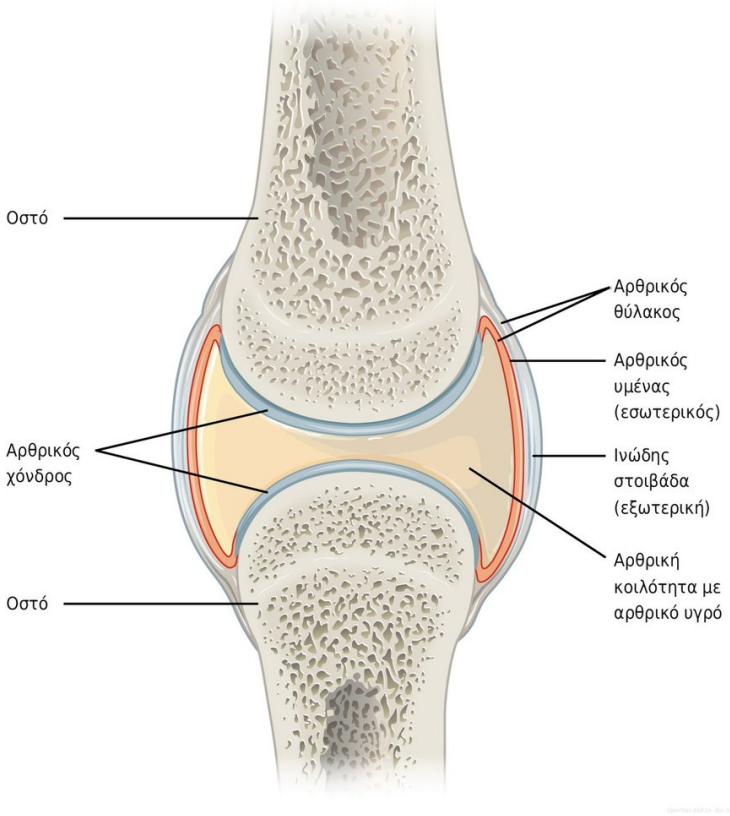
Πώς διαφέρουν ο τένοντας και ο σύνδεσμος;

Ο τένοντας συνδέει μυ με οστό και ο σύνδεσμος συνδέει οστό με οστό.

Σε βάθος — επεξήγηση

Μια διάρθρωση έχει αρθρικές επιφάνειες, θύλακο και συχνά αρθρικό υγρό, επιτρέποντας ομαλή κίνηση. Οι σύνδεσμοι σταθεροποιούν οστό με οστό και οι τένοντες μεταφέρουν τη δύναμη μυός προς οστό. Ο σκελετικός μυς αποτελείται από ίνες που συσπώνται χάρη στην αλληλεπίδραση ακτίνης και μυοσίνης. Μετά από τραυματισμό καταγράφουμε ανώμαλη θέση, οίδημα και νευροαγγειακή εικόνα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Αρθρώσεις με αρθρική κοιλότητα. Αρθρικός θύλακας, αρθρικός υμένας, αρθρικός χόνδρος, αρθρική κοιλότητα.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/9-4-synovial-joints.

01.10 — Καρδιά, μεγάλα αγγεία και βαλβίδες

Η καρδιά έχει τέσσερις κοιλότητες: δύο κόλπους και δύο κοιλίες. Το αίμα από το σώμα επιστρέφει στον δεξιό κόλπο, περνά στη δεξιά κοιλία και κατευθύνεται προς τους πνεύμονες. Από τους πνεύμονες επιστρέφει στον αριστερό κόλπο, περνά στην αριστερή κοιλία και εξωθείται στην αορτή.

SOS · Ροή: δεξιά καρδιά → πνεύμονες → αριστερή καρδιά → αορτή → σώμα· οι βαλβίδες περιορίζουν την παλινδρόμηση.

Θεωρία & κατανόηση

Οι καρδιακές βαλβίδες διατηρούν τη ροή προς μία κατεύθυνση: τριγλώχινα, πνευμονική, μιτροειδής και αορτική. Τα στεφανιαία αγγεία τροφοδοτούν τον καρδιακό μυ. Η γνώση της πορείας του αίματος εξηγεί γιατί μια διαταραχή καρδιακής αντλίας επηρεάζει την αιμάτωση όλων των οργάνων.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Τριγλώχινα δεξιά, μιτροειδής αριστερά, αορτική και πνευμονική στην έξοδο των κοιλιών.

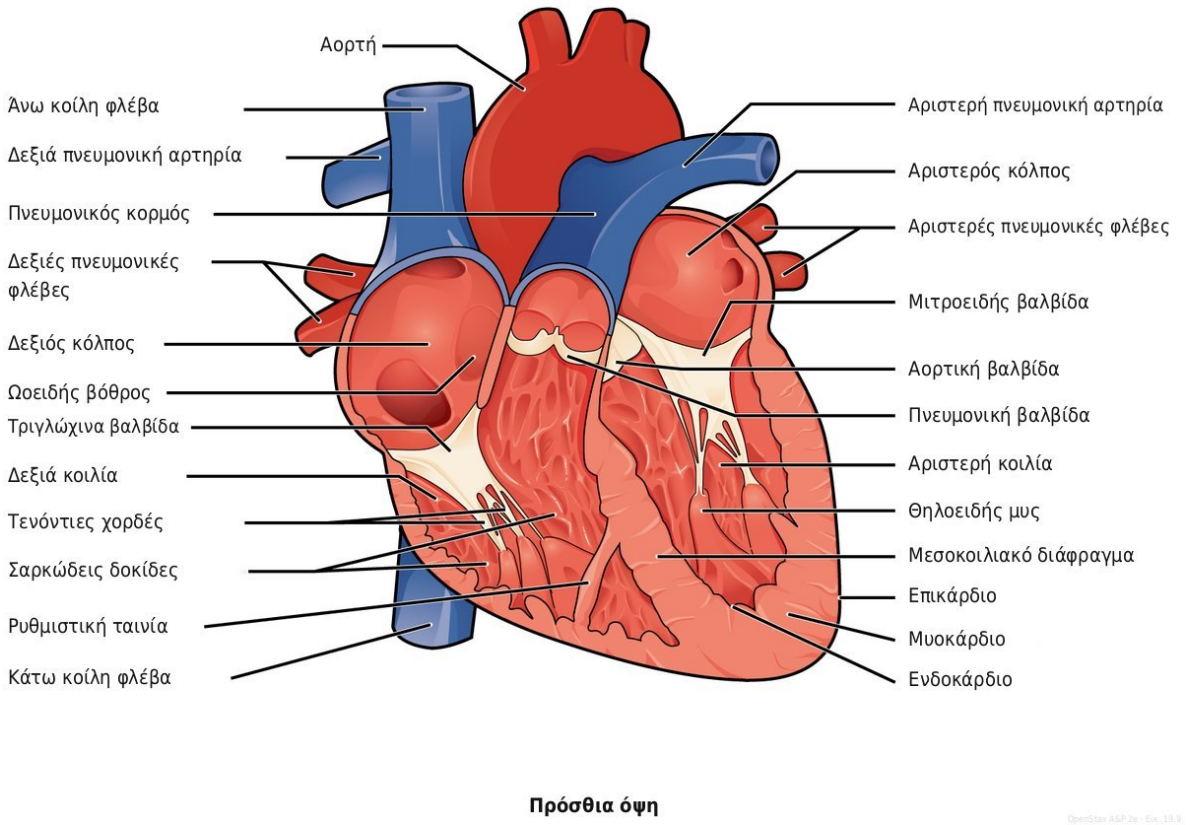
Από ποια κοιλία εκφύεται η αορτή;

Από την αριστερή κοιλία.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η δεξιά καρδιά στέλνει αίμα στη μικρή κυκλοφορία και η αριστερή στη συστηματική κυκλοφορία. Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ αριστερού κόλπου και κοιλίας, η τριγλώχινα δεξιά. Οι στεφανιαίες αρτηρίες αιματώνουν το μυοκάρδιο. Η αορτή είναι το κύριο αρτηριακό αγγείο της συστηματικής κυκλοφορίας. Μια διαταραχή στεφανιαίας ροής μπορεί να προκαλέσει ισχαιμία ακόμη και χωρίς αρχικά εμφανείς εξωτερικές βλάβες.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Πρόσθια όψη

Εικόνα: Εσωτερικές δομές της καρδιάς. Κόλποι, κοιλίες, βαλβίδες, τενόντιες χορδές, μεσοκοιλιακό διάφραγμα, τοιχώματα.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/19-1-heart-anatomy.

01.11 — Ανώτεροι και κατώτεροι αεραγωγοί

Η μύτη και η στοματική κοιλότητα οδηγούν στον φάρυγγα. Ο λάρυγγας συνδέει τον φάρυγγα με την τραχεία και περιλαμβάνει τις φωνητικές χορδές. Η τραχεία διακλαδίζεται σε δύο κύριους βρόγχους που

κατευθύνονται στους πνεύμονες.

SOS · Διαδρομή αέρα: μύτη/στόμα → φάρυγγας → λάρυγγας → τραχεία → βρόγχοι → κυψελίδες.

Θεωρία & κατανόηση

Οι βρόγχοι διακλαδίζονται σε μικρότερους βρόγχους και βρογχιόλια. Οι πνευμονικές κυψελίδες παρέχουν μεγάλη επιφάνεια ανταλλαγής αερίων. Στην εκτίμηση ασθενούς είναι σημαντική η διάκριση μεταξύ ανοιχτού ανατομικά αεραγωγού, αποτελεσματικού αερισμού και επαρκούς οξυγόνωσης.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Αεραγωγός → τραχεία → βρόγχοι → βρογχιόλια → κυψελίδες.

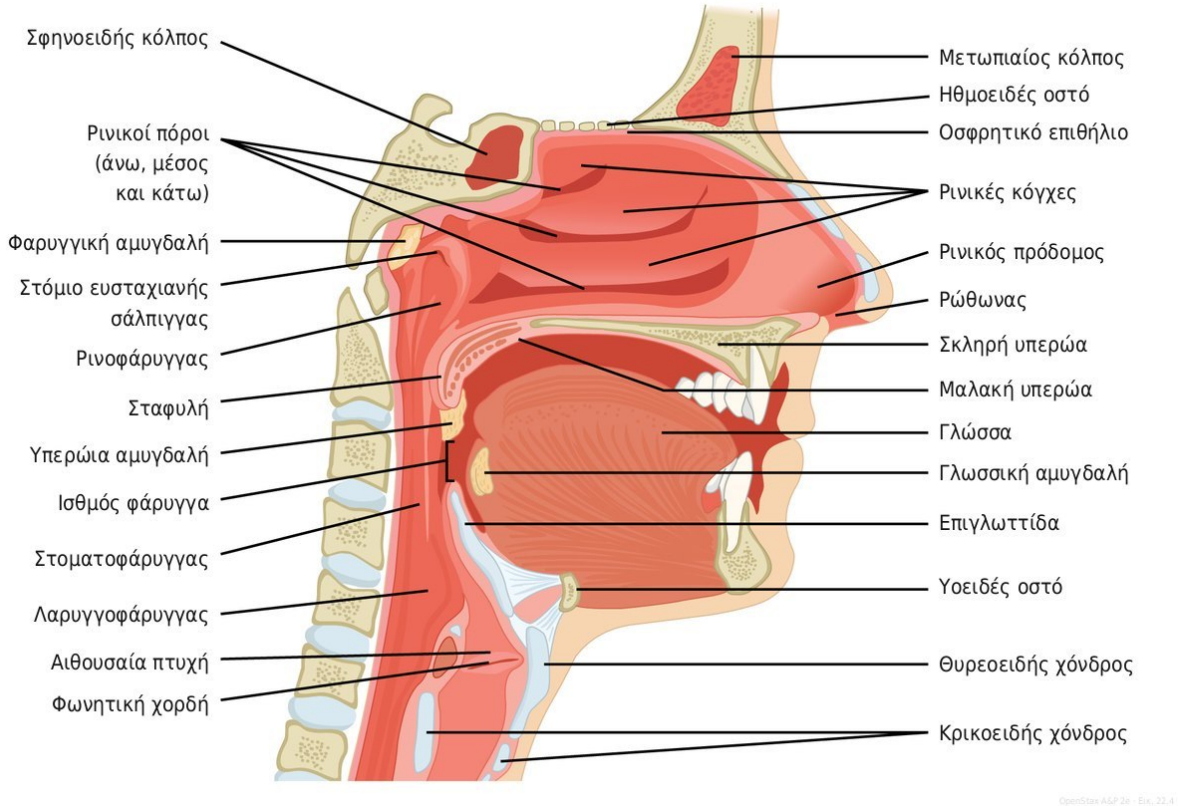
Πού πραγματοποιείται η ανταλλαγή αερίων με τα πνευμονικά τριχοειδή;

Στις κυψελίδες.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η επιγλωττίδα συμμετέχει στην προστασία της εισόδου του λάρυγγα κατά την κατάποση. Η τραχεία υποστηρίζεται από χόνδρινους δακτυλίους και διχάζεται σε δεξιό και αριστερό κύριο βρόγχο. Οι κυψελίδες είναι ο τόπος ανταλλαγής αερίων με τα τριχοειδή. Ο ανοιχτός αεραγωγός, ο επαρκής αερισμός και η σωστή ανταλλαγή αερίων είναι τρεις διαφορετικές έννοιες που αξιολογούνται μαζί.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Ανώτεροι αεραγωγοί. Ρινική κοιλότητα, ρινοφάρυγγας, στοματοφάρυγγας, λαρυγγοφάρυγγας, επιγλωττίδα, λάρυγγας.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/22-1-organs-and-structures-of-the-respiratory-system.

01.12 — Πεπτικό σύστημα και αδένες

Το πεπτικό σύστημα περιλαμβάνει στόμα, φάρυγγα, οισοφάγο, στομάχι, λεπτό και παχύ έντερο, ορθό και πρωκτό. Η διάσπαση της τροφής αρχίζει στο στόμα και συνεχίζεται στο στομάχι και στο λεπτό έντερο. Το λεπτό έντερο είναι σημαντικός τόπος απορρόφησης θρεπτικών ουσιών.

SOS · Λεπτό έντερο: κύρια απορρόφηση θρεπτικών· ήπαρ: χολή· πάγκρεας: πεπτικά ένζυμα και ορμόνες.

Θεωρία & κατανόηση

Το ήπαρ επεξεργάζεται θρεπτικά συστατικά και παράγει χολή. Η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει και συμπυκνώνει χολή, ενώ το πάγκρεας έχει εξωκρινή πεπτική και ενδοκρινή ορμονική λειτουργία. Η ανατομία αυτών των οργάνων βοηθά στην περιγραφή κοιλιακών συμπτωμάτων χωρίς πρόωρο συμπέρασμα για την αιτία τους.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ήπαρ: χολή· πάγκρεας: πεπτικά ένζυμα και ορμόνες.

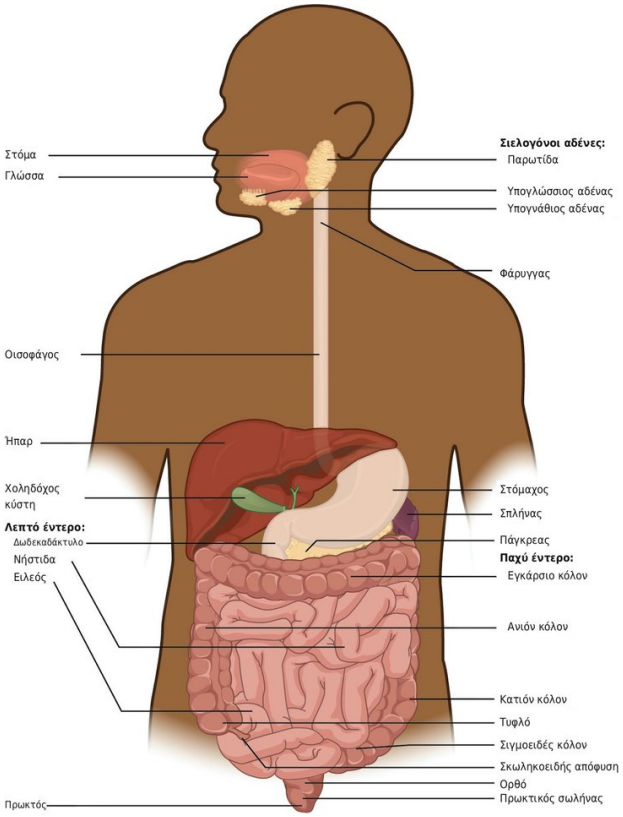
Ποιο όργανο παράγει τη χολή;

Το ήπαρ παράγει τη χολή. Η χοληδόχος κύστη την αποθηκεύει και τη συμπυκνώνει, ενώ η χολή βοηθά στην πέψη και απορρόφηση των λιπών στο λεπτό έντερο.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η πέψη περιλαμβάνει μηχανική επεξεργασία, διάσπαση σύνθετων ουσιών και απορρόφηση. Η χολή συμβάλλει στη γαλακτωματοποίηση λιπών, ενώ τα παγκρεατικά ένζυμα στη διάσπαση τροφών. Το λεπτό έντερο είναι κύριος τόπος απορρόφησης και το παχύ έντερο συμβάλλει στην ανάκτηση νερού. Η γνώση αυτών των θέσεων βοηθά να περιγράφουμε εμετό, αιμορραγία και κοιλιακό πόνο χωρίς να υποκαθιστούμε ιατρική διάγνωση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Συστατικά του πεπτικού συστήματος. Στόμα έως πρωκτός, σιελογόνοι αδένες, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, πάγκρεας.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/23-1-overview-of-the-digestive-system.

01.13 — Ουροποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα

Οι νεφροί παράγουν ούρα, τα οποία περνούν από τους ουρητήρες στην ουροδόχο κύστη και αποβάλλονται από την ουρήθρα. Βασικές δομές του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος: όρχεις, επιδιδυμίδες, σπερματικοί πόροι, προστάτης και πέος. Του γυναικείου: ωοθήκες, σάλπιγγες, μήτρα, τράχηλος και κόλπος.

SOS · Ουροποιητικό: νεφροί → ουρητήρες → κύστη → ουρήθρα. Αναπαραγωγικό: όρχεις/σπερματικοί πόροι και ωοθήκες/σάλπιγγες/μήτρα.

Θεωρία & κατανόηση

Το ουροποιητικό συμμετέχει στη ρύθμιση υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Τα αναπαραγωγικά όργανα περιλαμβάνουν διαφορετικές δομές ανά φύλο. Για τον διασώστη, η ανατομική γνώση εξασφαλίζει ακριβή περιγραφή συμπτωμάτων με σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Νεφρός → ουρητήρας → ουροδόχος κύστη → ουρήθρα.

Ποια δομή μεταφέρει το ούρο από τον νεφρό στην κύστη;

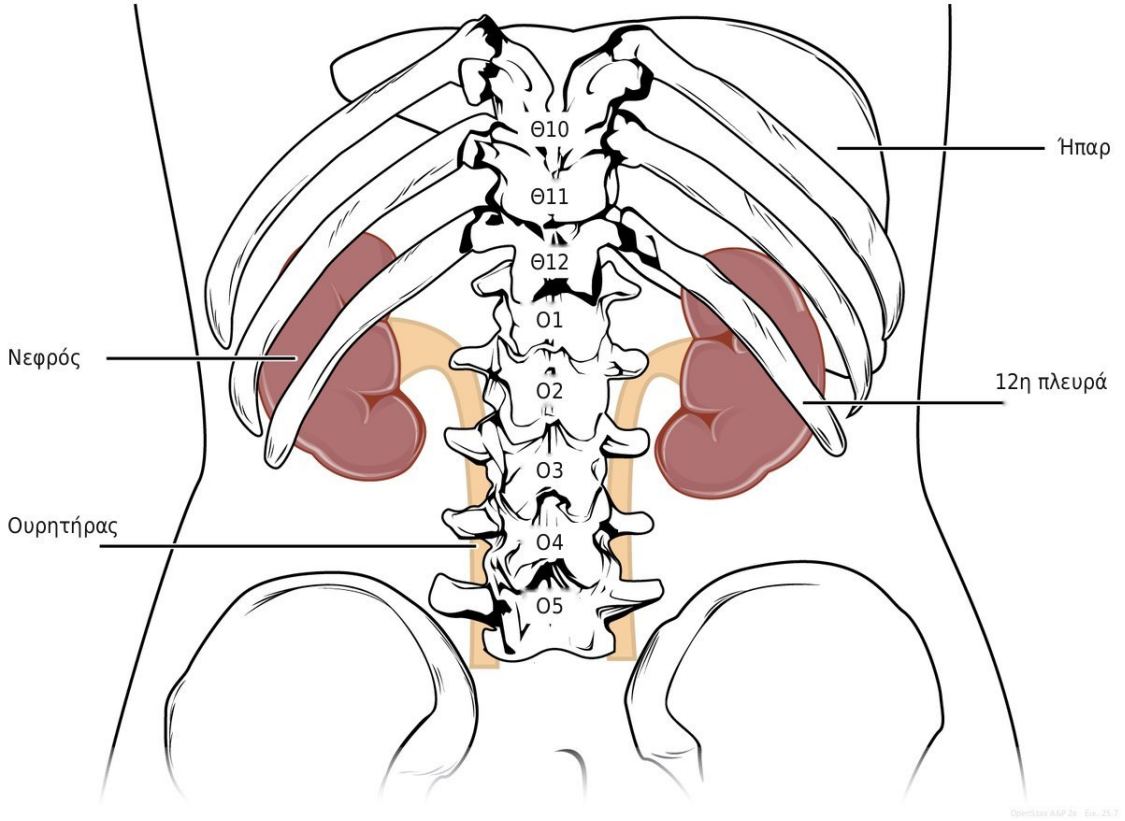
Ο ουρητήρας.

Σε βάθος — επεξήγηση

Στον νεφρώνα πραγματοποιούνται διήθηση, επαναρρόφηση και έκκριση. Έτσι οι νεφροί επηρεάζουν το ισοζύγιο υγρών, την αρτηριακή πίεση και το pH. Οι ουρητήρες μεταφέρουν ούρα στην κύστη, ενώ η ουρήθρα τα αποβάλλει. Το αναπαραγωγικό σύστημα έχει διαφορετικά όργανα και λειτουργίες από το

ουροποιητικό, παρά τη στενή ανατομική συνάφεια. Ιδιωτικότητα και διακριτικότητα είναι απαραίτητες στην εκτίμηση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Νεφροί και ουρητήρες. Θέση νεφρών ως προς τους σπονδύλους Θ10–Ο5, 12η πλευρά, ήπαρ, ουρητήρας.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/25-3-gross-anatomy-of-the-kidney.

01.14 — Ανατομικοί χώροι και τεταρτημόρια κοιλιάς

Η κοιλιά χωρίζεται πρακτικά σε τέσσερα τεταρτημόρια με νοητές κάθετες και οριζόντιες γραμμές στον ομφαλό. Επιπλέον χρησιμοποιούνται εννέα ανατομικές περιοχές για λεπτομερέστερη περιγραφή. Οι όροι δεξιό και αριστερό αφορούν πάντοτε την πλευρά του ασθενούς.

SOS · Τα τεταρτημόρια κοιλιάς ορίζονται από γραμμές στον ομφαλό· δεξιά/αριστερά = πλευρά του ασθενούς.

Θεωρία & κατανόηση

Ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος βρίσκεται πίσω από το περιτόναιο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους νεφρούς. Η κοιλιακή κοιλότητα περιέχει μεγάλα αγγεία και πολλά σπλάχνα. Ο ακριβής εντοπισμός του πόνου καταγράφεται μαζί με χρόνο έναρξης, συνοδά συμπτώματα και ζωτικά σημεία.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Δεξιά/αριστερά αναφέρονται στην πλευρά του ίδιου του ασθενούς.

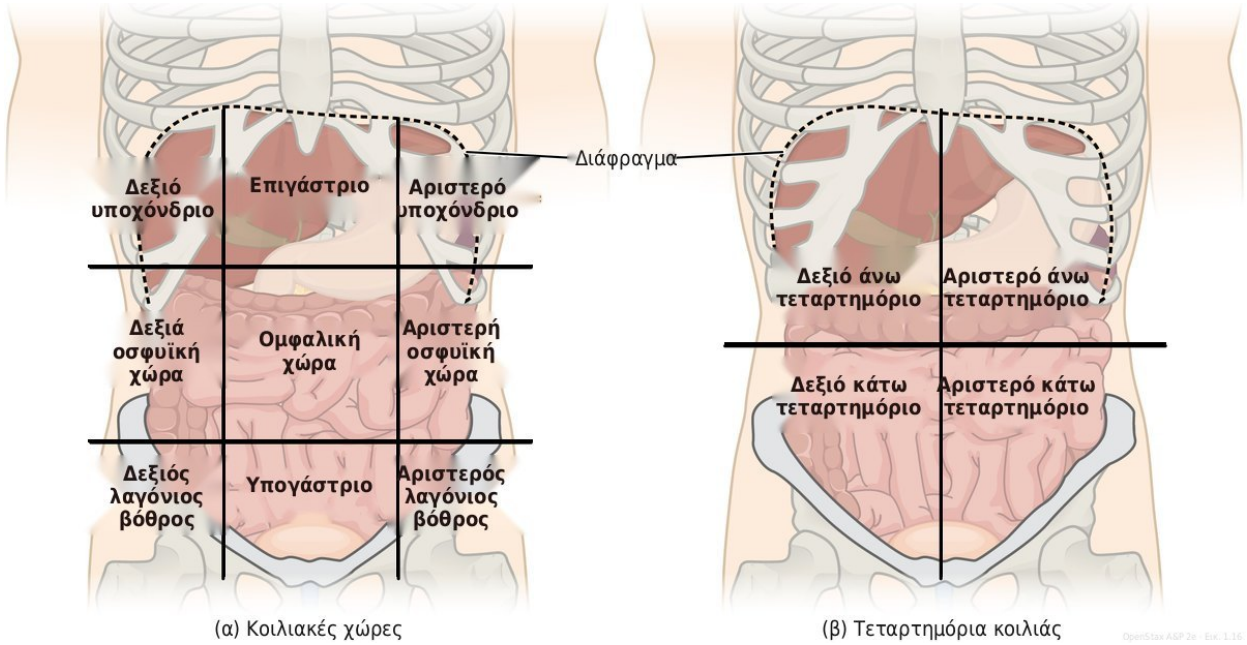
Σε ποια πλευρά του ασθενούς βρίσκεται κυρίως ο σπλήνας;

Αριστερά, στο άνω μέρος της κοιλιάς.

Σε βάθος — επεξήγηση

Στα τέσσερα τεταρτημόρια του κοιλιακού χώρου περιγράφουμε τη θέση αναφερόμενων ενοχλημάτων: δεξιό/αριστερό και άνω/κάτω. Στις εννέα περιοχές ονοματίζουμε μεταξύ άλλων επιγάστριο, ομφαλική και υπογάστριο. Ο πόνος από οπισθοπεριτοναϊκές δομές μπορεί να εντοπίζεται στη ράχη ή στα πλάγια. Η ανατομική περιγραφή συνδυάζεται με μηχανισμό κάκωσης, συνοδά σημεία και εξέλιξη συμπτωμάτων.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Χώρες και τεταρτημόρια της κοιλιάς. Εννέα κοιλιακές χώρες και τέσσερα τεταρτημόρια.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-6-anatomical-terminology.

02 · Φυσιολογία

02.01 — Ομοιόσταση και ανατροφοδότηση

Ομοιόσταση είναι η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σχετικά σταθερές εσωτερικές συνθήκες, παρά τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Θερμοκρασία σώματος, γλυκόζη, οξεοβασική ισορροπία και αρτηριακή πίεση ρυθμίζονται από αλληλεπιδρώντες μηχανισμούς. Στην αρνητική ανατροφοδότηση, η απόκλιση ενεργοποιεί διαδικασίες που τείνουν να την αντιστρέψουν. Η διαταραχή της ομοιόστασης βρίσκεται πίσω από πολλές επείγουσες καταστάσεις.

SOS · Ομοιόσταση = διατήρηση εσωτερικής ισορροπίας, κυρίως με αρνητική ανατροφοδότηση.

Αναλυτική κατανόηση

Η ομοιόσταση είναι η διατήρηση εσωτερικών μεταβλητών σε λειτουργικά όρια παρά τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Σε μηχανισμό αρνητικής ανατροφοδότησης ένας αισθητήρας ανιχνεύει απόκλιση, ένα κέντρο ελέγχου τη συγκρίνει με τη ρύθμιση και ένα εκτελεστικό όργανο μειώνει την απόκλιση. Παραδείγματα αποτελούν η θερμορρύθμιση και η ρύθμιση της γλυκόζης. Η θετική ανατροφοδότηση ενισχύει ένα ερέθισμα και χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες διαδικασίες όπως ο τοκετός.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Ο διασώστης παρατηρεί τι σημαίνει διαταραχή ομοιόστασης μέσα από μεταβολές σε συνείδηση, αναπνοή, σφύξεις, θερμοκρασία και αιμάτωση.

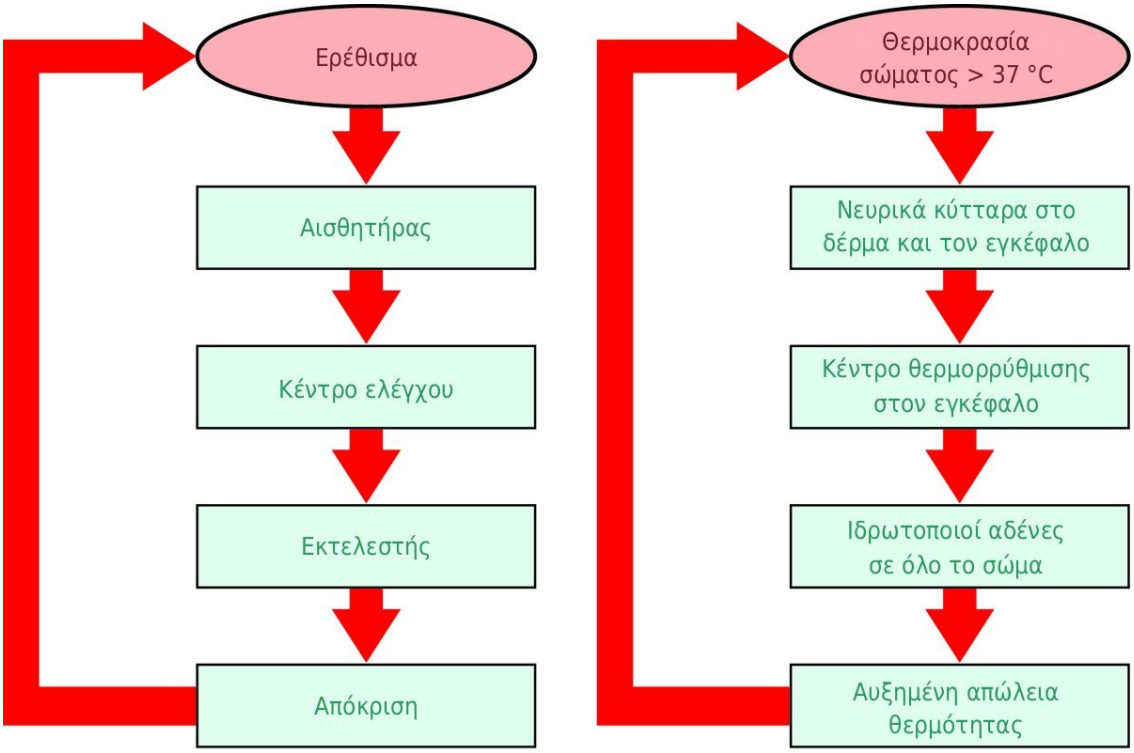
Τι κάνει η αρνητική ανατροφοδότηση;

Αντισταθμίζει μια απόκλιση για να επαναφέρει μια παράμετρο προς το φυσιολογικό λειτουργικό εύρος.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η ομοιόσταση είναι δυναμική, όχι απόλυτα ακίνητη ισορροπία. Θερμοϋποδοχείς, εγκέφαλος, ορμόνες, νεφροί και καρδιαγγειακό σύστημα συνεργάζονται για να διατηρείται κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον. Στην αρνητική ανατροφοδότηση η απάντηση μειώνει τη μεταβολή που τη δημιούργησε. Στην κλινική πράξη μία μεμονωμένη τιμή μπορεί να φαίνεται ανεκτή, ενώ η επιδείνωση με την πάροδο του χρόνου έχει μεγάλη σημασία.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



(α) Βρόχος αρνητικής ανατροφοδότησης (β) Ρύθμιση θερμοκρασίας σώματος

Εικόνα: Αρνητική ανατροφοδότηση. Βρόχος αρνητικής ανατροφοδότησης και παράδειγμα ρύθμισης θερμοκρασίας σώματος.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-5-homeostasis.

02.02 — Φυσιολογία της αναπνοής

Με την εισπνοή το διάφραγμα συσπάται και η θωρακική κοιλότητα διευρύνεται. Στις κυψελίδες γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα με το αίμα. Ο αερισμός αφορά τη μετακίνηση του αέρα, ενώ η οξυγόνωση την είσοδο οξυγόνου στο αίμα· δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Η συχνότητα, το βάθος και η αποτελεσματικότητα της αναπνοής αξιολογούνται μαζί με την κλινική εικόνα, όχι μόνο με ένα οξύμετρο.

SOS · Αερισμός = μετακίνηση αέρα· οξυγόνωση = πρόσληψη O_2· η ανταλλαγή αερίων γίνεται στις κυψελίδες.

Αναλυτική κατανόηση

Ο αερισμός μετακινεί αέρα στους πνεύμονες, η διάχυση επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη και η αιμάτωση μεταφέρει αίμα στα πνευμονικά τριχοειδή. Η μεταφορά οξυγόνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αιμοσφαιρίνη. Κορεσμός SpO_2, συχνότητα αναπνοών και αναπνευστικό έργο περιγράφουν διαφορετικές πλευρές της κατάστασης και δεν πρέπει να εκτιμώνται μεμονωμένα.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Ένας φυσιολογικός αριθμός στο οξύμετρο δεν αποκλείει σοβαρή υποαεριστική διαταραχή ή επαπειλούμενη εξάντληση. Παρατήρησε πάντα συχνότητα, βάθος, συμμετρία και επίπεδο συνείδησης.

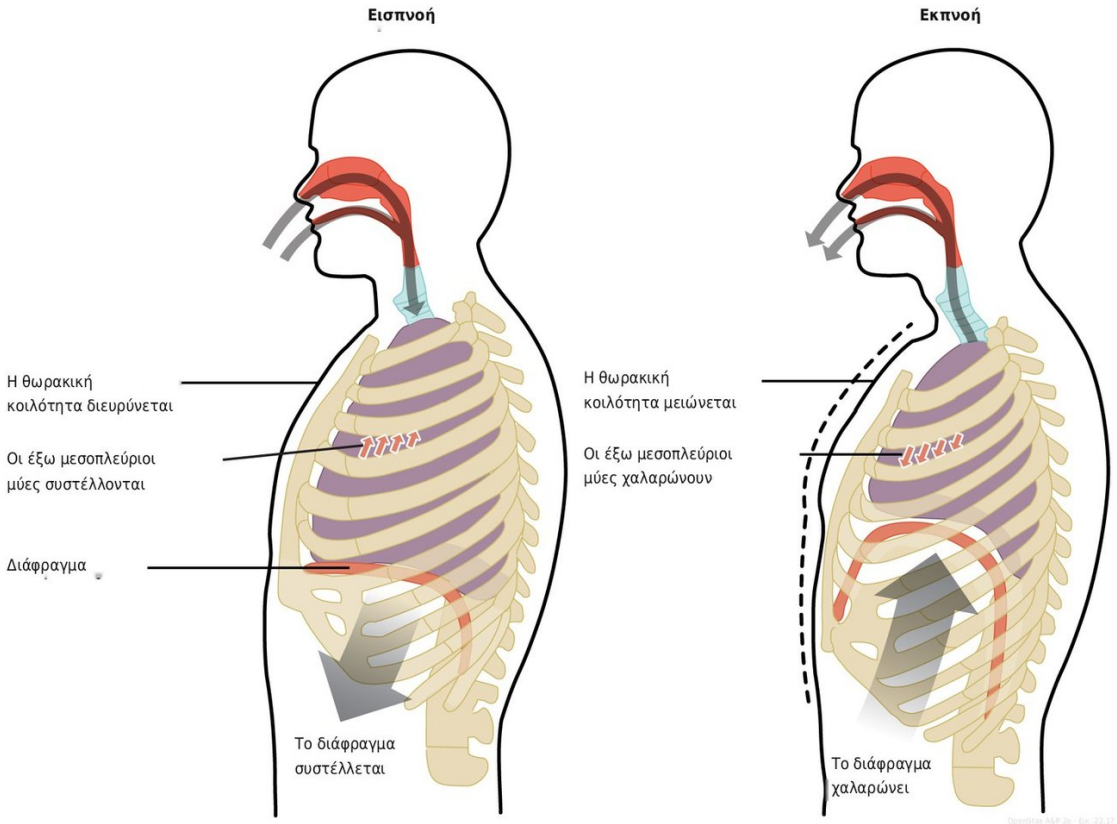
Ποια είναι η διαφορά αερισμού και οξυγόνωσης;

Αερισμός = μετακίνηση αέρα και αποβολή CO_2· οξυγόνωση = είσοδος/μεταφορά O_2 στο αίμα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Ο αερισμός είναι η είσοδος και έξοδος αέρα· η διάχυση είναι η μετακίνηση αερίων μεταξύ κυψελίδων και αίματος. Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου. Η αναπνευστική συχνότητα από μόνη της δεν αποδεικνύει επαρκή ανταλλαγή αερίων: αξιολογούμε βάθος αναπνοής, έργο αναπνοής, επίπεδο συνείδησης και άλλες ενδείξεις. Η φυσιολογία βοηθά στην κατανόηση της επιδείνωσης.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Εισπνοή και εκπνοή. Κίνηση διαφράγματος και μεσοπλεύριων μυών, μεταβολή όγκου θωρακικής κοιλότητας.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/22-3-the-process-of-breathing.

02.03 — Κυκλοφορία και αιμάτωση

Η καρδιά ωθεί το αίμα μέσα από δύο κυκλοφορίες: τη συστηματική και την πνευμονική. Η καρδιακή παροχή εξαρτάται από την καρδιακή συχνότητα και τον όγκο παλμού. Αιμάτωση είναι η παροχή αίματος στους ιστούς, ώστε να λαμβάνουν οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία. Σημεία ανεπαρκούς αιμάτωσης μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολή της συνείδησης, ψυχρό δέρμα και διαταραχές σφυγμού.

SOS · Καρδιακή παροχή = συχνότητα × όγκος παλμού· αιμάτωση = παροχή αίματος και O_2 στους ιστούς.

Αναλυτική κατανόηση

Η καρδιακή παροχή εξαρτάται από τη συχνότητα και τον όγκο παλμού. Η αρτηριακή πίεση σχετίζεται τόσο με την καρδιακή παροχή όσο και με την περιφερική αγγειακή αντίσταση. Η μικροκυκλοφορία στα τριχοειδή είναι το σημείο ανταλλαγής οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών. Η έγκαιρη αναγνώριση ανεπαρκούς αιμάτωσης βασίζεται σε συνδυασμό ενδείξεων, π.χ. συνείδηση, δέρμα, σφύξεις και πίεση.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Μια μεμονωμένη αρτηριακή πίεση δεν αρκεί για να αποκλείσει shock· εντόπισε τάσεις και συνδυασμό ευρημάτων.

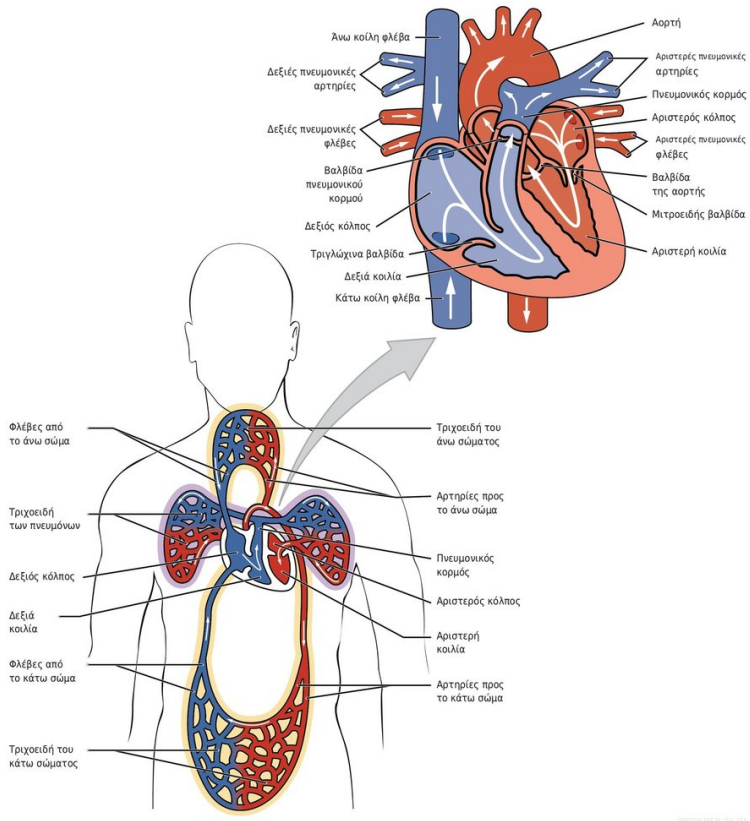
Από τι προκύπτει η καρδιακή παροχή;

Από τη συχνότητα των παλμών επί τον όγκο παλμού.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η καρδιακή παροχή εξαρτάται από τη συχνότητα και τον όγκο παλμού, αλλά η αποτελεσματική αιμάτωση επηρεάζεται και από τον αγγειακό τόνο και την κατάσταση της μικροκυκλοφορίας. Ο σφυγμός περιγράφεται ως προς συχνότητα, ρυθμό και ποιότητα. Διαφορετικοί μηχανισμοί μπορούν να προκαλέσουν ανεπαρκή ιστική άρδευση, γι’ αυτό εξετάζονται περισσότερες από μία παράμετροι και η τάση μεταβολής τους.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία. Διπλό κυκλοφορικό σύστημα και εσωτερική ανατομία της καρδιάς.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/19-1-heart-anatomy.

02.04 — Νευρική ρύθμιση και μεταβολισμός

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει ακούσιες λειτουργίες, όπως καρδιακή συχνότητα και αγγειακό τόνο. Ο μεταβολισμός χρησιμοποιεί θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή ενέργειας. Η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη συμβάλλουν στη ρύθμιση της γλυκόζης. Η φυσιολογία συνδέεται άμεσα με την κατανόηση διαταραχών συνείδησης, υπογλυκαιμίας και stress.

SOS · Αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει ακούσιες λειτουργίες· ινσουλίνη μειώνει και γλυκαγόνη αυξάνει τη γλυκόζη.

Αναλυτική κατανόηση

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα συντονίζει πολλές ακούσιες λειτουργίες όπως καρδιακή συχνότητα και αγγειακό τόνο. Το συμπαθητικό συνήθως προάγει την απάντηση σε καταπόνηση, ενώ το παρασυμπαθητικό συμβάλλει σε λειτουργίες ανάπαυσης. Η αερόβια παραγωγή ενέργειας απαιτεί οξυγόνο και κατάλληλα υποστρώματα, ενώ η αναερόβια γλυκόλυση μπορεί να παράγει μικρότερη ποσότητα ATP χωρίς άμεση χρήση οξυγόνου. Ο εγκέφαλος εξαρτάται από συνεχή επαρκή παροχή αίματος, οξυγόνου και γλυκόζης. Διαταραχές γλυκόζης, οξυγόνωσης ή αιμάτωσης μπορούν να εκδηλωθούν με αλλαγή συμπεριφοράς ή συνείδησης.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Στη διαταραχή συνείδησης σκέψου πρώτα αναστρέψιμες αιτίες κατά την καθιερωμένη πρωτογενή εκτίμηση, χωρίς να παραλείπεις επικίνδυνες άλλες αιτίες.

Πηγή: NCBI Bookshelf · Αναερόβια γλυκόλυση ↗ (εκπαιδευτική επισήμανση).

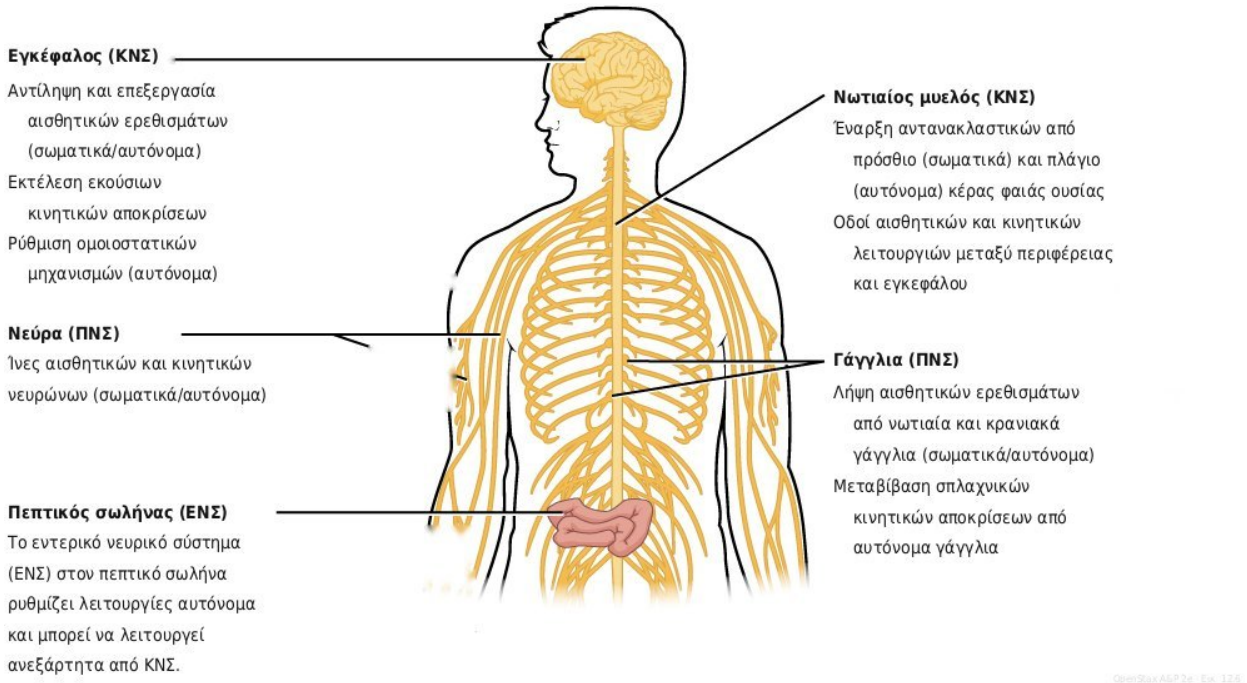
Ποιο σύστημα συμμετέχει στη ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας χωρίς συνειδητό έλεγχο;

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό, την κινητικότητα του γαστρεντερικού και τον τόνο των αγγείων. Οι ορμόνες δρουν ως χημικά σήματα μεταξύ οργάνων, ενώ ο μεταβολισμός περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Μια οξεία ασθένεια μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα νευρική λειτουργία, γλυκόζη και κυκλοφορία, δείχνοντας τη σύνδεση των συστημάτων.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Σωματικό, αυτόνομο και εντερικό νευρικό σύστημα. Ρόλοι εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, νεύρων, γαγγλίων και εντερικού νευρικού συστήματος.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-1-basic-structure-and-function-of-the-nervous-system.

02.05 — Μεμβράνες και μεταφορά ουσιών

Η κυτταρική μεμβράνη είναι επιλεκτικός φραγμός που επιτρέπει διαφορετικά την κίνηση νερού, ιόντων και άλλων μορίων. Με διάχυση τα σωματίδια μετακινούνται κατά μήκος διαφοράς συγκέντρωσης, ενώ στην ώσμωση μετακινείται κυρίως νερό μέσω ημιπερατού φραγμού.

SOS · Διάχυση: μετακίνηση κατά τη βαθμίδα συγκέντρωσης· ώσμωση: μετακίνηση νερού μέσα από ημιπερατή μεμβράνη.

Θεωρία & κατανόηση

Η ενεργός μεταφορά απαιτεί ενέργεια για να μετακινεί ουσίες ενάντια στις βαθμίδες τους. Η ισορροπία υγρών μεταξύ ενδοκυττάριου, διάμεσου και ενδαγγειακού χώρου επηρεάζει την κυκλοφορία και τη λειτουργία των κυττάρων.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Διάχυση: κίνηση κατά βαθμίδα· ενεργός μεταφορά: χρειάζεται ενέργεια.

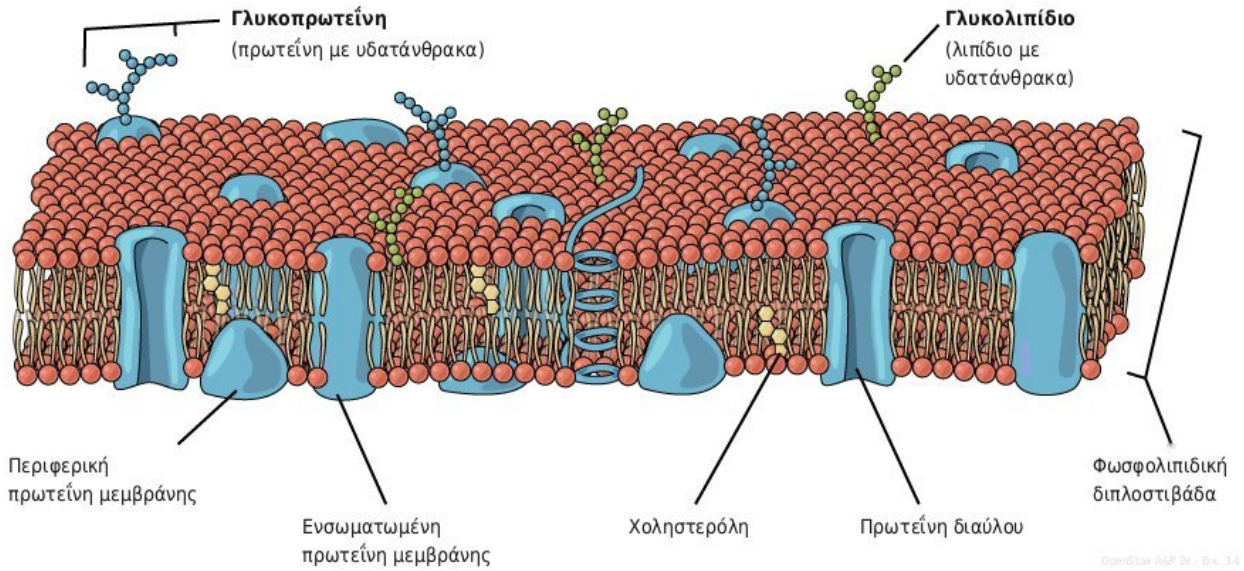
Τι είναι η ώσμωση;

Η μετακίνηση νερού μέσω ημιπερατής μεμβράνης ως αποτέλεσμα διαφοράς συγκέντρωσης διαλυτών ουσιών.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η παθητική διάχυση δεν απαιτεί άμεση κατανάλωση ενέργειας, ενώ η ενεργός μεταφορά χρησιμοποιεί μηχανισμούς όπως η αντλία νατρίου–καλίου. Η ώσμωση σχετίζεται με τη μετακίνηση νερού ανάμεσα σε χώρους διαφορετικής ωσμωτικής δραστικότητας. Η διαφορά ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού είναι βασική για την κατανόηση αφυδάτωσης, οιδήματος και μεταβολών ηλεκτρολυτών.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Η κυτταρική μεμβράνη. Φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα, πρωτεΐνες διαύλων, χοληστερόλη, γλυκοπρωτεΐνες.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/3-1-the-cell-membrane.

02.06 — Νευρική ώση και αντανακλαστικά

Οι νευρώνες μεταφέρουν σήματα μέσω μεταβολών του ηλεκτρικού δυναμικού της μεμβράνης. Ένα δυναμικό ενέργειας διαδίδεται κατά μήκος του νευράξονα και η επικοινωνία σε πολλές συνάψεις γίνεται μέσω νευροδιαβιβαστών.

SOS · Η νευρική ώση είναι δυναμικό ενέργειας· οι συνάψεις συνήθως μεταφέρουν σήματα με νευροδιαβιβαστές.

Θεωρία & κατανόηση

Το αντανακλαστικό είναι ταχεία και σχετικά στερεότυπη απάντηση σε ερέθισμα μέσω αντανακλαστικού τόξου. Ο εγκέφαλος συντονίζει ανώτερες λειτουργίες, ενώ ο νωτιαίος μυελός συμμετέχει σε κινητικά και αντανακλαστικά κυκλώματα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Νευρώνες, δυναμικά ενέργειας, συνάψεις, νευροδιαβιβαστές.

Εμβάθυνση φυσιολογικού μηχανισμού

Η νευρική ώση είναι παροδική μεταβολή του ηλεκτρικού δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης. Τα ερεθίσματα μεταδίδονται κατά μήκος του νευράξονα και στα σημεία επικοινωνίας μεταξύ κυττάρων συμμετέχουν νευροδιαβιβαστές. Στο απλό αντανακλαστικό η απάντηση μπορεί να οργανώνεται σε επίπεδο νωτιαίου μυελού χωρίς να απαιτείται συνειδητή απόφαση. Η διατήρηση ανταπόκρισης δεν αποκλείει άλλη επικίνδυνη βλάβη.

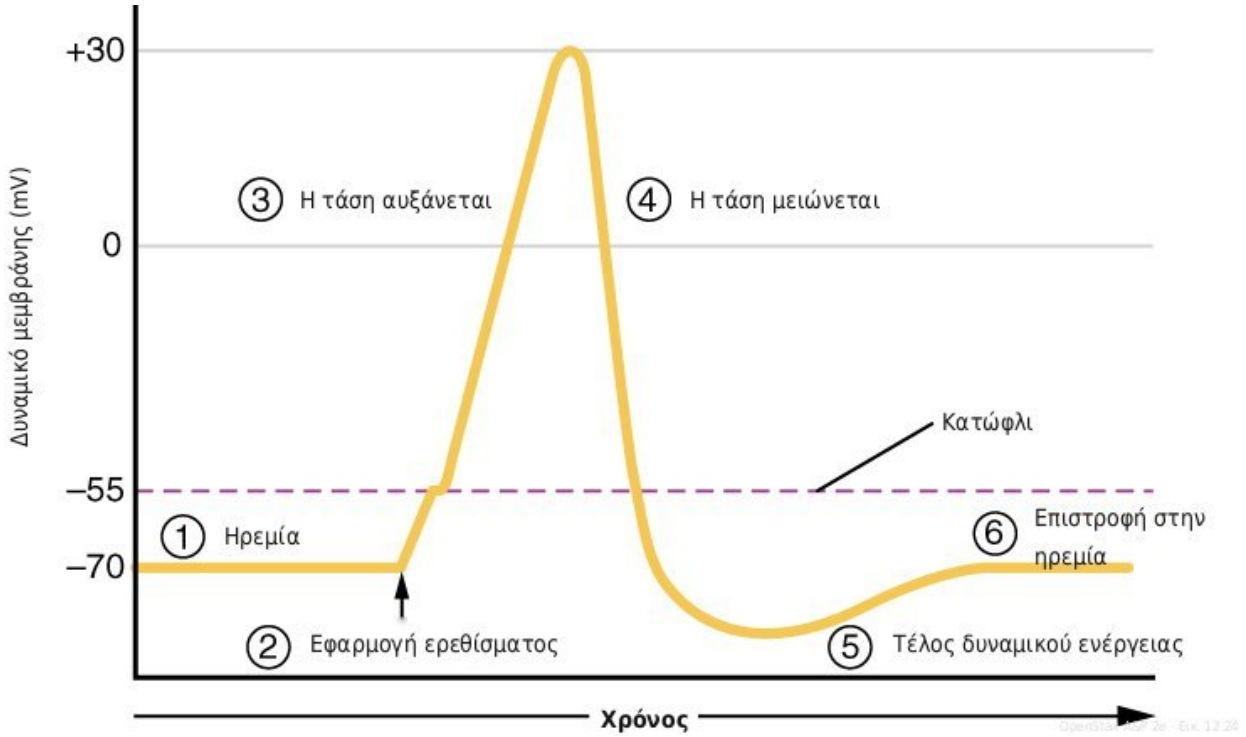
Τι μεταφέρεται κατά μήκος ενός νευράξονα;

Η νευρική ώση / το δυναμικό ενέργειας.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το δυναμικό ενέργειας δημιουργείται όταν ανοίγουν και κλείνουν ιοντικοί δίαυλοι, προκαλώντας ηλεκτρικές μεταβολές στη μεμβράνη. Η σύναψη μεταβιβάζει πληροφορία σε άλλο νευρώνα ή κύτταρο-στόχο. Ένα αντανακλαστικό τόξο μπορεί να λειτουργεί στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού. Η κλινική εκτίμηση νευρολογικής ανταπόκρισης δεν πρέπει να συγχέεται με πλήρη νευρολογική διάγνωση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Στάδια δυναμικού ενέργειας. Ηρεμία, κατώφλι, εκπόλωση, επαναπόλωση και επιστροφή στην ηρεμία.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή:

https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-4-the-action-potential.

02.07 — Καρδιακός κύκλος και ηλεκτρική αγωγή

Η καρδιακή λειτουργία εναλλάσσει συστολή και διαστολή. Κατά τη διαστολή οι κοιλίες γεμίζουν με αίμα· κατά τη συστολή εξωθούν αίμα προς τις αρτηρίες. Το φλεβόκομβο ενεργοποιεί φυσιολογικά τον καρδιακό ρυθμό, και η ώση διαδίδεται στο ερεθισματαγωγό σύστημα.

SOS · Διαστολή = γέμισμα κοιλιών· συστολή = εξώθηση αίματος· ο φλεβόκομβος είναι φυσιολογικός βηματοδότης.

Θεωρία & κατανόηση

Ο όγκος παλμού είναι η ποσότητα αίματος που εξωθεί μια κοιλία σε κάθε συστολή. Η καρδιακή παροχή είναι το γινόμενο όγκου παλμού και καρδιακής συχνότητας. Έτσι εξηγείται πώς μεταβολές του ρυθμού ή της ισχύος της αντλίας επηρεάζουν την αιμάτωση.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Καρδιακή παροχή = καρδιακή συχνότητα × όγκος παλμού.

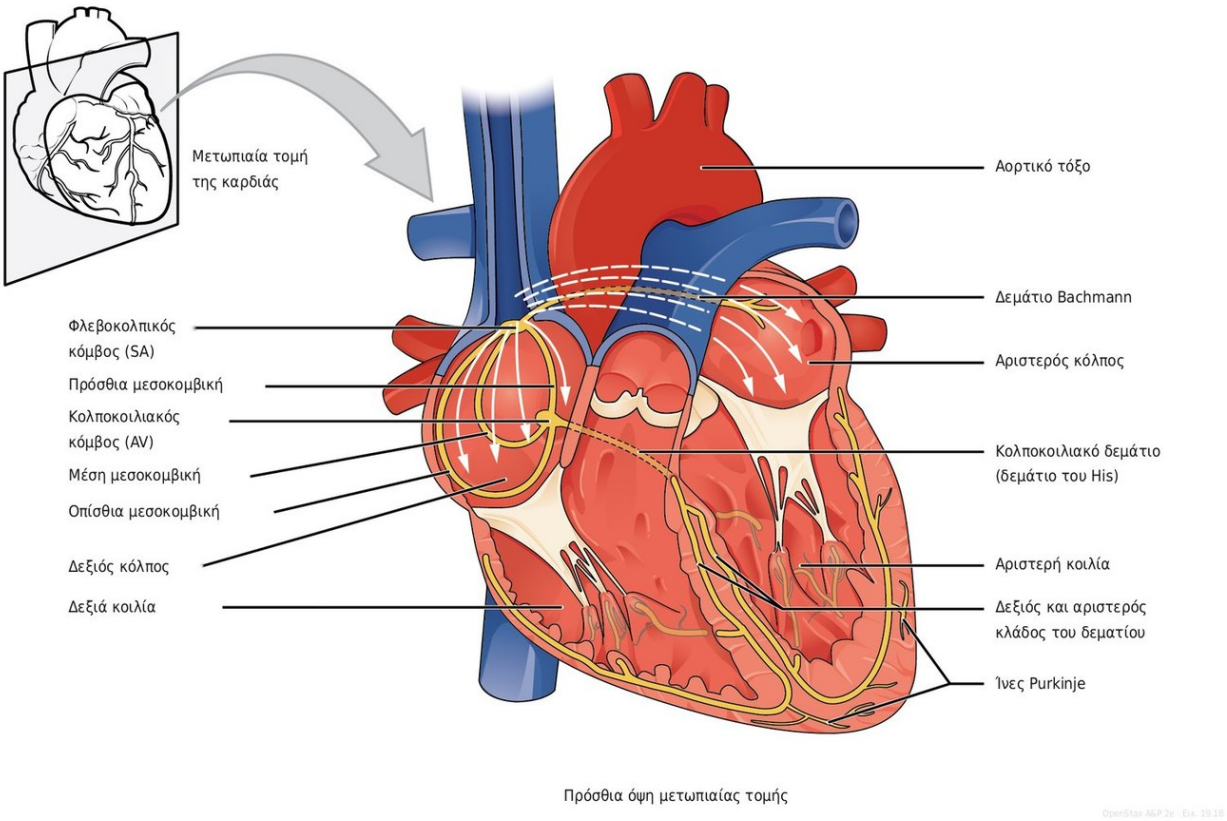
Τι συμβαίνει στη διαστολή των κοιλιών;

Γεμίζουν με αίμα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η διαστολή επιτρέπει πλήρωση των κοιλιών και η συστολή προωθεί αίμα στην πνευμονική και στη συστηματική κυκλοφορία. Ο φλεβόκομβος συνήθως πυροδοτεί τον ρυθμό και η αγωγή περνά από τον κολποκοιλιακό κόμβο στο σύστημα His–Purkinje. Η ηλεκτρική δραστηριότητα δεν ταυτίζεται πάντοτε με αποτελεσματική μηχανική συστολή, γι’ αυτό το ηλεκτροκαρδιογράφημα αξιολογείται μαζί με τον ασθενή.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς. Φλεβόκομβος, κολποκοιλιακός κόμβος, δεμάτιο His, κλάδοι, ίνες Purkinje.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/19-2-cardiac-muscle-and-electrical-activity.

02.08 — Πίεση, αντίσταση και μικροκυκλοφορία

Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από την καρδιακή παροχή και την αντίσταση του αγγειακού δικτύου. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα υπό υψηλότερη πίεση από τις φλέβες, ενώ τα τριχοειδή είναι κύριος τόπος ανταλλαγής ουσιών με τους ιστούς.

SOS · Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από παροχή και αγγειακές αντιστάσεις· στα τριχοειδή γίνεται ανταλλαγή ουσιών.

Θεωρία & κατανόηση

Η αιμάτωση δεν εκτιμάται από έναν αριθμό μόνο. Το επίπεδο συνείδησης, η θερμοκρασία δέρματος, ο περιφερικός σφυγμός και άλλα ευρήματα συμπληρώνουν την κλινική εικόνα. Η πίεση μπορεί να παραμένει φαινομενικά φυσιολογική σε πρώιμη αντιρρόπηση.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Αρτηρίες → αρτηρίδια → τριχοειδή → φλεβίδια → φλέβες.

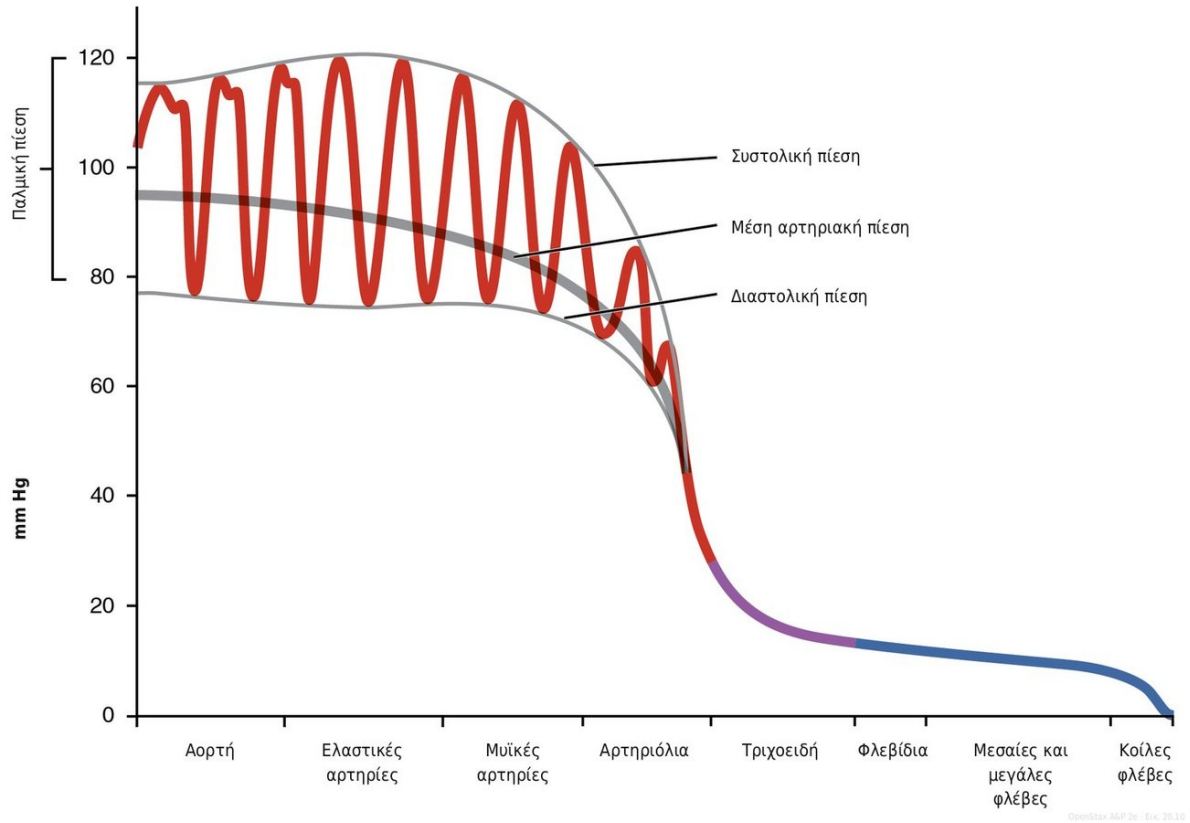
Πού γίνεται κατά κύριο λόγο η ανταλλαγή ουσιών με τους ιστούς;

Στα τριχοειδή.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από αλληλεπίδραση καρδιακής παροχής και περιφερικής αντίστασης. Τα αρτηρίδια ρυθμίζουν σημαντικά την αντίσταση, ενώ τα τριχοειδή επιτρέπουν την ανταλλαγή ουσιών με τους ιστούς. Η ταχεία επαναπλήρωση τριχοειδών αποτελεί βοηθητικό εύρημα, όχι αυτόνομο διαγνωστικό κριτήριο. Η εξέλιξη της πίεσης και των άλλων ευρημάτων πρέπει να εκτιμάται συνολικά.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Πίεση κατά μήκος του αγγειακού δικτύου. Συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση από την αορτή έως τις κοίλες φλέβες.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/20-2-blood-flow-blood-pressure-and-resistance.

02.09 — Αερισμός, διάχυση και μεταφορά αερίων

Ο αερισμός μετακινεί αέρα από και προς τις κυψελίδες. Η διάχυση μετακινεί οξυγόνο από τις κυψελίδες προς το αίμα και διοξείδιο του άνθρακα αντίθετα. Η αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου στο αίμα.

SOS · Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του O_2· το CO_2 απομακρύνεται μέσω πνευμονικού αερισμού.

Θεωρία & κατανόηση

Ο κορεσμός οξυγόνου δεν μετρά απευθείας την αποτελεσματικότητα του αερισμού ούτε την αιμοσφαιρίνη ή την αιμάτωση όλων των ιστών. Ένας άνθρωπος μπορεί να παρουσιάζει ανεπαρκή αναπνευστική προσπάθεια παρά πρόσκαιρα ικανοποιητική ένδειξη οξυμέτρου.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Αερισμός ≠ οξυγόνωση ≠ αιμάτωση.

Ποιο μόριο μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου στο αίμα;

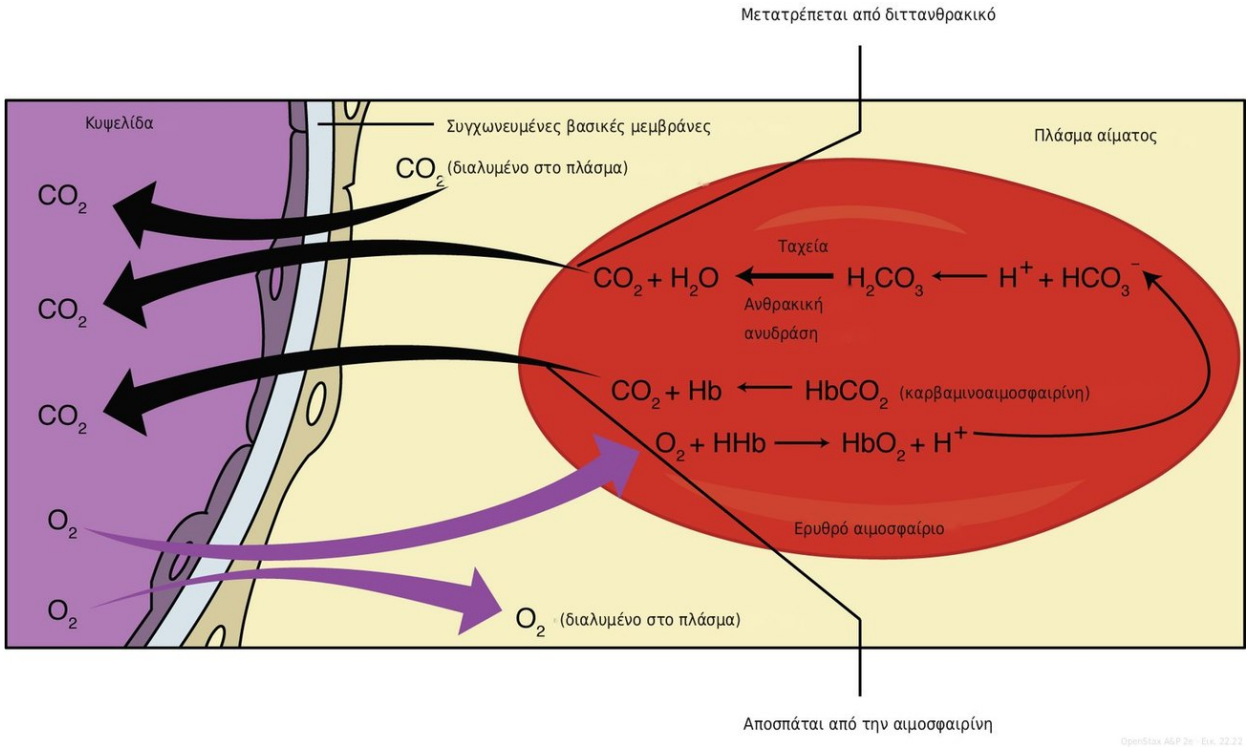
Η αιμοσφαιρίνη.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται στον μεταβολισμό και απομακρύνεται κυρίως με την αναπνοή. Η οξυγόνωση δεν είναι συνώνυμη με τον αερισμό: ένας ασθενής μπορεί να παρουσιάζει πρόβλημα

απομάκρυνσης CO_2 ακόμη και όταν η οξυμετρία δεν δείχνει όλη τη σοβαρότητα. Το παλμικό οξύμετρο έχει περιορισμούς, για παράδειγμα σε χαμηλή περιφερική αιμάτωση. Η κλινική παρατήρηση παραμένει κρίσιμη.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Εξωτερική αναπνοή. Ανταλλαγή O_2 και CO_2 μεταξύ κυψελίδας και αίματος· μεταφορά με την αιμοσφαιρίνη.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/22-4-gas-exchange.

02.10 — Οξεοβασική ισορροπία

Το pH δείχνει την οξύτητα ή αλκαλικότητα ενός διαλύματος. Στον οργανισμό, τα ρυθμιστικά διαλύματα, οι πνεύμονες και οι νεφροί συνεργάζονται για να διατηρούν τη φυσιολογική οξεοβασική ισορροπία. Το διοξείδιο του άνθρακα συνδέει άμεσα τον αερισμό με αυτή την ισορροπία.

SOS · Οξεοβασική ρύθμιση: ρυθμιστικά συστήματα, πνεύμονες (CO_2) και νεφροί (οξέα/διττανθρακικά).

Θεωρία & κατανόηση

Οι πνεύμονες μπορούν να μεταβάλλουν σχετικά γρήγορα την αποβολή διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αναπνοής. Οι νεφροί ρυθμίζουν τη συγκράτηση ή απέκκριση οξέων και διττανθρακικών σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ερμηνεία διαταραχών απαιτεί κλινικό πλαίσιο και, όπου ενδείκνυται, εργαστηριακά δεδομένα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Πνεύμονες: CO_2 · νεφροί: H^+ και HCO_3^-.

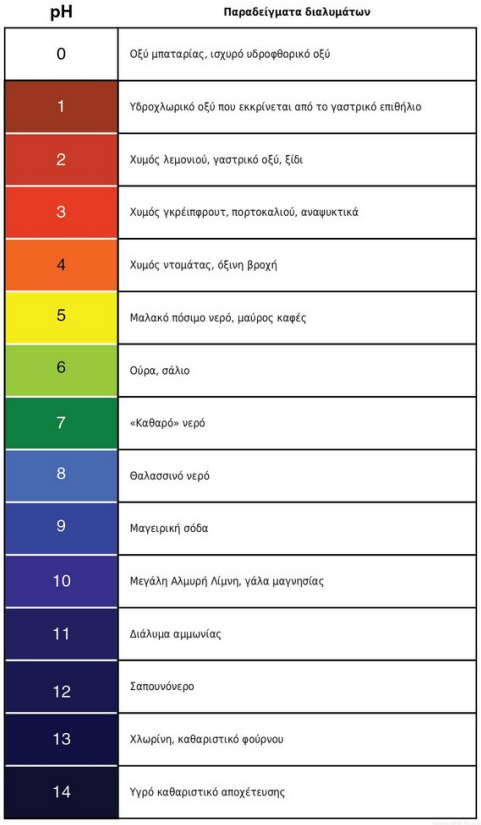
Ποιο όργανο ρυθμίζει σχετικά γρήγορα την αποβολή CO_2;

Οι πνεύμονες.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το pH επηρεάζεται από συστήματα ρυθμιστικών διαλυμάτων, τη νεφρική αποβολή οξέων και τον αναπνευστικό έλεγχο του CO_2. Η οξέωση και η αλκάλωση μπορούν να έχουν μεταβολικό ή αναπνευστικό υπόβαθρο. Η διάκριση απαιτεί κατάλληλες μετρήσεις και ιατρική ερμηνεία. Για τον σπουδαστή σημαντικό είναι να κατανοεί πώς αναπνευστική ανεπάρκεια και κυκλοφορική διαταραχή επηρεάζουν την οξεοβασική ισορροπία.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Η κλίμακα pH. Τιμές pH από 0 έως 14 με παραδείγματα διαλυμάτων (γαστρικό οξύ, ούρα, αίμα, αμμωνία).. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/26-4-acid-base-balance.

02.11 — Νεφρική λειτουργία και ισοζύγιο υγρών

Ο νεφρώνας είναι η βασική λειτουργική μονάδα του νεφρού. Το αίμα διηθείται στο σπείραμα και κατά μήκος των σωληναρίων γίνεται επαναρρόφηση νερού και χρήσιμων ουσιών, καθώς και έκκριση άλλων. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται τα ούρα.

SOS · Ο νεφρώνας διηθεί αίμα, επαναρροφά νερό και χρήσιμες ουσίες και συμμετέχει στην παραγωγή ούρων.

Θεωρία & κατανόηση

Οι νεφροί συμβάλλουν στην ισορροπία νατρίου, καλίου, νερού και οξέων. Το ισοζύγιο εισροών και απωλειών υγρών επηρεάζει τον όγκο κυκλοφορούντος αίματος. Μεταβολές στη διούρηση μπορεί να αποτελούν σημαντικό στοιχείο της γενικής κατάστασης.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Νεφρώνας = σπείραμα + σωληναριακό σύστημα.

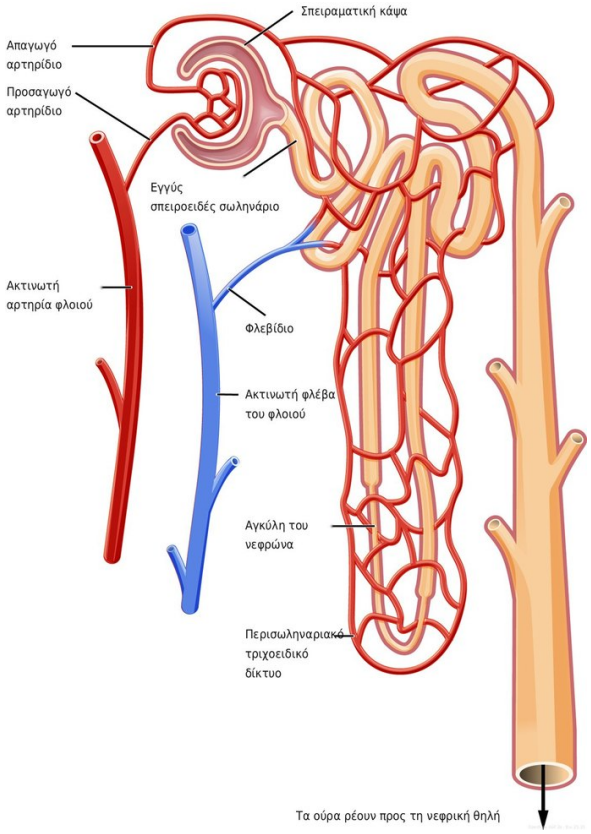
Ποια είναι η λειτουργική μονάδα του νεφρού;

Ο νεφρώνας.

Σε βάθος — επεξήγηση

Οι νεφροί φιλτράρουν πλάσμα και επαναρροφούν χρήσιμες ουσίες, ενώ εκκρίνουν ορισμένα προϊόντα στον σωληναριακό αυλό. Οι ορμόνες ADH και αλδοστερόνη συμβάλλουν με διαφορετικούς τρόπους στη διαχείριση νερού και νατρίου. Η νεφρική λειτουργία επηρεάζει τον όγκο κυκλοφορούντος αίματος και τη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών. Η παραγωγή ούρων αποτελεί σημαντική ένδειξη σε νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Αιματική ροή στον νεφρώνα. Προσαγωγό/απαγωγό αρτηρίδιο, σπείραμα, περισωληναριακά τριχοειδή, αγκύλη νεφρώνα.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/25-3-gross-anatomy-of-the-kidney.

02.12 — Πέψη, απορρόφηση και θρέψη

Η πέψη μετατρέπει σύνθετες ουσίες της τροφής σε μικρότερες που μπορούν να απορροφηθούν. Οι υδατάνθρακες παρέχουν γλυκόζη, οι πρωτεΐνες αμινοξέα και τα λίπη λιπαρά οξέα και άλλα προϊόντα. Στο λεπτό έντερο υπάρχουν λάχνες που αυξάνουν την επιφάνεια απορρόφησης.

SOS · Η κύρια απορρόφηση θρεπτικών γίνεται στο λεπτό έντερο με μεγάλη επιφάνεια λαχνών.

Θεωρία & κατανόηση

Η λειτουργία ήπατος, παγκρέατος και χολής είναι σημαντική για την επεξεργασία και αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών. Η απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών συνεχίζεται και στο παχύ έντερο. Διαταραχές πρόσληψης ή απορρόφησης μπορούν να επηρεάσουν τα διαθέσιμα υγρά και την ενεργειακή

κατάσταση.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Λεπτό έντερο: κύρια απορρόφηση θρεπτικών· παχύ: σημαντική απορρόφηση νερού.

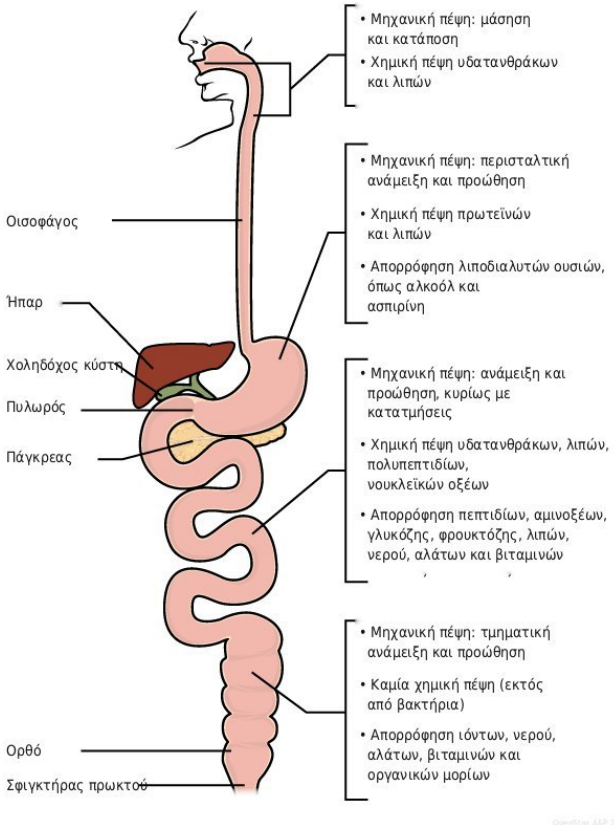
Πού απορροφώνται τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά;

Στο λεπτό έντερο.

Σε βάθος — επεξήγηση

Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη υφίστανται πεπτική επεξεργασία πριν την απορρόφηση. Οι λάχνες και οι μικρολάχνες αυξάνουν τη διαθέσιμη επιφάνεια του λεπτού εντέρου. Η πυλαία κυκλοφορία μεταφέρει πολλές απορροφημένες ουσίες προς το ήπαρ. Το γαστρεντερικό σύστημα συνδέεται με το ενδοκρινικό και το κυκλοφορικό: γι’ αυτό σοβαρή νόσος σε ένα μπορεί να επηρεάσει τα άλλα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Πέψη και απορρόφηση. Μηχανική και χημική πέψη και απορρόφηση σε κάθε τμήμα του πεπτικού σωλήνα.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/23-7-chemical-digestion-and-absorption-a-closer-look.

02.13 — Ενδοκρινής ρύθμιση και γλυκόζη

Οι ενδοκρινείς αδένες απελευθερώνουν ορμόνες στο αίμα. Το πάγκρεας εκκρίνει ινσουλίνη που διευκολύνει την πρόσληψη και αποθήκευση γλυκόζης, και γλυκαγόνη που συμβάλλει στην αύξηση της γλυκόζης αίματος.

SOS · Πάγκρεας: ινσουλίνη διευκολύνει πρόσληψη γλυκόζης· γλυκαγόνη κινητοποιεί γλυκόζη.

Θεωρία & κατανόηση

Ο υποθάλαμος και η υπόφυση συμμετέχουν σε πολλούς άξονες ορμονικής ρύθμισης. Ο θυρεοειδής επηρεάζει τον μεταβολισμό, ενώ τα επινεφρίδια εκκρίνουν ορμόνες σημαντικές για την απόκριση στο στρες. Για την προνοσοκομειακή εκτίμηση είναι σημαντικό να συνδέεται η γλυκόζη με τη νευρολογική εικόνα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ινσουλίνη και γλυκαγόνη έχουν αντίρροπες δράσεις στη γλυκόζη.

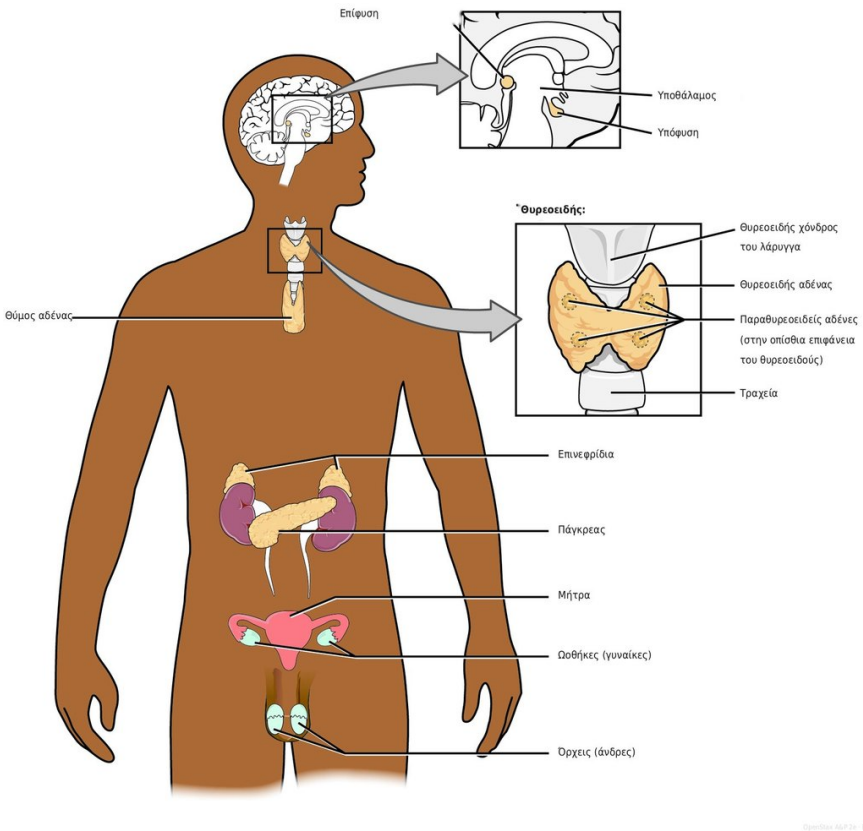
Ποια ορμόνη προάγει την πρόσληψη γλυκόζης από πολλούς ιστούς;

Η ινσουλίνη.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η ινσουλίνη βοηθά πολλά κύτταρα να προσλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν γλυκόζη, ενώ η γλυκαγόνη υποστηρίζει την αύξηση της γλυκόζης όταν χρειάζεται. Οι θυρεοειδικές ορμόνες επηρεάζουν τον ρυθμό μεταβολισμού και οι ορμόνες του στρες μεταβάλλουν την ενεργειακή ισορροπία. Τα συμπτώματα διαταραχών γλυκόζης μπορεί να επικαλύπτονται με άλλες επείγουσες καταστάσεις. Η τεκμηριωμένη μέτρηση είναι ουσιαστική.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Το ενδοκρινικό σύστημα. Θέση των ενδοκρινών αδένων: υπόφυση, θυρεοειδής, επινεφρίδια, πάγκρεας, γονάδες.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/17-1-an-overview-of-the-endocrine-system.

03 · Ο Διασώστης – Επαγγελματίας Υγείας

03.01 — Αποστολή και επαγγελματικά όρια

Ο διασώστης συμμετέχει στην εκτίμηση και υποστήριξη του ασθενούς, στην ασφαλή μεταφορά, στην επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο και στη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας. Ο ρόλος δεν ταυτίζεται με τον ιατρό. Οι συγκεκριμένες πράξεις και η χορήγηση φαρμάκων καθορίζονται από εκπαίδευση, νομοθεσία, ισχύουσες υπηρεσιακές διαδικασίες και ιατρικές οδηγίες.

SOS · Διασώστης: εκτίμηση, βασική υποστήριξη, ασφαλής διακομιδή και συνεργασία· μόνο πράξεις που επιτρέπονται από εκπαίδευση και πρωτόκολλο.

Αναλυτική κατανόηση

Ο διασώστης λειτουργεί ως μέλος οργανωμένου συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Οι βασικές του ευθύνες περιλαμβάνουν διαχείριση κινδύνου, έγκαιρη αναγνώριση απειλής ζωής, υποστήριξη μέσα στα όρια εκπαίδευσης και αρμοδιοτήτων, καταγραφή και σωστή διακομιδή. Δεν ταυτίζεται με τον ιατρό: η αξιολόγηση και οι θεραπευτικές πράξεις που επιτρέπονται ορίζονται από το ισχύον πλαίσιο και τα τοπικά πρωτόκολλα.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση γνωρίζουμε τι επιτρέπεται αυτόνομα, τι απαιτεί οδηγία και πότε πρέπει να κληθεί ανώτερη υποστήριξη.

Ποιος καθορίζει αν μια πράξη μπορεί να εκτελεστεί αυτόνομα;

Το ισχύον επαγγελματικό/νομικό πλαίσιο, η εκπαίδευση και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η επαγγελματική ταυτότητα περιλαμβάνει φροντίδα με ασφάλεια, κατανόηση των ορίων του ρόλου και τεκμηριωμένη συνεργασία. Η άδεια, τα καθήκοντα και το εύρος πράξεων δεν προκύπτουν από ένα εκπαιδευτικό σημείωμα αλλά από το ισχύον θεσμικό και υπηρεσιακό πλαίσιο. Ο διασώστης αναφέρει ευρήματα και διασφαλίζει την ορθή διακομιδή, χωρίς να παρουσιάζει ανεπιβεβαίωτες διαγνώσεις ως γεγονότα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Πλήρωμα ασθενοφόρου σε περιστατικό. Διασώστες εκτιμούν ασθενή στον τόπο του συμβάντος.. Δημιουργός: Noah Wulf. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruce_Woodbury_Beltway_Medical_Incident_5.jpg.

03.02 — Επικοινωνία, αξιοπρέπεια και εμπιστευτικότητα

Η φροντίδα περιλαμβάνει σαφή ενημέρωση, σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στην ιδιωτικότητα, ενεργητική ακρόαση και συνεργασία με τον ασθενή όπου αυτό είναι εφικτό. Οι πληροφορίες υγείας είναι ευαίσθητες και μεταφέρονται μόνο σε όσους εμπλέκονται νόμιμα στη φροντίδα. Η καταγραφή πρέπει να είναι ακριβής, αντικειμενική και χωρίς αξιολογικούς χαρακτηρισμούς.

SOS · Σεβασμός, συγκατάθεση, σαφής ενημέρωση και εμπιστευτικότητα είναι μέρος της φροντίδας.

Αναλυτική κατανόηση

Η αξιοπρέπεια δεν είναι προαιρετική λεπτομέρεια σε ένα επείγον. Εξηγούμε τις ενέργειές μας με σύντομο, απλό λόγο, διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητα και ζητάμε συναίνεση όπου είναι δυνατή. Καταγράφουμε αντικειμενικά γεγονότα, όχι χαρακτηρισμούς για τον ασθενή. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μεταφέρονται μόνο σε κατάλληλους αποδέκτες για σκοπούς περίθαλψης.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Σε θορυβώδη σκηνή ορίζουμε έναν συντονιστή επικοινωνίας και ενημερώνουμε τον ασθενή ακόμη και αν δεν μπορεί να απαντήσει εύκολα.

Τι είναι καλύτερο στο δελτίο: «αγενής» ή συγκεκριμένη συμπεριφορά;

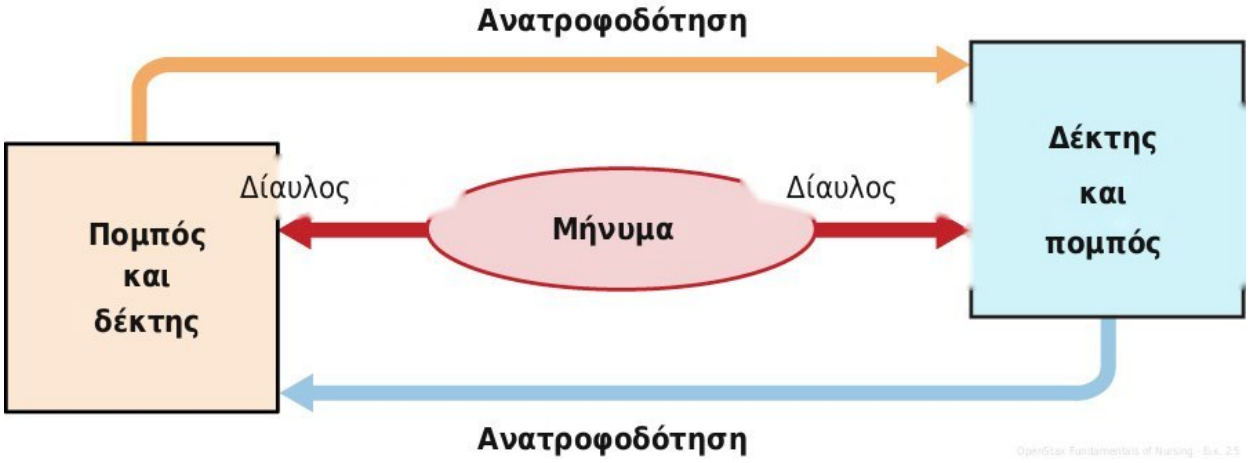
Συγκεκριμένη, αντικειμενικά παρατηρούμενη συμπεριφορά.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η επικοινωνία είναι και κλινική δεξιότητα. Μιλάμε με σαφείς προτάσεις, εξηγούμε τις ενέργειες στο επίπεδο κατανόησης του ασθενούς και ελέγχουμε αν μας κατάλαβε. Πληροφορίες υγείας δεν

κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε συνθήκες έντασης, η προστασία της αξιοπρέπειας και η αποφυγή χαρακτηρισμών είναι εξίσου σημαντικές με τη σωστή τεχνική καταγραφή.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Μοντέλο επικοινωνίας. Πομπός, δέκτης, μήνυμα, δίαυλος και ανατροφοδότηση.. Δημιουργός: OpenStax, Fundamentals of Nursing. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/fundamentals-nursing/pages/2-2-models-of-communication.

03.03 — Ασφάλεια πληρώματος και συνεχής εκπαίδευση

Η εργασία στην προνοσοκομειακή φροντίδα ενέχει σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους. Οι ασφαλείς τεχνικές μεταφοράς, τα μέσα ατομικής προστασίας και η αναγνώριση επικίνδυνων σκηνών μειώνουν τους κινδύνους. Η επιμόρφωση στις νέες οδηγίες είναι ουσιώδης, επειδή οι κλινικές συστάσεις και ο διαθέσιμος εξοπλισμός εξελίσσονται.

SOS · Ασφάλεια σκηνής και ΜΑΠ επανεκτιμώνται συνεχώς· κάθε μέλος δηλώνει τους περιορισμούς εκπαίδευσής του.

Αναλυτική κατανόηση

Οι κίνδυνοι για το πλήρωμα περιλαμβάνουν κυκλοφορία οχημάτων, βία, ηλεκτρική ενέργεια, βιολογικούς παράγοντες, ασταθείς κατασκευές και σωματική καταπόνηση. Η εκτίμηση ασφάλειας επαναλαμβάνεται όσο εξελίσσεται το περιστατικό. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η ανασκόπηση περιστατικών βοηθούν στην αναγνώριση ανθρώπινων λαθών και στην εφαρμογή ασφαλέστερων διαδικασιών.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Αν η σκηνή δεν είναι ασφαλής, η είσοδος χωρίς έλεγχο προσθέτει θύματα αντί να μειώνει την ανάγκη βοήθειας.

Γιατί αξιολογούμε ξανά την ασφάλεια μετά την αρχική είσοδο;

Επειδή οι συνθήκες και οι κίνδυνοι μπορεί να αλλάξουν.

Σε βάθος — επεξήγηση

Οι κίνδυνοι για το πλήρωμα περιλαμβάνουν οδική κυκλοφορία, φυσικά εμπόδια, μολυσματικούς παράγοντες, βία και καταπόνηση κατά τις μεταφορές. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα ΜΑΠ και ζητούμε πρόσθετη βοήθεια όπου απαιτείται. Η εκπαίδευση συνεχίζεται μετά το πτυχίο μέσα από ασκήσεις, ανατροφοδότηση, ανασκόπηση περιστατικών και επικαιροποίηση κατευθυντήριων οδηγιών.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Ασφαλής μεταφορά τραυματία. Προετοιμασία τραυματία σε φορείο με μέσα προστασίας.. Δημιουργός: Dvermeirre. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MVA_Response_Welland_FD_Niagara_EMS_03.JPG.

03.04 — Το σύστημα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας

Η προνοσοκομειακή φροντίδα είναι μια οργανωμένη αλυσίδα από τη λήψη κλήσης και τη διαλογή μέχρι την ανταπόκριση, την εκτίμηση του πάσχοντος και την παράδοσή του σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Το πλήρωμα δεν λειτουργεί απομονωμένα: συνεργάζεται με κέντρο, άλλες υπηρεσίες και νοσοκομειακούς επαγγελματίες.

SOS · Προνοσοκομειακή αλυσίδα: κλήση, διαλογή, αποστολή, φροντίδα, διακομιδή και τεκμηριωμένη παράδοση.

Θεωρία & κατανόηση

Η αποτελεσματικότητα στηρίζεται σε σαφή κατανομή ρόλων, επικοινωνία κρίσιμων δεδομένων και ασφαλή μεταφορά. Η χρονική αλληλουχία, η ακριβής τοποθεσία και οι αλλαγές της κατάστασης αποτελούν επιχειρησιακές πληροφορίες, όχι γραφειοκρατικές λεπτομέρειες.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Αλυσίδα: κλήση → ανταπόκριση → εκτίμηση → φροντίδα → παράδοση.

Πού ολοκληρώνεται το επεισόδιο προνοσοκομειακής φροντίδας;

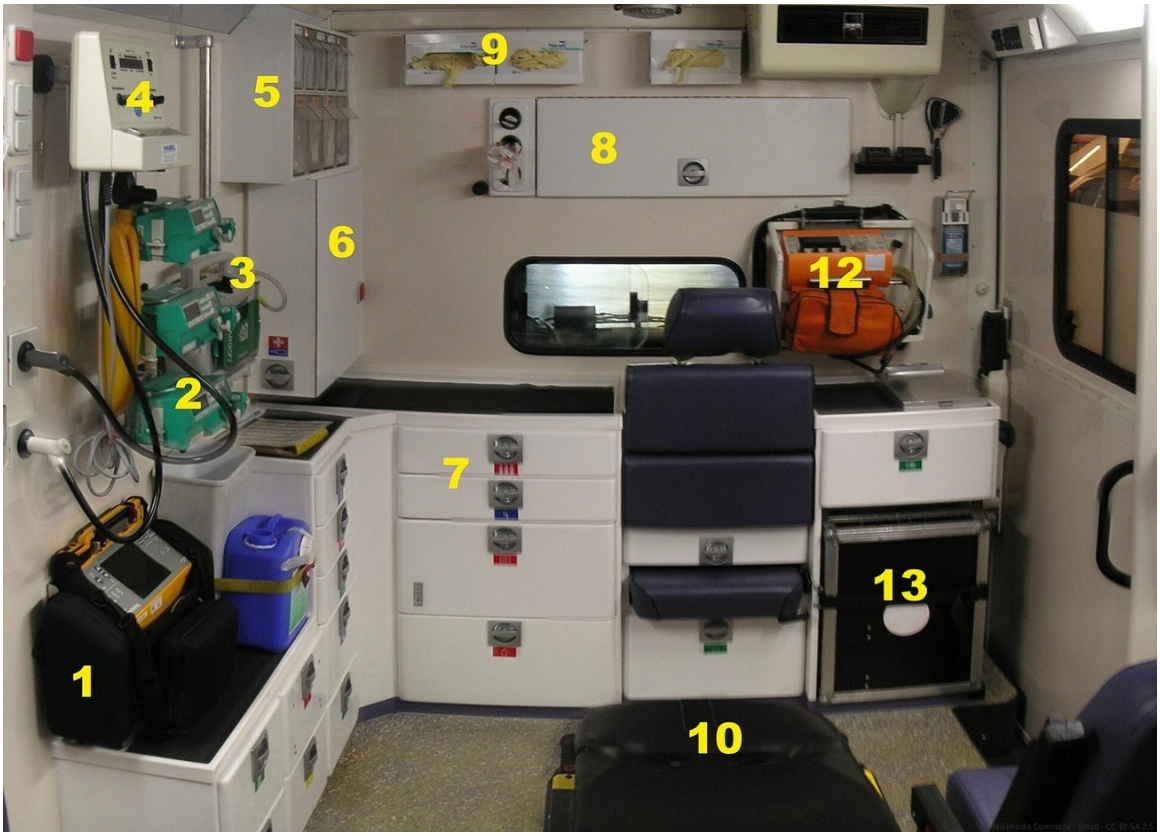
Με την ασφαλή παράδοση και τεκμηρίωση στη μονάδα υποδοχής.

Σε βάθος — επεξήγηση

Ένα οργανωμένο σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας περιλαμβάνει λήψη κλήσης, διαλογή/προτεραιοποίηση, κινητοποίηση κατάλληλων πόρων, επιτόπια εκτίμηση, μεταφορά και παράδοση

στον κατάλληλο υγειονομικό φορέα. Η σαφής επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο περιορίζει καθυστερήσεις και ασάφειες. Οι ακριβείς επιχειρησιακές διαδικασίες καθορίζονται τοπικά από την υπηρεσία.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Εσωτερικό ασθενοφόρου. Φορείο, εξοπλισμός και οργάνωση χώρου σε κινητή μονάδα.. Δημιουργός: Ernstl. Άδεια: CC BY-SA 2.5. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambulance_Interior_Details.jpg.

03.05 — Συναίνεση και λήψη αποφάσεων

Η ενημερωμένη συναίνεση βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, αξιολόγησης και έκφρασης επιλογής από τον ασθενή. Ο επαγγελματίας εξηγεί, μέσα στα επαγγελματικά του όρια, τι πρόκειται να γίνει και σέβεται την αξιοπρέπεια και τις αποφάσεις του προσώπου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.

SOS · Η συναίνεση και η ικανότητα απόφασης αξιολογούνται στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο· η άρνηση τεκμηριώνεται.

Θεωρία & κατανόηση

Σε επείγουσες καταστάσεις με περιορισμένη δυνατότητα συναίνεσης απαιτείται τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των διαδικασιών. Δεν εξάγουμε αυτόματα συμπεράσματα για την ικανότητα συναίνεσης μόνο από ηλικία, αναπηρία ή γλώσσα. Σε αμφιβολία ζητείται συνδρομή της αρμόδιας κλινικής ομάδας.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Συναίνεση, ενημέρωση, ικανότητα, τεκμηρίωση.

Τι προηγείται κανονικά μιας μη επείγουσας παρέμβασης;

Η κατάλληλη ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η συναίνεση προϋποθέτει κατανοητή πληροφόρηση και δυνατότητα του προσώπου να λάβει απόφαση. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων μπορεί να επηρεάζεται από συγχυτική κατάσταση, τραυματισμό ή άλλες καταστάσεις. Η αντιμετώπιση άρνησης μεταφοράς ή φροντίδας δεν λύνεται με έναν γενικό κανόνα: ακολουθούνται η νομοθεσία, η επιβλέπουσα ιατρική οδηγία και οι υπηρεσιακές διαδικασίες.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Ηθικά διλήμματα στη φροντίδα. Αυτονομία, συναίνεση, απόρρητο, πολιτισμικός σεβασμός.. Δημιουργός: OpenStax, Fundamentals of Nursing. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/fundamentals-nursing/pages/16-2-ethics-in-nursing-practice.

03.06 — Επαγγελματικό απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες υγείας έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Η ασφαλής διαχείρισή τους απαιτεί να συλλέγονται μόνο όσα είναι αναγκαία, να προστατεύονται οι καταγραφές και να αποκαλύπτονται στους κατά νόμο εμπλεκόμενους στη φροντίδα.

SOS · Δεδομένα υγείας μοιράζονται μόνο με εξουσιοδοτημένους για τη φροντίδα, όχι σε προσωπικά δίκτυα.

Θεωρία & κατανόηση

Η κοινοποίηση φωτογραφιών, ονομάτων ή περιστατικών σε προσωπικές συνομιλίες και κοινωνικά δίκτυα μπορεί να παραβιάσει σοβαρά την εμπιστευτικότητα. Κατά την παράδοση, η κλινική επικοινωνία πρέπει να είναι επαρκής χωρίς αδικαιολόγητη έκθεση δεδομένων τρίτων.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Η ευκολία επικοινωνίας δεν αναιρεί την υποχρέωση εχεμύθειας.

Επιτρέπεται η ανάρτηση αναγνωρίσιμης φωτογραφίας περιστατικού σε προσωπικό προφίλ;

Όχι χωρίς κατάλληλη νόμιμη βάση και τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σε βάθος — επεξήγηση

Οι πληροφορίες ασθενούς χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένο σκοπό φροντίδας και καταγράφονται στα εγκεκριμένα συστήματα. Δεν φωτογραφίζουμε ή δημοσιοποιούμε περιστατικά για προσωπική χρήση. Οι συζητήσεις για ευαίσθητα δεδομένα γίνονται μόνο με τους κατάλληλους επαγγελματίες, σε ασφαλές πλαίσιο. Το καθήκον εμπιστευτικότητας συνεχίζεται και μετά το τέλος της βάρδιας.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Πρόσβαση στον φάκελο του ασθενούς. Μελέτη ιατρικού φακέλου πριν την εκτίμηση.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/4-2-data-collection-and-documentation.

03.07 — Ασφαλής μετακίνηση και εργονομία

Οι διασώστες εργάζονται συχνά σε δύσκολους χώρους και σηκώνουν ή μετακινούν εξοπλισμό και ασθενείς. Ο κίνδυνος μυοσκελετικού τραυματισμού μειώνεται με προσχεδιασμό, χρήση κατάλληλων βοηθημάτων, σταθερή βάση στήριξης και επαρκή αριθμό ατόμων.

SOS · Πριν τη μετακίνηση: σχέδιο, σωστός αριθμός βοηθών, κατάλληλο μέσο και προστασία μέσης/αρθρώσεων.

Θεωρία & κατανόηση

Πριν από τη μεταφορά εξετάζονται διαδρομή, εμπόδια, σκάλες, χώρος και περιορισμοί εξοπλισμού. Η χρήση φορείων και ειδικών μέσων γίνεται μόνο μετά από αντίστοιχη εκπαίδευση και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Δεν σηκώνουμε μεμονωμένα φορτία πέρα από την ασφαλή ικανότητα της ομάδας.

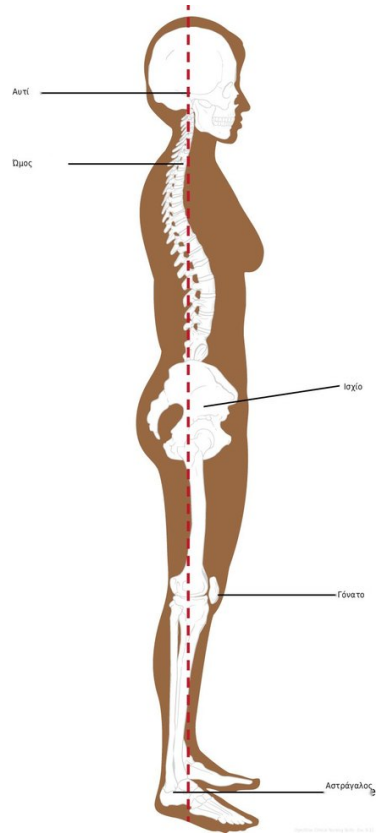
Ποιο είναι το πρώτο βήμα πριν από δύσκολη μεταφορά ασθενούς;

Η εκτίμηση του χώρου, του φορτίου και των διαθέσιμων μέσων/ατόμων.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η εργονομία στην ανύψωση φορτίων απαιτεί σχεδιασμό πριν τη μετακίνηση και συνεργασία ομάδας. Εκτιμούμε διαδρομή, εμπόδια, βάρος, διαθέσιμο εξοπλισμό και ανάγκη πρόσθετου προσωπικού. Χρησιμοποιούμε βοηθήματα σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή και εκπαίδευση. Η «βιαστική χειροκίνητη ανύψωση» δεν είναι αποδεκτό υποκατάστατο κατάλληλης οργάνωσης.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Ουδέτερη στάση σπονδυλικής στήλης. Ευθυγράμμιση αυτιού, ώμου, ισχίου, γόνατος και αστραγάλου.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/9-2-assessing-mobility.

03.08 — Ψυχολογική υποστήριξη και επικοινωνία

Σε επεισόδιο κρίσης ο ασθενής και οι συνοδοί μπορεί να βιώνουν φόβο, θυμό ή σύγχυση. Η ήρεμη, σαφής επικοινωνία, η συστήση του επαγγελματία και η περιγραφή των επόμενων ενεργειών μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα.

SOS · Επικοινωνία με ήρεμη γλώσσα, ενεργητική ακρόαση και αποφυγή μη ρεαλιστικών υποσχέσεων.

Θεωρία & κατανόηση

Αποφεύγονται υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν και στιγματιστικές εκφράσεις. Η ενεργητική ακρόαση επιτρέπει να αναγνωρίζονται πρακτικές ανάγκες, ενώ η ασφάλεια πληρώματος παραμένει πρώτη προτεραιότητα όταν υπάρχει απειλή βίας.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Σύντομες φράσεις, ήρεμος τόνος, ακρόαση, σεβασμός.

Ποιο χαρακτηριστικό βοηθά στην επικοινωνία με φοβισμένο ασθενή;

Η σαφής, ήρεμη και ειλικρινής ενημέρωση.

Σε βάθος — επεξήγηση

Σε ασθενή ή συγγενή που φοβάται, η ήρεμη εξήγηση μπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία. Ακούμε χωρίς να διακόπτουμε και αποφεύγουμε αβάσιμες διαβεβαιώσεις. Η ψυχολογική υποστήριξη δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση ψυχολόγου ή ψυχιάτρου· σημαίνει ότι επικοινωνούμε με σεβασμό, αναγνωρίζουμε την κρίση και ενεργοποιούμε κατάλληλη περαιτέρω βοήθεια.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Μη λεκτική επικοινωνία. Ο πόνος και η δυσφορία εκφράζονται με τη στάση του σώματος.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/3-1-therapeutic-communication.

03.09 — Συνεργασία ομάδας και παράδοση περιστατικού

Η αποτελεσματική ομάδα χρειάζεται ρόλους, αμοιβαία επιβεβαίωση ενεργειών και σαφή επικοινωνία. Η κλειστή επικοινωνία βρόχου σημαίνει ότι ο παραλήπτης επαναλαμβάνει κρίσιμη οδηγία και ο αποστολέας επιβεβαιώνει την ορθή κατανόηση.

SOS · Παράδοση: κύριο πρόβλημα, χρόνο έναρξης, ζωτικά, μεταβολές, ενέργειες και ανταπόκριση, με επιβεβαίωση παραλαβής.

Θεωρία & κατανόηση

Κατά την παράδοση αναφέρονται τι συνέβη, πότε, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, ποια ζωτικά μετρήθηκαν και ποιες ενέργειες έγιναν. Τα ευρήματα διαχωρίζονται από τις υποθέσεις, ώστε να διευκολύνεται η συνέχεια της φροντίδας.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ποιος, τι, πότε, ευρήματα, παρεμβάσεις, ανταπόκριση.

Γιατί επαναλαμβάνουμε κρίσιμη οδηγία στην ομαδική επικοινωνία;

Για να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε σωστά κατανοητή.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η ομαδική εργασία απαιτεί σύντομη ανάθεση ρόλων, επιβεβαίωση σημαντικών πληροφοριών και τακτική ανασκόπηση προτεραιοτήτων. Στην παράδοση ασθενούς μεταφέρονται τα κρίσιμα στοιχεία: λόγος κλήσης, κατάσταση κατά την άφιξη, αξιολόγηση, εξελίξεις και παρεμβάσεις σύμφωνα με τα υπηρεσιακά πρότυπα. Η δομημένη αναφορά μειώνει τον κίνδυνο απώλειας πληροφορίας.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Μοντέλο SBAR για παράδοση περιστατικού. Κατάσταση, ιστορικό, εκτίμηση, εισήγηση.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/4-2-data-collection-and-documentation.

03.10 — Επαγγελματική ανθεκτικότητα και όρια

Η συνεχής έκθεση σε έντονα περιστατικά και βάρδιες μπορεί να προκαλεί κόπωση ή ψυχικό φορτίο. Η αναγνώριση εξάντλησης, η αναζήτηση υποστήριξης και η διατήρηση ασφαλών συνηθειών αποτελούν μέρος της επαγγελματικής ασφάλειας.

SOS · Επαγγελματική ανθεκτικότητα: αναγνώριση στρες, αποφόρτιση, ασφαλή όρια και αναζήτηση βοήθειας.

Θεωρία & κατανόηση

Η αποτίμηση περιστατικών και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση βοηθούν στην αναγνώριση σφαλμάτων χωρίς απόδοση άδικης ευθύνης. Η επίγνωση προσωπικών ορίων σημαίνει ότι ζητούμε έγκαιρα βοήθεια όταν απαιτείται πρόσθετη τεχνογνωσία ή μέσο.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Επαγγελματισμός περιλαμβάνει και έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.

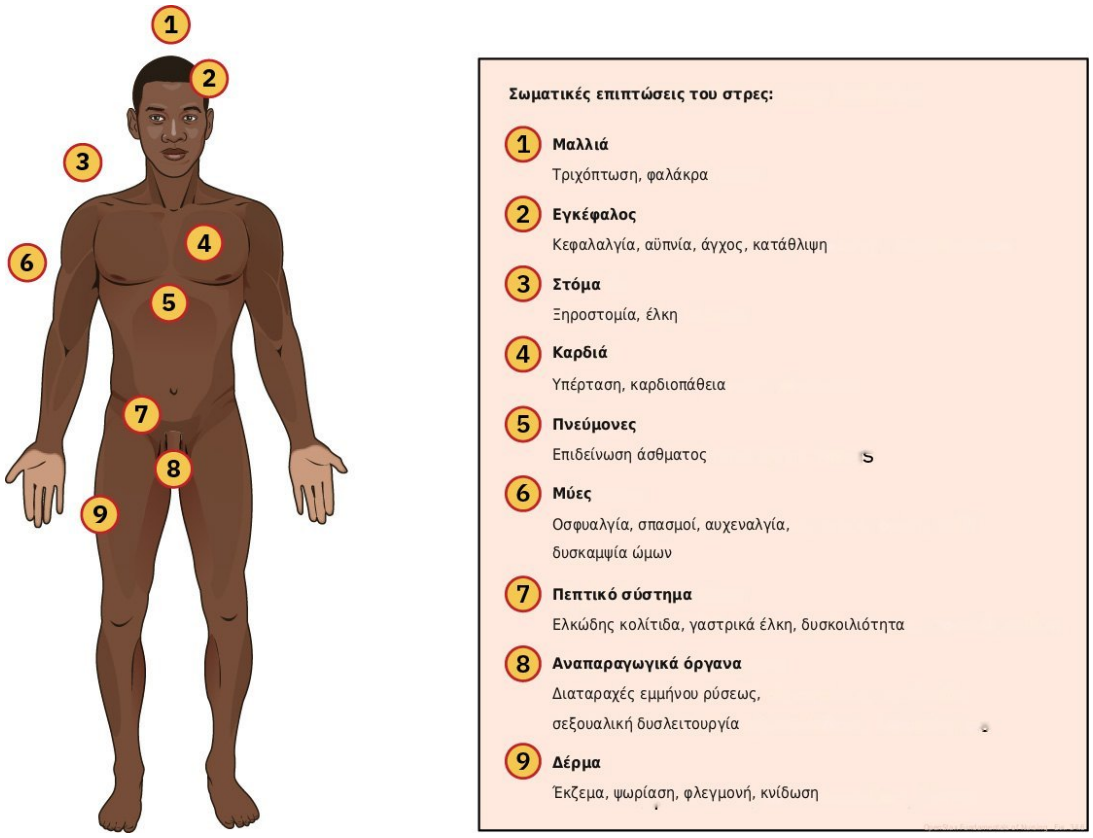
Γιατί έχει αξία ο απολογισμός μετά από ένα δύσκολο περιστατικό;

Για εντοπισμό μαθημάτων, υποστήριξη της ομάδας και βελτίωση της ασφάλειας.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η επαγγελματική ανθεκτικότητα δεν είναι αδιαφορία απέναντι στο ψυχολογικό φορτίο. Αναγνώριση κόπωσης, επαρκής ανάπαυση, υποστηρικτικό περιβάλλον και πρόσβαση σε κατάλληλη βοήθεια μειώνουν τους κινδύνους. Η εκπαίδευση σε δύσκολα περιστατικά και η ανασκόπηση μετά από σοβαρά συμβάντα γίνονται με ασφαλή, οργανωμένο τρόπο και χωρίς έκθεση προσωπικών δεδομένων.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Σωματικές επιπτώσεις του στρες. Πώς εκδηλώνεται το παρατεταμένο στρες στο σώμα.. Δημιουργός: OpenStax, Fundamentals of Nursing. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/fundamentals-nursing/pages/34-1-stress-and-adaptation.

04 · Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας

04.01 — Τι είναι δημόσια υγεία

Η δημόσια υγεία αφορά την προστασία και βελτίωση της υγείας πληθυσμών μέσω πρόληψης, ενημέρωσης, επιτήρησης και οργανωμένων παρεμβάσεων. Η ατομική φροντίδα απευθύνεται σε συγκεκριμένο ασθενή, ενώ τα μέτρα δημόσιας υγείας αποβλέπουν στη μείωση κινδύνων για μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων. Και τα δύο συναντώνται στην προνοσοκομειακή φροντίδα.

SOS · Δημόσια υγεία: πρόληψη νόσων, προστασία πληθυσμών και μείωση ανισοτήτων υγείας.

Αναλυτική κατανόηση

Η δημόσια υγεία ασχολείται με την πρόληψη νόσων και την προαγωγή της υγείας στον πληθυσμό. Η επιδημιολογία εξετάζει τη συχνότητα και την κατανομή καταστάσεων, ενώ η επιτήρηση επιτρέπει έγκαιρη ανίχνευση σημαντικών μεταβολών. Η πρόληψη περιλαμβάνει πρωτογενή μέτρα, έγκαιρη ανίχνευση και μείωση επιπλοκών.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Σε επείγον περιστατικό, ο διασώστης εφαρμόζει μέτρα πρόληψης που προστατεύουν ασθενή, πλήρωμα και κοινότητα.

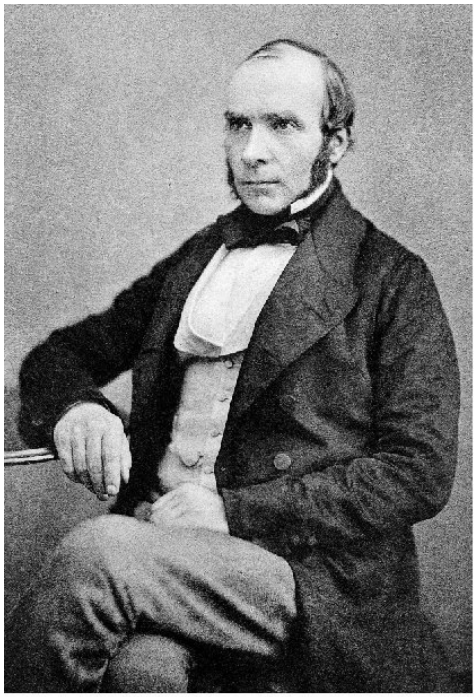
Τι μελετά η επιδημιολογία;

Τη συχνότητα, την κατανομή και τους παράγοντες υγείας και νόσου σε πληθυσμούς.

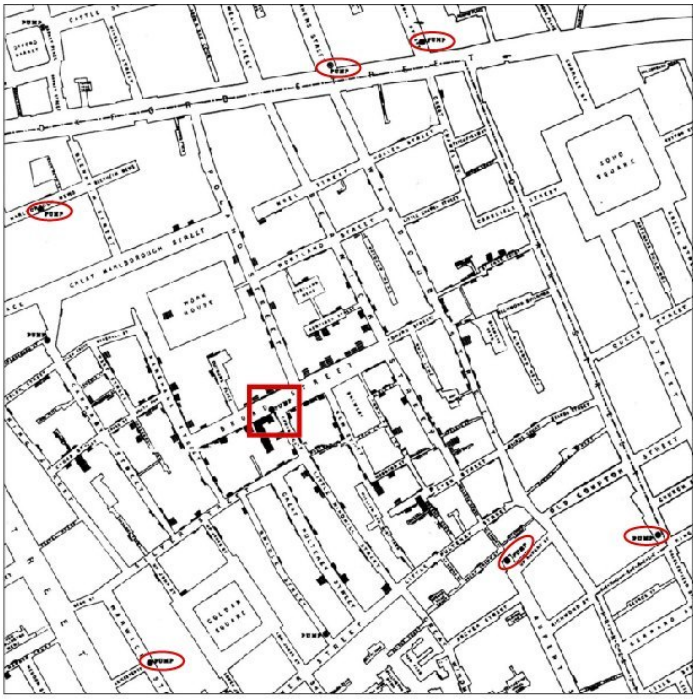
Σε βάθος — επεξήγηση

Η δημόσια υγεία μετρά και αντιμετωπίζει παράγοντες που επηρεάζουν ολόκληρους πληθυσμούς. Η επιτήρηση νόσων, η πρόληψη, η υγειονομική αγωγή και ο σχεδιασμός υπηρεσιών έχουν διαφορετικό σκοπό από την ατομική θεραπεία. Σε επιδημίες ή μεγάλες καταστροφές η σύνδεση προνοσοκομειακής φροντίδας με δημόσια υγεία γίνεται ιδιαίτερα εμφανής.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



(α) John Snow



(β) Χάρτης χολέρας, Λονδίνο 1854

Εικόνα: John Snow και ο χάρτης της χολέρας. Ο θεμελιωτής της επιδημιολογίας και η χαρτογράφηση των κρουσμάτων χολέρας στο Λονδίνο (1854).. Δημιουργός: OpenStax, Microbiology (N. Parker κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/microbiology/pages/16-2-tracking-infectious-diseases.

04.02 — Αλυσίδα μετάδοσης λοιμώξεων

Ένα λοιμώδες νόσημα μεταδίδεται όταν υπάρχει παθογόνος παράγοντας, πηγή, πύλη εξόδου, οδός μετάδοσης, πύλη εισόδου και ευπαθής ξενιστής. Η υγιεινή χεριών, τα σωστά ΜΑΠ, ο καθαρισμός επιφανειών και η σωστή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων διακόπτουν κρίκους αυτής της αλυσίδας. Η επιλογή ΜΑΠ εξαρτάται από τον κίνδυνο έκθεσης και τις ισχύουσες οδηγίες.

SOS · Αλυσίδα λοίμωξης: παθογόνο, δεξαμενή, έξοδος, οδός μετάδοσης, είσοδος, ευάλωτος ξενιστής.

Αναλυτική κατανόηση

Η μετάδοση λοίμωξης προϋποθέτει παθογόνο, δεξαμενή, πύλη εξόδου, τρόπο μετάδοσης, πύλη εισόδου και ευπαθή ξενιστή. Η διακοπή ενός κρίκου μειώνει τον κίνδυνο: υγιεινή χεριών, μέσα ατομικής προστασίας, καθαρισμός επιφανειών και ορθή διαχείριση αιχμηρών είναι βασικά μέτρα. Τα γάντια δεν αντικαθιστούν την υγιεινή χεριών.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Ο ΠΟΥ ορίζει πέντε κρίσιμες στιγμές υγιεινής χεριών: πριν από επαφή, πριν από άσηπτη πράξη, μετά από κίνδυνο έκθεσης σε υγρά, μετά από επαφή και μετά από επαφή με το περιβάλλον ασθενούς.

Αν φοράς γάντια, χρειάζεσαι υγιεινή χεριών;

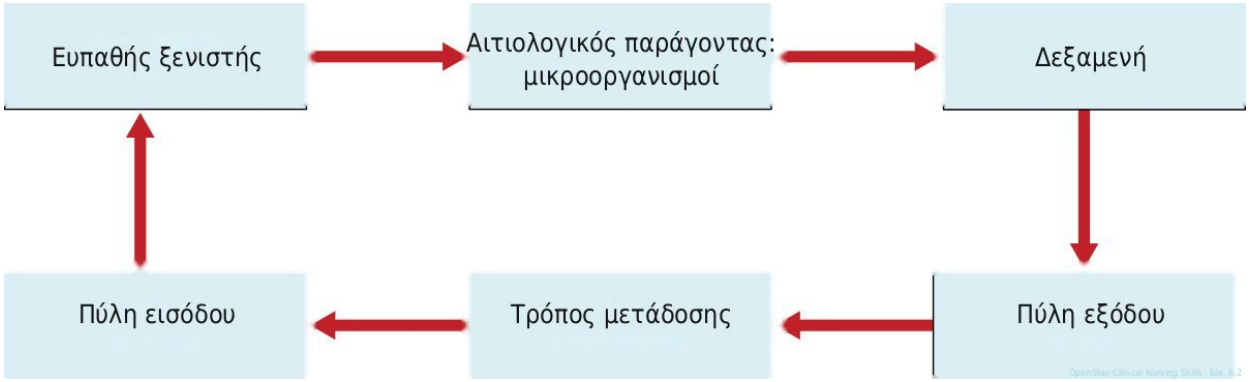
Ναι. Η υγιεινή χεριών απαιτείται και πριν/μετά τη χρήση γαντιών ανάλογα με τη φροντίδα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Για να μεταδοθεί λοίμωξη χρειάζεται παθογόνο, δεξαμενή, έξοδος, τρόπος μεταφοράς, είσοδος και ευπαθής ξενιστής. Τα μέτρα πρόληψης στοχεύουν να διακόψουν έναν ή περισσότερους κρίκους αυτής της αλυσίδας. Η αναγνώριση πιθανού τρόπου μετάδοσης επηρεάζει τα ΜΑΠ και την επικοινωνία με τον φορέα

υποδοχής, σύμφωνα με επίσημα πρωτόκολλα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: ΠΟΥ · Πρόληψη λοιμώξεων .



Εικόνα: Η αλυσίδα της λοίμωξης. Αιτιολογικός παράγοντας, δεξαμενή, πύλη εξόδου, τρόπος μετάδοσης, πύλη εισόδου, ευπαθής ξενιστής.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/6-1-infection-cycle.

04.03 — Πρόληψη και ευάλωτοι πληθυσμοί

Η πρωτογενής πρόληψη αποσκοπεί στην αποφυγή νόσου, η δευτερογενής στην έγκαιρη ανίχνευση και η τριτογενής στη μείωση επιπλοκών και αναπηρίας. Σε ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα μπορεί να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη συνεννόηση και στη διαχείριση κινδύνου. Ο διασώστης συμβάλλει με ασφαλή πρακτική και ορθή ενημέρωση.

SOS · Πρόληψη: εμβολιασμοί, υγιεινή, έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και πρόσβαση σε φροντίδα.

Αναλυτική κατανόηση

Οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας περιλαμβάνουν συνθήκες διαβίωσης, εργασία, μόρφωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η ίδια κλινική κατάσταση μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικούς κινδύνους σε ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους ή ανθρώπους με αναπηρία. Η καθολική πρόσβαση και η μη διάκριση αποτελούν αρχές της φροντίδας.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Στην παράδοση αναφέρουμε πρακτικές ανάγκες, όπως κινητικά βοηθήματα ή δυσκολία επικοινωνίας, χωρίς στερεότυπα.

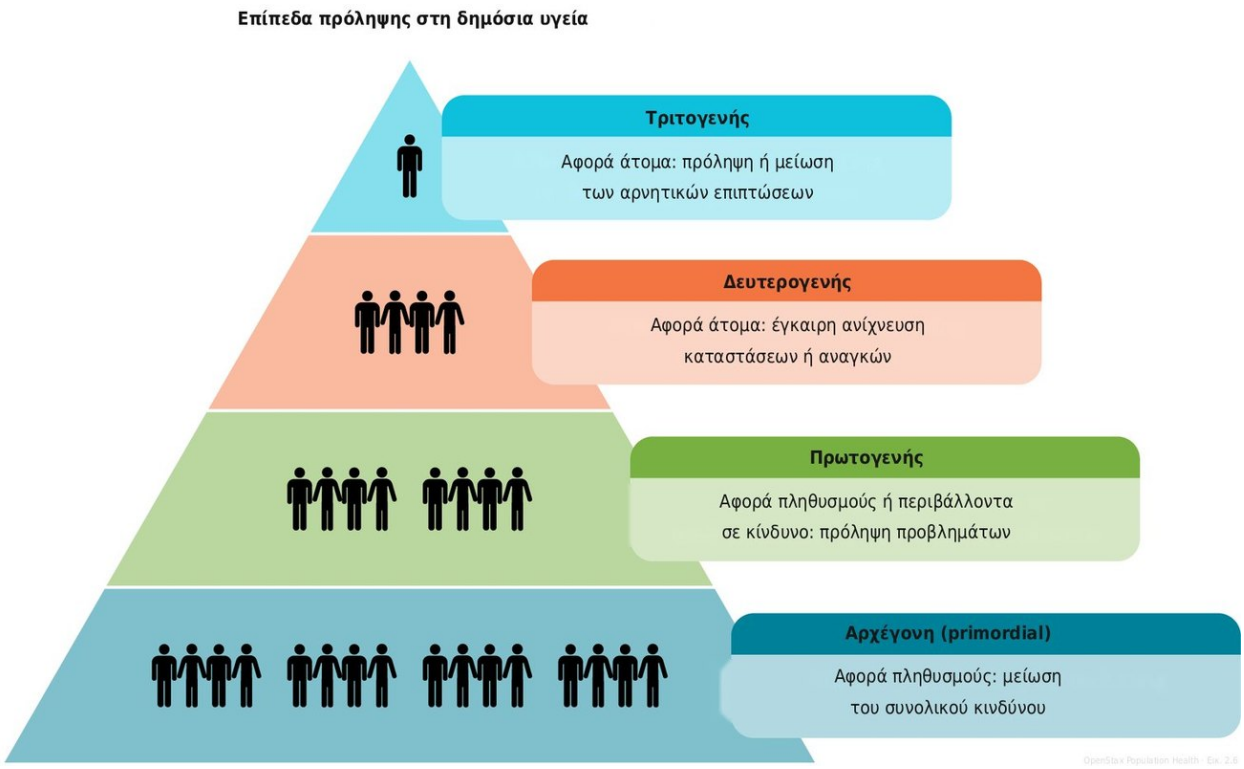
Ποια είναι μία κρίσιμη αρχή όταν φροντίζουμε ευάλωτο άτομο;

Εξατομίκευση, αξιοπρέπεια και αποφυγή διακρίσεων.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η πρόληψη μπορεί να είναι πρωτογενής (να αποτραπεί η νόσος), δευτερογενής (έγκαιρη ανίχνευση) ή τριτογενής (μείωση επιπλοκών). Οι ευάλωτοι πληθυσμοί μπορεί να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια πρόσβασης σε υπηρεσίες. Οι διασώστες φροντίζουν ισότιμα τον ασθενή, χωρίς προκατάληψη για ηλικία, κοινωνική κατάσταση, γλώσσα ή αναπηρία.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Επίπεδα πρόληψης. Αρχέγονη, πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη.. Δημιουργός: OpenStax, Population Health for Nurses. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/population-health/pages/2-5-levels-of-prevention.

04.04 — Υγεία, νόσος και κοινωνικοί προσδιοριστές

Η υγεία δεν περιορίζεται στην απουσία διαγνωσμένης νόσου. Επηρεάζεται από περιβάλλον, εισόδημα, εκπαίδευση, στέγαση, πρόσβαση σε υπηρεσίες, συνθήκες εργασίας και κοινωνικούς παράγοντες. Η δημόσια υγεία αξιολογεί κινδύνους και παρεμβάσεις σε επίπεδο πληθυσμού.

SOS · Η υγεία επηρεάζεται από βιολογικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Θεωρία & κατανόηση

Η γνώση αυτών των παραγόντων βοηθά τον διασώστη να επικοινωνεί χωρίς στερεότυπα και να αναγνωρίζει γιατί διαφορετικοί άνθρωποι έχουν άνισες δυνατότητες πρόληψης και πρόσβασης στη φροντίδα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Δημόσια υγεία = πληθυσμοί και πρόληψη, όχι μόνο μεμονωμένος ασθενής.

Πώς διαφέρει η δημόσια υγεία από την ατομική κλινική φροντίδα;

Εστιάζει στην υγεία πληθυσμών και στα μέτρα πρόληψης/προαγωγής.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η υγεία επηρεάζεται από γενετικούς, συμπεριφορικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Εισόδημα, εκπαίδευση, στέγαση και δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες μπορούν να επηρεάζουν αποτελέσματα υγείας. Οι ορισμοί νόσου και υγείας μεταβάλλονται ανά επιστημονικό πλαίσιο, αλλά στην προνοσοκομειακή πράξη προέχει πάντα η ασφαλής, μη στιγματιστική προσέγγιση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Έλλειψη στέγης και υγεία. Κοινωνικοί προσδιοριστές: στέγαση, διατροφή και έκθεση σε κινδύνους.. Δημιουργός: OpenStax, Population Health for Nurses. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/population-health/pages/8-1-economic-stability.

04.05 — Βασικές έννοιες επιδημιολογίας

Η επίπτωση περιγράφει νέα περιστατικά μιας νόσου σε συγκεκριμένο πληθυσμό και χρονικό διάστημα. Ο επιπολασμός περιγράφει το σύνολο των υπαρχόντων περιστατικών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή περίοδο. Η διάκριση βοηθά στην κατανόηση της εξάπλωσης και του βάρους νοσημάτων.

SOS · Επίπτωση = νέα περιστατικά σε περίοδο· επιπολασμός = όλα τα υπάρχοντα περιστατικά σε χρόνο/περίοδο.

Θεωρία & κατανόηση

Ο κίνδυνος συνδέεται με την πιθανότητα εμφάνισης συμβάντος, ενώ η συσχέτιση δεν αποδεικνύει πάντα αιτιότητα. Η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων είναι απαραίτητη για την επιτήρηση και τη λήψη αποφάσεων δημόσιας υγείας.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Επίπτωση: νέα περιστατικά· επιπολασμός: υπάρχοντα περιστατικά.

Ποιος δείκτης περιλαμβάνει τα νέα περιστατικά σε χρονική περίοδο;

Η επίπτωση.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η επίπτωση περιγράφει τα νέα περιστατικά σε ένα χρονικό διάστημα, ενώ ο επιπολασμός την παρουσία υπάρχοντων περιστατικών σε έναν πληθυσμό. Διαχωρίζουμε συσχέτιση από αιτιότητα και κατανοούμε ότι ένα ποσοστό χωρίς παρονομαστή μπορεί να παραπλανεί. Η επιδημιολογική ενημέρωση βοηθά στην κατανόηση της κατανομής κινδύνων, όχι στην αυτόματη διάγνωση κάθε περιστατικού.

Παραδείγματα με σωστό παρονομαστή

Αθροιστική επίπτωση (αναλογία νέων περιστατικών): από 1.000 άτομα χωρίς τη συγκεκριμένη νόσο στην αρχή ενός έτους, 20 εμφανίζουν νέα νόσο μέσα στο έτος. Η αναλογία είναι 20 / 1.000 × 100 = 2% στο συγκεκριμένο έτος . Δεν πρόκειται για ρυθμό ανά ανθρωποχρόνο.

Επιπολασμός σημείου: σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, 50 από 1.000 άτομα του πληθυσμού έχουν τη νόσο (παλαιά ή νέα περιστατικά). Ο επιπολασμός είναι 50 / 1.000 × 100 = 5% εκείνη την ημερομηνία .

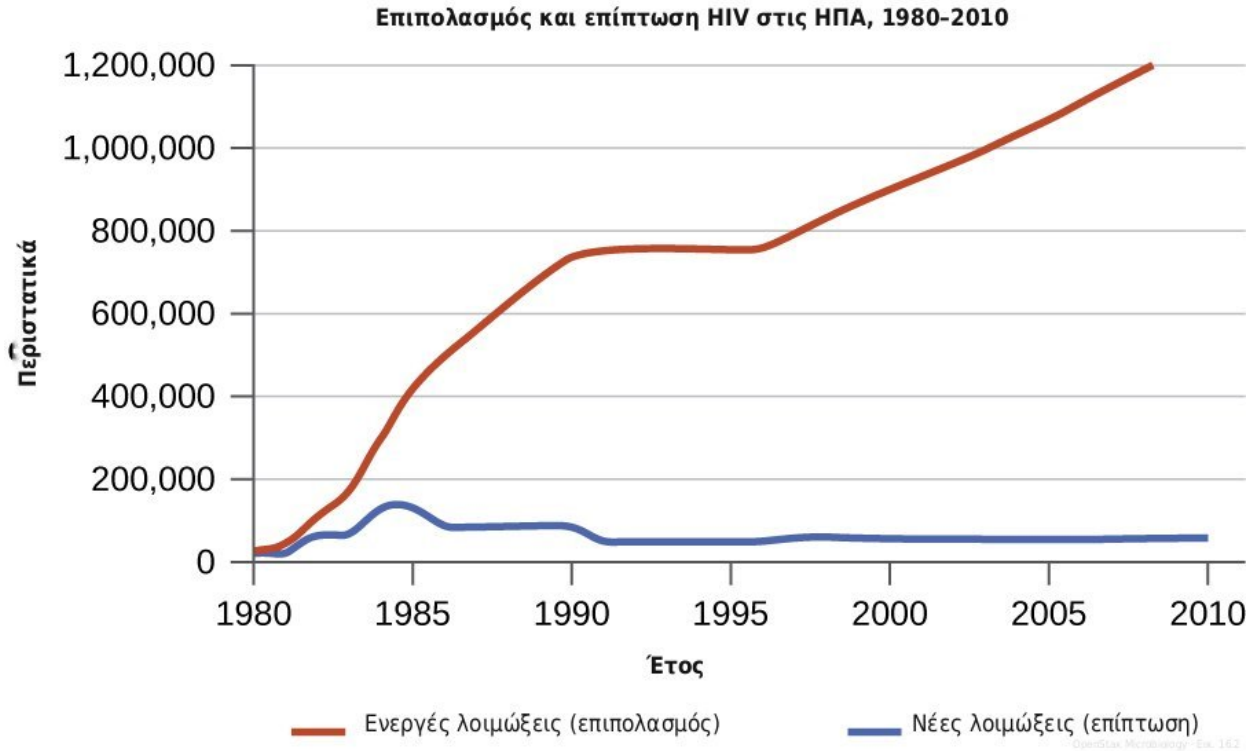
Άσκηση αυτοελέγχου

Αν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία 80 από 2.000 κατοίκους έχουν μια νόσο, ποιος είναι ο επιπολασμός σημείου;

80 / 2.000 × 100 = 4% . Ο αριθμητής και ο παρονομαστής πρέπει να αφορούν την ίδια χρονική στιγμή.

Πηγή ορισμών και μεθόδου: CDC — Principles of Epidemiology, Lesson 3 . Τα αριθμητικά παραδείγματα είναι συνθετικά, όχι πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Επίπτωση και επιπολασμός. Διαφορά νέων κρουσμάτων (επίπτωση) και συνολικών κρουσμάτων (επιπολασμός).. Δημιουργός: OpenStax, Microbiology (N. Parker κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/microbiology/pages/16-1-the-language-of-epidemiologists.

04.06 — Βακτήρια, ιοί και μύκητες

Τα βακτήρια είναι κυτταρικοί μικροοργανισμοί, ενώ οι ιοί χρειάζονται κύτταρα ξενιστή για να πολλαπλασιαστούν. Οι μύκητες έχουν διαφορετική κυτταρική οργάνωση και μπορεί να προκαλούν επιφανειακές ή συστηματικές λοιμώξεις.

SOS · Βακτήρια, ιοί και μύκητες είναι διαφορετικές κατηγορίες παθογόνων· τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν ιογενείς λοιμώξεις.

Θεωρία & κατανόηση

Η παρουσία μικροοργανισμών δεν ισοδυναμεί πάντοτε με ενεργό λοίμωξη. Διακρίνουμε αποικισμό, μόλυνση και κλινική λοίμωξη. Η αναγνώριση των οδών μετάδοσης καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας χωρίς αυθαίρετη χρήση αντιβιοτικών.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Τα αντιβιοτικά δεν αντιμετωπίζουν ιογενείς λοιμώξεις από μόνα τους.

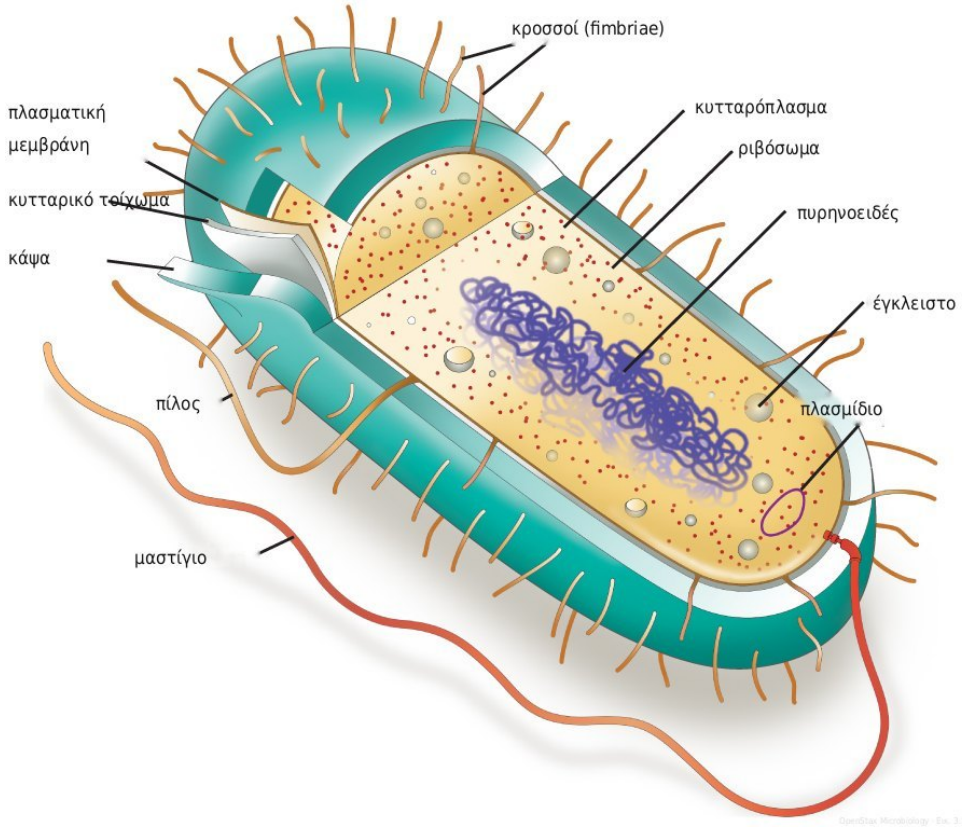
Ποια κατηγορία μικροοργανισμών απαιτεί κύτταρο ξενιστή για πολλαπλασιασμό;

Οι ιοί χρειάζονται ζωντανό κύτταρο ξενιστή για να πολλαπλασιαστούν, χρησιμοποιώντας τον κυτταρικό του μηχανισμό. Τα αντιβιοτικά δρουν στα βακτήρια και δεν θεραπεύουν ιογενείς λοιμώξεις.

Σε βάθος — επεξήγηση

Τα βακτήρια είναι κύτταρα χωρίς οργανωμένο πυρήνα, οι ιοί χρειάζονται ξενιστικά κύτταρα για πολλαπλασιασμό και οι μύκητες αποτελούν διαφορετική ομάδα οργανισμών. Η θεραπεία τους δεν είναι ίδια: για παράδειγμα αντιβιοτικά δεν αντιμετωπίζουν ιογενείς λοιμώξεις. Η αναγνώριση ατομικού κινδύνου έκθεσης δεν απαιτεί να προσδιορίζει ο διασώστης το ακριβές παθογόνο επιτόπου.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Τυπικό προκαρυωτικό κύτταρο (βακτήριο). Κυτταρικό τοίχωμα, κάψα, πυρηνοειδές, ριβοσώματα, μαστίγιο, πίλοι.. Δημιουργός: OpenStax, Microbiology (N. Parker κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/microbiology/pages/3-3-unique-characteristics-of-prokaryotic-cells.

04.07 — Υγιεινή χεριών και ατομική προστασία

Η υγιεινή χεριών είναι κεντρικό μέτρο πρόληψης λοιμώξεων. Η επιλογή αλκοολούχου αντισηπτικού ή πλυσίματος με νερό και σαπούνι εξαρτάται από την κατάσταση των χεριών και το είδος της πιθανής

έκθεσης. Η τεχνική πρέπει να καλύπτει όλες τις επιφάνειες των χεριών.

SOS · Υγιεινή χεριών πριν/μετά τη φροντίδα· γάντια δεν υποκαθιστούν την υγιεινή χεριών.

Θεωρία & κατανόηση

Γάντια, μάσκα, προστασία οφθαλμών και ποδιά επιλέγονται με βάση τον κίνδυνο, όχι μηχανικά σε κάθε περιστατικό. Τα γάντια δεν αντικαθιστούν την υγιεινή χεριών· η αφαίρεση των ΜΑΠ μπορεί επίσης να δημιουργήσει κίνδυνο επιμόλυνσης.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Πριν και μετά την επαφή με ασθενή εφαρμόζουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις.

Αν χρησιμοποιούμε γάντια, παραλείπουμε την υγιεινή χεριών;

Όχι. Τα γάντια δεν αντικαθιστούν την υγιεινή χεριών.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η υγιεινή χεριών είναι βασικό μέτρο πρόληψης, τόσο πριν όσο και μετά την επαφή με ασθενή ή μολυσμένες επιφάνειες, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες στιγμές. Γάντια δεν αντικαθιστούν τον καθαρισμό χεριών. Η επιλογή μάσκας, προστασίας οφθαλμών και ποδιάς εξαρτάται από εκτιμώμενο κίνδυνο, οδό μετάδοσης και τις ισχύουσες οδηγίες.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: ΠΟΥ · Πρόληψη λοιμώξεων .



Εικόνα: Χρήση μη αποστειρωμένων γαντιών. Βασικό μέτρο ατομικής προστασίας στη φροντίδα.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/6-2-asepsis-and-ppe.

04.08 — Καθαρισμός, απολύμανση, αποστείρωση

Ο καθαρισμός απομακρύνει ρύπους και οργανικό υλικό από μια επιφάνεια. Η απολύμανση μειώνει ή καταστρέφει πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς, ενώ η αποστείρωση έχει αυστηρότερο στόχο εξάλειψης βιώσιμων μικροοργανισμών σύμφωνα με τη μέθοδο και τις προδιαγραφές.

SOS · Καθαρισμός αφαιρεί ρύπους· απολύμανση μειώνει παθογόνα· αποστείρωση εξαλείφει βιώσιμους μικροοργανισμούς.

Θεωρία & κατανόηση

Η κατάλληλη διαδικασία εξαρτάται από το είδος του εξοπλισμού και τον κίνδυνο επαφής με ιστούς ή βλεννογόνους. Στο ασθενοφόρο ακολουθούμε οδηγίες κατασκευαστή και υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε σωστό χρόνο επαφής και δεν αναμειγνύουμε επικίνδυνα χημικά καθαριστικά.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Καθαρισμός ≠ απολύμανση ≠ αποστείρωση.

Ποια διαδικασία προηγείται συχνά της απολύμανσης;

Ο κατάλληλος καθαρισμός.

Σε βάθος — επεξήγηση

Ο καθαρισμός απομακρύνει ορατούς ρύπους και οργανικό φορτίο. Η απολύμανση μειώνει ή εξαλείφει μεγάλο μέρος παθογόνων σε επιφάνειες, ενώ η αποστείρωση αποσκοπεί στην καταστροφή όλων των μορφών μικροβιακής ζωής. Τα προϊόντα εφαρμόζονται με σωστή αραίωση και χρόνο επαφής σύμφωνα με τον κατασκευαστή και το πρωτόκολλο του φορέα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: ΠΟΥ · Πρόληψη λοιμώξεων .

Συνήθη πρωτόκολλα ελέγχου μικροβιακής ανάπτυξης			
Πρωτόκολλο	**Ορισμός**	**Συνήθης εφαρμογή**	**Συνήθεις παράγοντες**
Για άψυχα αντικείμενα			
Απολύμανση	Μειώνει ή καταστρέφει το μικροβιακό φορτίο άψυχου αντικειμένου με θερμότητα ή αντιμικροβιακά χημικά	Καθαρισμός επιφανειών, π.χ. πάγκων, κλινικών επιφανειών και χώρων υγιεινής	Χλωρίνη, φαινόλες, γλουταραλδεΰδη
Εξυγίανση	Μειώνει το μικροβιακό φορτίο άψυχου αντικειμένου σε ασφαλή για τη δημόσια υγεία επίπεδα, με θερμότητα ή αντιμικροβιακά χημικά	Πλύσιμο σκευών εστίασης, καθαρισμός δημόσιων χώρων υγιεινής	Απορρυπαντικά με φωσφορικά, βιομηχανικά καθαριστικά με τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου
Αποστείρωση	Εξαλείφει πλήρως όλα τα βλαστικά κύτταρα, τα ενδοσπόρια και τους ιούς από άψυχο αντικείμενο	Προετοιμασία χειρουργικού εξοπλισμού και βελόνων για ένεση	Ατμός υπό πίεση (κλίβανος), χημικά, ακτινοβολία
Για ζωντανό ιστό			
Αντισηψία	Μειώνει το μικροβιακό φορτίο σε δέρμα ή ιστό με αντιμικροβιακό χημικό	Καθαρισμός τραυματισμένου δέρματος· καθαρισμός δέρματος πριν από χειρουργείο	Βορικό οξύ, ισοπροπυλική αλκοόλη, υπεροξείδιο υδρογόνου, ιώδιο (betadine)
Απομάκρυνση μικροβίων	Μειώνει το μικροβιακό φορτίο σε δέρμα ή ιστό με ήπιο έως έντονο τρίψιμο και ήπια χημικά	Πλύσιμο χεριών	Σαπούνι, τολύπιο με αλκοόλη

Εικόνα: Απολύμανση, εξυγίανση, αποστείρωση, αντισηψία. Ορισμοί, εφαρμογές και συνήθεις παράγοντες για κάθε επίπεδο ελέγχου μικροβίων.. Δημιουργός: OpenStax, Microbiology (N. Parker κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/microbiology/pages/13-1-controlling-microbial-growth.

04.09 — Ανοσία και εμβολιασμός

Η φυσική ανοσία περιλαμβάνει φραγμούς όπως δέρμα και μη ειδικές αντιδράσεις. Η επίκτητη ανοσία αναπτύσσει πιο στοχευμένη αναγνώριση παθογόνων και ανοσολογική μνήμη. Τα αντισώματα παράγονται από κύτταρα του ανοσοποιητικού και συμμετέχουν στην άμυνα.

SOS · Η ενεργητική ανοσία αναπτύσσεται μετά από έκθεση ή εμβολιασμό· τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Θεωρία & κατανόηση

Ο εμβολιασμός προάγει ανοσολογική απόκριση χωρίς να απαιτείται η νόσηση από την ίδια τη λοίμωξη με τον συνήθη τρόπο. Οι συστάσεις διαφέρουν κατά ηλικία, ομάδα κινδύνου και ισχύον εθνικό πρόγραμμα. Στον χώρο εργασίας υγείας υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες προστασίας.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Έμφυτη και επίκτητη ανοσία είναι συμπληρωματικοί μηχανισμοί.

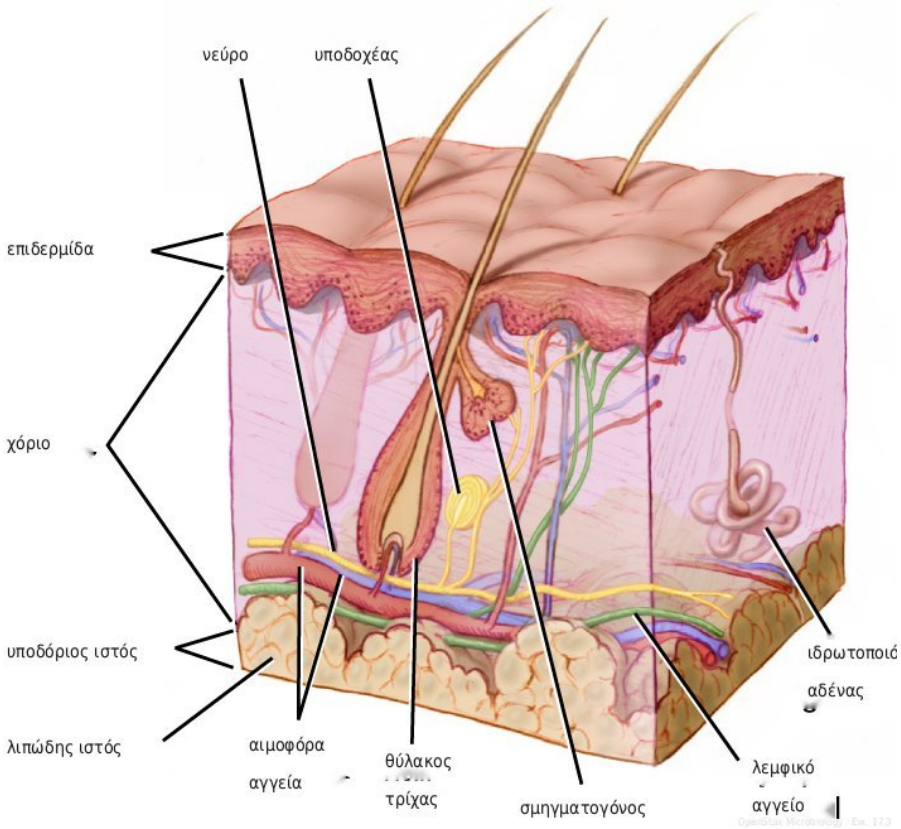
Τι επιδιώκει ο εμβολιασμός;

Να προκαλέσει προστατευτική ανοσολογική απόκριση και μνήμη.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η έμφυτη ανοσία αντιδρά γρήγορα σε πολλούς κινδύνους, ενώ η επίκτητη διαθέτει πιο εξειδικευμένη απόκριση και μνήμη. Ο εμβολιασμός συμβάλλει στην πρόληψη νόσων και στη μείωση σοβαρών επιπλοκών. Για τους επαγγελματίες υγείας τα ενδεδειγμένα εμβόλια και η παρακολούθησή τους καθορίζονται από επίσημες συστάσεις και την υπηρεσία εργασιακής υγείας.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Το δέρμα ως φυσικός φραγμός. Επιδερμίδα, χόριο και υποδόριος ιστός· φυσική ανοσία.. Δημιουργός: OpenStax, Microbiology (N. Parker κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/microbiology/pages/17-1-physical-defenses.

04.10 — Ασφαλής διαχείριση αιχμηρών και βιολογικών υλικών

Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να απορρίπτονται άμεσα σε κατάλληλους ανθεκτικούς περιέκτες, χωρίς επικίνδυνους χειρισμούς. Η έκθεση σε αίμα ή βιολογικά υγρά απαιτεί άμεση εφαρμογή της υπηρεσιακής διαδικασίας, αναφορά και κατάλληλη αξιολόγηση.

SOS · Αιχμηρά: άμεση απόρριψη σε ειδικό περιέκτη, χωρίς επανατοποθέτηση καλύμματος στη βελόνα.

Θεωρία & κατανόηση

Η αναγνώριση κινδύνου προηγείται της αφαίρεσης μολυσμένων υλικών. Η καθαριότητα του ασθενοφόρου μετά από περιστατικό είναι οργανωμένο μέρος της προνοσοκομειακής ασφάλειας και όχι προαιρετική εργασία.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ποτέ αυθαίρετος χειρισμός ή επανακάλυψη χρησιμοποιημένης βελόνας.

Πού απορρίπτονται οι χρησιμοποιημένες βελόνες;

Σε εγκεκριμένο άκαμπτο περιέκτη αιχμηρών.

Σε βάθος — επεξήγηση

Τα αιχμηρά απορρίπτονται αμέσως σε ειδικό ανθεκτικό δοχείο, ποτέ σε κοινή σακούλα απορριμμάτων. Τα μολυσματικά υλικά διαχειρίζονται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο διαχωρισμό αποβλήτων. Σε επαγγελματική έκθεση υπάρχει διαδικασία άμεσης αναφοράς, αξιολόγησης και παρακολούθησης από αρμόδιο φορέα. Δεν υποκαθιστούμε τις οδηγίες έκθεσης με συμβουλές από γενικό εκπαιδευτικό κείμενο.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: ΠΟΥ · Πρόληψη λοιμώξεων .



Εικόνα: Περιέκτης αιχμηρών αντικειμένων. Άμεση απόρριψη βελόνων σε ανθεκτικό περιέκτη, χωρίς υπερπλήρωση.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/6-4-infection-control-and-patient-safety.

05 · Εισαγωγή στην Προνοσοκομειακή Εκτίμηση και Υποστήριξη του Ασθενούς

05.01 — Ασφάλεια σκηνής — βασική εισαγωγή

Πριν την προσέγγιση αξιολογείται η ασφάλεια του χώρου, οι πιθανοί κίνδυνοι και η ανάγκη πρόσθετων μέσων. Η πρώτη εντύπωση περιλαμβάνει επίπεδο συνείδησης, ορατή δυσχέρεια αναπνοής, σοβαρή αιμορραγία και κατάσταση του περιβάλλοντος. Η επαγγελματική εκτίμηση ακολουθεί προκαθορισμένη δομή για να μειώνεται η πιθανότητα παράλειψης κρίσιμου ευρήματος.

SOS · Ασφάλεια χώρου και κατάλληλα ΜΑΠ προηγούνται κάθε προσέγγισης ασθενούς.

Αναλυτική κατανόηση

Πριν την προσέγγιση εντοπίζουμε κινδύνους από τροχαία κίνηση, καπνό, ρεύμα, βία και χημικές ουσίες. Καθορίζουμε ασφαλές σημείο στάθμευσης, εξόδους διαφυγής και ανάγκη επιπλέον δυνάμεων. Η αρχική εντύπωση συνθέτει επίπεδο συνείδησης, εμφανή αναπνευστική δυσχέρεια και μεγάλη αιμορραγία. Η προνοσοκομειακή προσέγγιση είναι δυναμική: αν κάτι αλλάξει, επιστρέφουμε στα κρίσιμα βήματα.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Ο διασώστης δεν εισέρχεται σε μη ασφαλές περιβάλλον μόνο και μόνο επειδή το περιστατικό φαίνεται επείγον.

Τι προηγείται της επαφής με τον ασθενή;

Η εκτίμηση ασφάλειας σκηνής και πληρώματος.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η εκτίμηση ξεκινά πριν πλησιάσουμε το περιστατικό: ελέγχουμε κυκλοφορία, ηλεκτρικούς κινδύνους, καπνό, χημικές ουσίες και πιθανούς παράγοντες βίας. Ακολουθεί σύντομη πρώτη εντύπωση: ανταπόκριση, εμφανής αναπνευστική δυσχέρεια και σοβαρή αιμορραγία. Ο μη ασφαλής χώρος δεν γίνεται ασφαλής επειδή υπάρχει επείγον ιατρικό περιστατικό. Καλούμε κατάλληλη υποστήριξη.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Τροχαίο: εκτίμηση ασφάλειας σκηνής. Πλήρωμα και πυροσβεστική σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα.. Δημιουργός: Dvermeirre. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MVA_Response_Welland_FD_Niagara_EMS_01.JPG.

05.02 — ABCDE — συνοπτική εισαγωγή

Το ABCDE οργανώνει την αξιολόγηση σε αεραγωγό (Airway), αναπνοή (Breathing), κυκλοφορία (Circulation), νευρολογική κατάσταση (Disability) και έκθεση/περιβάλλον (Exposure). Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε κατά προτεραιότητα απειλές για τη ζωή μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Στο σοβαρό τραύμα η καταστροφική εξωτερική αιμορραγία μπορεί να χρειάζεται άμεσο έλεγχο πριν από την υπόλοιπη ακολουθία.

SOS · ABCDE: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure· αντιμετωπίζουμε κάθε απειλή όταν εντοπίζεται.

Αναλυτική κατανόηση

Το ABCDE είναι δομημένη διαδικασία για να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε κατά σειρά απειλές ζωής: Α αεραγωγός, Β αναπνοή, C κυκλοφορία, D νευρολογική κατάσταση και Ε πλήρης έκθεση με προστασία από υποθερμία. Στο σοβαρό τραύμα η καταστροφική αιμορραγία μπορεί να προηγηθεί ως XABCDE (X = καταστροφική εξωτερική αιμορραγία). Δεν ολοκληρώνουμε μηχανικά ένα στάδιο αν μια άμεση απειλή απαιτεί ενέργεια ή κλήση βοήθειας.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Μετά από παρέμβαση ή επιδείνωση επαναλαμβάνουμε την πρωτογενή εκτίμηση. Τα φάρμακα και οι επεμβατικές πράξεις ακολουθούν τις επιτρεπόμενες αρμοδιότητες.

Πηγή: RCUK 2025 · Αρχική εκτίμηση/αιμορραγία ↗ (εκπαιδευτική επισήμανση).

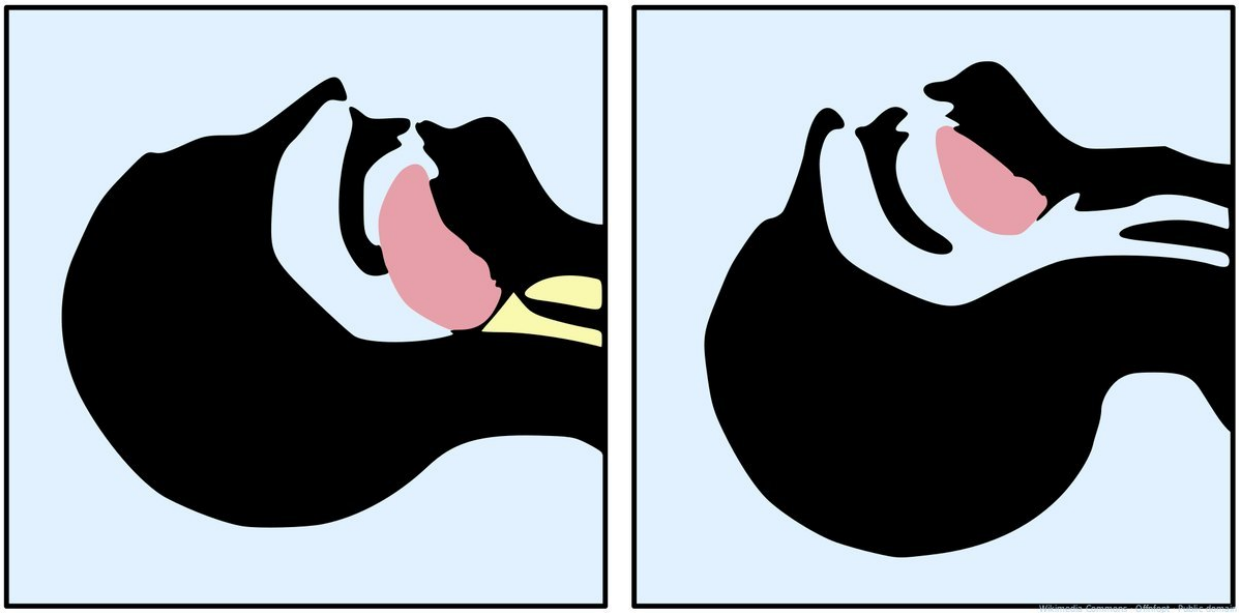
Τι αντιπροσωπεύει το D;

Disability — σύντομη νευρολογική εκτίμηση, όπως επίπεδο συνείδησης και άλλοι κρίσιμοι δείκτες.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η σειρά ABCDE είναι εργαλείο συστηματικής πρώτης εκτίμησης και επανεκτίμησης. Στην πράξη, εμφανής καταστροφική εξωτερική αιμορραγία μπορεί να αντιμετωπίζεται άμεσα βάσει εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου, χωρίς να αγνοούνται οι υπόλοιπες απειλές. Η προτεραιότητα καθορίζεται από την κατάσταση και τις ισχύουσες οδηγίες. Δεν περιμένουμε να ολοκληρώσουμε κάθε γράμμα πριν αναγνωρίσουμε ζωτικό κίνδυνο.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: Πρώτες βοήθειες 2025 .



Εικόνα: Απόφραξη αεραγωγού από τη γλώσσα (Α). Η γλώσσα πέφτει προς τα πίσω και κλείνει τον αεραγωγό· έκταση κεφαλής και ανύψωση γένειου.. Δημιουργός: Vassia Atanassova / Offnfopt. Άδεια: Public domain. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue_blocking_airway.svg.

05.03 — Ζωτικά σημεία — πρώτη γνωριμία

Καταγράφονται οι μεταβολές σε αναπνευστική συχνότητα, σφυγμό, αρτηριακή πίεση, επίπεδο συνείδησης, θερμοκρασία όταν απαιτείται και κορεσμό οξυγόνου, με γνώση των περιορισμών κάθε συσκευής. Η επανεκτίμηση είναι συνεχής διαδικασία, ιδιαίτερα όταν η κατάσταση αλλάζει ή μετά από παρέμβαση. Η τάση των τιμών μαζί με την κλινική εικόνα είναι σημαντικότερη από μεμονωμένο αριθμό.

SOS · Ζωτικά: αναπνοές, σφύξεις, πίεση, κορεσμός και άλλα ανά ένδειξη· μετράμε και ερμηνεύουμε σε συνάρτηση με την εικόνα.

Αναλυτική κατανόηση

Ζωτικά σημεία είναι, μεταξύ άλλων, η αναπνευστική συχνότητα, οι σφύξεις, η αρτηριακή πίεση, ο κορεσμός και η θερμοκρασία. Η συνείδηση και η περιφερική αιμάτωση συμπληρώνουν τη φυσιολογική εικόνα. Η ακριβής χρονική σήμανση αποτρέπει σύγχυση για το πότε άλλαξε η κατάσταση. Μια επιδεινούμενη τάση έχει συχνά μεγαλύτερη σημασία από ένα στιγμιαίο «καλό» αποτέλεσμα.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Κατέγραψε μέτρηση, ώρα, συνθήκες και ανταπόκριση σε ενέργειες. Αν μια τιμή είναι ασύμβατη με την κλινική εικόνα, επιβεβαίωσε τον αισθητήρα/τη μέτρηση χωρίς καθυστέρηση κρίσιμης βοήθειας.

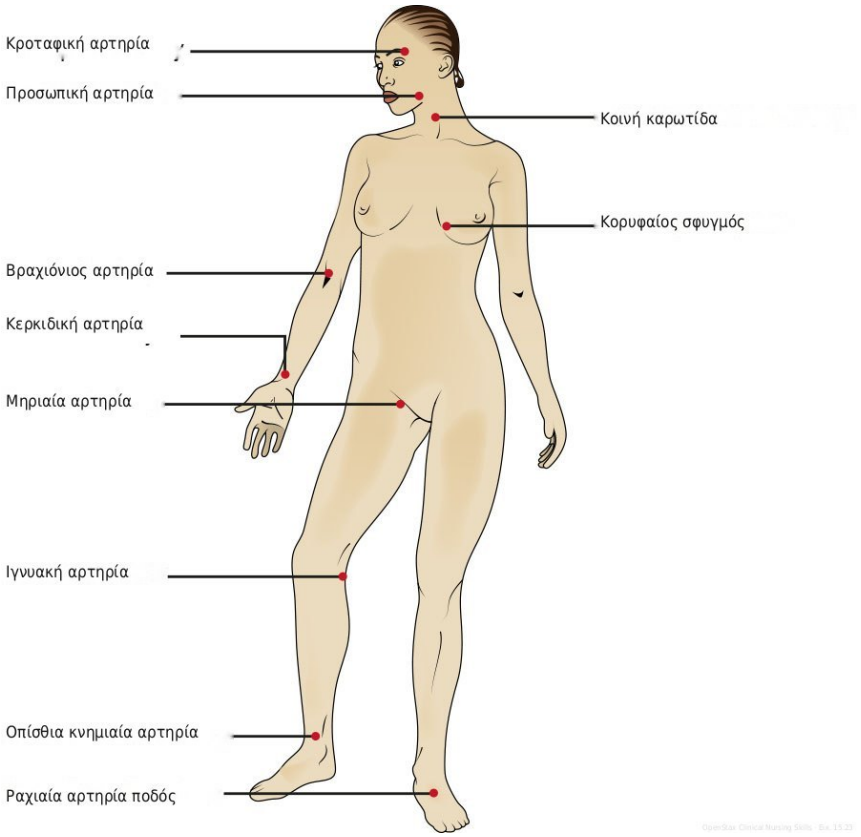
Γιατί ξαναμετράμε τα ζωτικά σημεία;

Για να ανιχνεύσουμε έγκαιρα βελτίωση ή επιδείνωση και να αξιολογήσουμε την ανταπόκριση.

Σε βάθος — επεξήγηση

Μετράμε και καταγράφουμε ζωτικά σημεία με σωστή τεχνική, αναφέροντας μονάδες και ώρα λήψης. Αξιολογούμε αναπνευστική συχνότητα, καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία όπου απαιτείται, κορεσμό και επίπεδο συνείδησης. Μια τιμή χωρίς κλινικό πλαίσιο ή χωρίς εξέλιξη στον χρόνο μπορεί να είναι παραπλανητική. Ορισμένες συσκευές έχουν περιορισμούς που πρέπει να αναγνωρίζουμε.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Σημεία ψηλάφησης σφυγμού. Κροταφική, καρωτίδα, βραχιόνιος, κερκιδική, μηριαία, ιγνυακή, οπίσθια κνημιαία, ραχιαία ποδός.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/15-5-heart-rate.

05.04 — Ιστορικό — αρχικό πλαίσιο

Η δομημένη λήψη ιστορικού μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία όπως SAMPLE (συμπτώματα, αλλεργίες, φάρμακα, παθήσεις, τελευταία λήψη τροφής/υγρών, γεγονότα) και OPQRST για τον πόνο. Στην παράδοση αναφέρονται τα κρίσιμα ευρήματα, οι χρόνοι, οι μετρήσεις, οι παρεμβάσεις και η ανταπόκριση. Οι συντομογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι κοινώς κατανοητές από την ομάδα.

SOS · Ιστορικό: τι συνέβη, πότε ξεκίνησε, συμπτώματα, αλλεργίες, φάρμακα, συνοδά νοσήματα και προηγούμενα γεγονότα.

Αναλυτική κατανόηση

Στο ιστορικό χρησιμοποιούμε δομημένες μνημονικές μεθόδους όπως SAMPLE: συμπτώματα, αλλεργίες, φάρμακα, παρελθόν, τελευταία πρόσληψη και γεγονότα. Στον πόνο το OPQRST βοηθά να περιγραφεί έναρξη, πρόκληση/ανακούφιση, χαρακτήρας, εντόπιση/αντανάκλαση, ένταση και χρόνος. Η παράδοση απαιτεί αναγνωριστικό, μηχανισμό ή κύριο σύμπτωμα, κρίσιμα ευρήματα, ζωτικά, χρονικά στοιχεία και τι

έγινε.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Η αξιόπιστη παράδοση είναι σύντομη, δομημένη και περιέχει όσα χρειάζεται αμέσως η επόμενη ομάδα, όχι ανεπεξέργαστες πολλές λεπτομέρειες.

Τι πληροφορία αναζητά το Α στο SAMPLE;

Αλλεργίες.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η συλλογή ιστορικού επικεντρώνεται στα κύρια συμπτώματα, τις αλλεργίες, τα φάρμακα, τις προηγούμενες παθήσεις, την τελευταία λήψη τροφής/υγρών και τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Στην παράδοση επικοινωνούμε αντικειμενικά τις μετρήσεις, τους χρονικούς δείκτες και τις ενέργειες που έγιναν. Δεν αποδίδουμε αυθαίρετα αιτίες όταν δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Λήψη ιστορικού και εκπαίδευση. Επίδειξη πρώτων βοηθειών και επικοινωνία με τον πάσχοντα.. Δημιουργός: State Government Photographer. Άδεια: CC0 1.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_aid_class(GN00053).jpg.

05.05 — Προσέγγιση σκηνής — αναλυτική αξιολόγηση

Η πρώτη εκτίμηση αρχίζει πριν αγγίξει κανείς τον ασθενή. Αναγνωρίζονται κίνδυνοι οδικής κυκλοφορίας, βίας, χημικής έκθεσης, ηλεκτρισμού, πυρκαγιάς και ασταθών κατασκευών. Παράλληλα αξιολογείται αν χρειάζονται πρόσθετες υπηρεσίες, μέσα ή πληρώματα.

SOS · Προσέγγιση: μέγεθος συμβάντος, αριθμός ασθενών, πρόσβαση, κίνδυνοι και απαιτούμενη συνδρομή.

Θεωρία & κατανόηση

Στη συνέχεια καταγράφονται αριθμός ασθενών, πιθανοί μηχανισμοί κάκωσης και αν η κατάσταση φαίνεται επείγουσα. Το πλήρωμα δεν εισέρχεται σε μη ασφαλή σκηνή για να εκτελέσει κλινικό χειρισμό χωρίς επαρκή έλεγχο του κινδύνου.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ασφάλεια σκηνής → αριθμός ασθενών → ανάγκη πρόσθετων πόρων → προσέγγιση.

Ποια αξιολόγηση προηγείται της προσέγγισης του ασθενούς;

Η ασφάλεια της σκηνής.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η πλήρης προσέγγιση περιλαμβάνει ασφάλεια, κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, ταυτοποίηση της ανάγκης και ενημέρωση του συντονισμού. Η συναίνεση όπου εφαρμόζεται και η ιδιωτικότητα αποτελούν μέρος της ασφαλούς φροντίδας. Η μετακίνηση ασθενούς σχεδιάζεται με βάση τον χώρο, τους κινδύνους και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Φόρτωση ασθενούς στο ασθενοφόρο. Οργανωμένη μεταφορά από τη σκηνή στο όχημα.. Δημιουργός: BorghettiElia. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loading_of_patient.jpg.

05.06 — Γρήγορη αναγνώριση απειλής για τη ζωή

Η αρχική οπτική εικόνα περιλαμβάνει θέση σώματος, προσπάθεια αναπνοής, χρώμα δέρματος, εμφανή αιμορραγία και ανταπόκριση σε λεκτική επαφή. Η αναγνώριση κινδύνου οδηγεί στην άμεση κλήση βοήθειας και στις κατάλληλες ενέργειες κατά την εκπαίδευση.

SOS · Άμεσες απειλές: απόφραξη αεραγωγού, ανεπαρκής αναπνοή, μαζική αιμορραγία, σοβαρή κυκλοφορική αστάθεια.

Θεωρία & κατανόηση

Η προτεραιότητα δεν είναι η πλήρης διάγνωση. Είναι η ανίχνευση προβλημάτων που μπορούν να προκαλέσουν ταχεία επιδείνωση, όπως διαταραχή αεραγωγού, μη φυσιολογική αναπνοή, ανεξέλεγκτη αιμορραγία ή σοβαρή διαταραχή συνείδησης.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Πρώτα απειλητικά σημεία — ύστερα αναλυτικό ιστορικό.

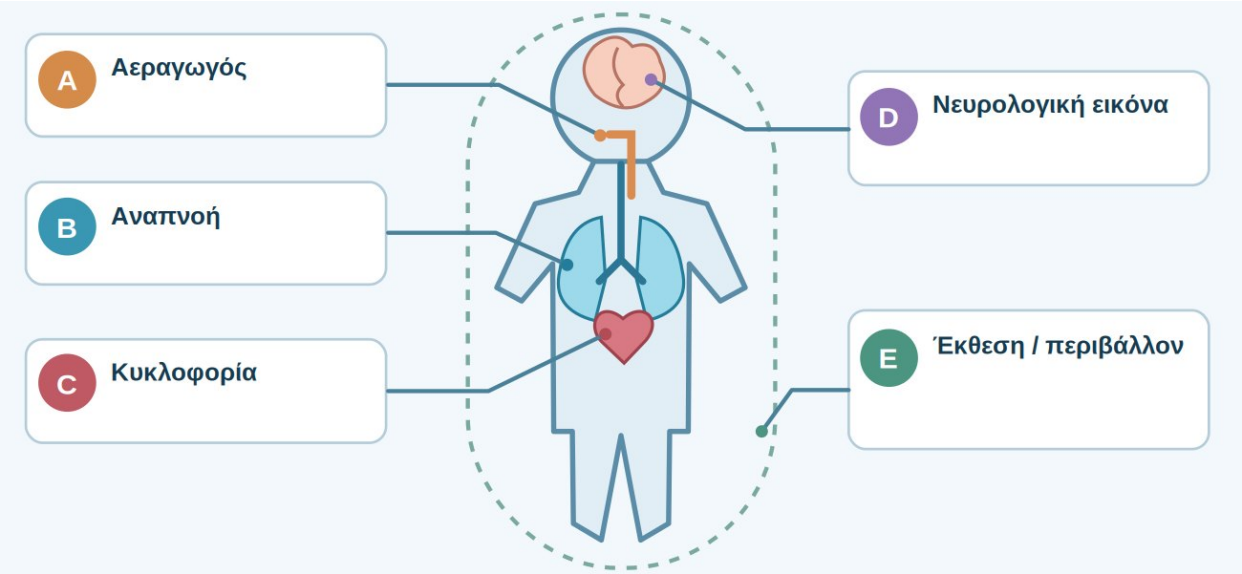
Ποιος είναι ο στόχος της πρώτης γρήγορης εκτίμησης;

Να εντοπιστούν άμεσες απειλές για τη ζωή.

Σε βάθος — επεξήγηση

Αναζητούμε αμέσως ενδείξεις όπως απουσία φυσιολογικής αναπνοής, μη ανταπόκριση, καταστροφική αιμορραγία και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Οι ενδείξεις αυτές απαιτούν ταχεία ενεργοποίηση του κατάλληλου πρωτοκόλλου. Οι περιγραφές σημείων είναι εκπαιδευτικές και δεν δίνουν άδεια για εκτέλεση επεμβατικών χειρισμών έξω από την εκπαίδευση και τις αρμοδιότητες.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Πρωτογενής εκτίμηση ABCDE: ανατομική επισκόπηση. Σχηματική ανθρώπινη μορφή με θέσεις εκτίμησης αεραγωγού, αναπνοής, κυκλοφορίας, νευρολογικής εικόνας και έκθεσης. Σε σοβαρό τραύμα η καταστροφική αιμορραγία μπορεί να προηγηθεί· ζητείται βοήθεια και γίνεται επανεκτίμηση. Εκπαίδευση και υπηρεσιακά πρωτόκολλα καθορίζουν τις επιτρεπόμενες πράξεις.. Δημιουργός: ΕΚΑΒ Σπουδή · πρωτότυπο εκπαιδευτικό διανυσματικό σχέδιο. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://www.resus.org.uk/professional-library/2025-resuscitation-guidelines/first-aid-guidelines.

05.07 — Πρωτογενής εκτίμηση ABCDE — αναλυτικά

Το ABCDE είναι οργανωμένος τρόπος επανειλημμένης εκτίμησης: Αεραγωγός (A), Αναπνοή (B), Κυκλοφορία (C), Νευρολογική κατάσταση (D), Έκθεση και περιβάλλον (E). Σε σοβαρό τραύμα, η καταστροφική εξωτερική αιμορραγία μπορεί να απαιτεί άμεση προτεραιότητα πριν από τα επόμενα βήματα.

SOS · Σε κάθε βήμα ABCDE αναγνώρισε/αντιμετώπισε την απειλή και επανέλεγξε από την αρχή αν επιδεινωθεί ο ασθενής.

Ασφάλεια σκηνής και αίτημα βοήθειας. Σε σοβαρό τραύμα με καταστροφική εξωτερική αιμορραγία: άμεσος έλεγχος της αιμορραγίας πριν από το ABCDE (X/<C>).

A: αεραγωγός και άμεσες απειλές.

B: αναπνοή, συχνότητα και έργο.

C: κυκλοφορία, αιμάτωση και λοιπές αιμορραγίες.

D: συνείδηση και νευρολογική εικόνα.

E: στοχευμένη έκθεση, αποφυγή υποθερμίας και επανεκτίμηση.

Εκπαιδευτικό πλαίσιο: πράξεις μόνο με αντίστοιχη εκπαίδευση και σύμφωνα με τις ισχύουσες υπηρεσιακές οδηγίες.

Θεωρία & κατανόηση

Η κλινική αξιολόγηση είναι κυκλική: μετά από παρέμβαση ο διασώστης επανεξετάζει την ανταπόκριση και επιστρέφει στην αρχή αν μεταβληθούν τα ευρήματα. Κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο εφόσον υπάρχει εκπαίδευση, ένδειξη και αντίστοιχη υπηρεσιακή αρμοδιότητα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

A: αεραγωγός · B: αναπνοή · C: κυκλοφορία · D: νευρολογική κατάσταση · E: έκθεση.

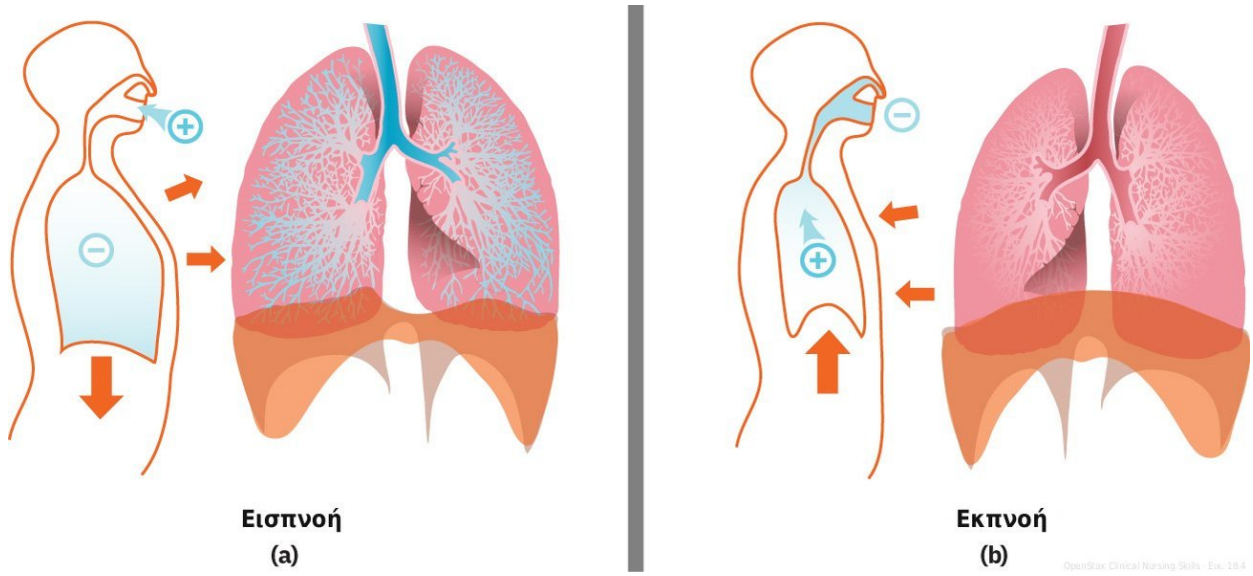
Τι σημαίνει το D στο ABCDE;

Disability — νευρολογική κατάσταση.

Σε βάθος — επεξήγηση

Στο A εξετάζεται η βατότητα του αεραγωγού, στο B η αναπνοή, στο C η κυκλοφορία, στο D η νευρολογική ανταπόκριση και στο E η επισκόπηση/έκθεση με προστασία θερμοκρασίας και ιδιωτικότητας. Η σειρά χρησιμεύει στην επικοινωνία της ομάδας, ενώ κάθε άμεσα αναγνωρισμένος κίνδυνος αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους τοπικούς κανόνες.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: Πρώτες βοήθειες 2025 .



Εικόνα: Εισπνοή και εκπνοή. Μεταβολές θωρακικής κοιλότητας και πίεσης κατά την αναπνοή (B).. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/18-1-respiratory-system.

05.08 — Αεραγωγός και αναπνευστική προσπάθεια

Ο αεραγωγός ελέγχεται για ομιλία, ήχους απόφραξης, ξένα σώματα και ενδείξεις ότι ο αέρας δεν περνά αποτελεσματικά. Η αναπνευστική εκτίμηση περιλαμβάνει συχνότητα, βάθος, συμμετρία, χρήση επικουρικών μυών και τυχόν ασυνήθιστους αναπνευστικούς ήχους.

SOS · Αεραγωγός: βατότητα, ήχοι, έργο αναπνοής και φυσιολογική ή μη αναπνοή, με υποστήριξη εντός αρμοδιοτήτων.

Θεωρία & κατανόηση

Δεν ταυτίζουμε την ύπαρξη αναπνευστικών κινήσεων με επαρκή αερισμό. Η παροχή οξυγόνου ή χρήση συσκευών αναπνευστικής υποστήριξης ακολουθεί τις ενδείξεις και τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Σε κατάρρευση χωρίς φυσιολογική αναπνοή εφαρμόζεται ο κατάλληλος αλγόριθμος αναζωογόνησης.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ανοιχτός αεραγωγός, επαρκής αερισμός και οξυγόνωση είναι διακριτοί έλεγχοι.

Μπορεί ασθενής να κινεί τον θώρακα αλλά να αερίζεται ανεπαρκώς;

Ναι. Η κίνηση του θώρακα δεν εγγυάται επαρκή αερισμό· ελέγχουμε τη βατότητα του αεραγωγού και την αποτελεσματικότητα της αναπνοής.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η δυνατότητα ομιλίας δίνει πληροφορίες για τον αεραγωγό, αλλά δεν αποκλείει μελλοντική επιδείνωση. Παρατηρούμε αναπνευστική συχνότητα, προσπάθεια, συμμετρία κινήσεων και παθολογικούς ήχους. Ένας ασθενής μπορεί να εμφανίζει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια χωρίς πολύ χαμηλό αρχικό κορεσμό. Παρατηρούμε τον άνθρωπο και όχι μόνο την ένδειξη ενός οργάνου.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Άνοιγμα αεραγωγού. Έκταση κεφαλής – ανύψωση γένειου σε αναίσθητο πάσχοντα.. Δημιουργός: Staff Sgt. Nathan Rivard (U.S. Army). Άδεια: Public domain. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opening_the_airway_150321-A-NB545-046.jpg.

05.09 — Κυκλοφορία, σφυγμός και αιμορραγία

Η εκτίμηση της κυκλοφορίας περιλαμβάνει σφυγμό, χρώμα και θερμοκρασία δέρματος, εμφανή αιμορραγία και γενική εικόνα αιμάτωσης. Η αρτηριακή πίεση αποτελεί χρήσιμη μέτρηση, αλλά δεν αποδεικνύει μόνη της ότι όλοι οι ιστοί αιματώνονται επαρκώς.

SOS · Κυκλοφορία: σφυγμός, δέρμα, τριχοειδική επαναπλήρωση, πίεση όπου ενδείκνυται και έλεγχος αιμορραγίας.

Θεωρία & κατανόηση

Σημαντική εξωτερική αιμορραγία αντιμετωπίζεται άμεσα σύμφωνα με την αντίστοιχη εκπαίδευση και πρωτόκολλο. Η επανεκτίμηση είναι ουσιώδης, επειδή τα αρχικά ζωτικά μπορεί να μεταβληθούν γρήγορα. Η σωστή ενημέρωση της ομάδας υποδοχής περιλαμβάνει χρόνο και ανταπόκριση σε παρεμβάσεις.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Σφυγμός, δέρμα, αιμορραγία, πίεση, επίπεδο συνείδησης.

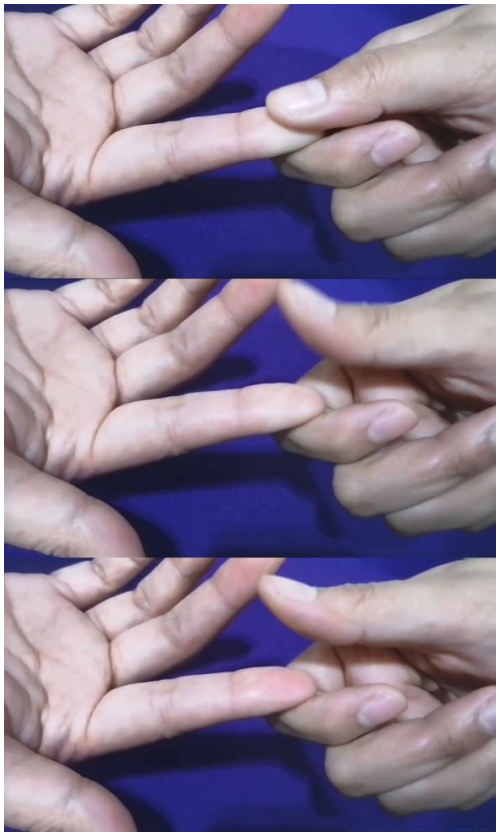
Αρκεί η φυσιολογική αρτηριακή πίεση για να αποκλείσουμε ανεπαρκή αιμάτωση;

Όχι. Φυσιολογική πίεση δεν αποκλείει πρώιμη καταπληξία· συνεκτιμούμε σφυγμό, δέρμα, συνείδηση και συνολική αιμάτωση.

Σε βάθος — επεξήγηση

Στη φάση C εξετάζονται εμφανής αιμορραγία, χαρακτηριστικά σφυγμού, δέρμα και άλλες ενδείξεις ανεπαρκούς αιμάτωσης. Η αρτηριακή πίεση είναι σημαντική αλλά δεν αποκλείει αρχική καταπληξία όταν βρίσκεται εντός φαινομενικά φυσιολογικών ορίων. Καταγράφουμε αλλαγές και εφαρμόζουμε μόνον τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της εκπαίδευσης και των οδηγιών.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών). Σχετική επιστημονική οδηγία: Πρώτες βοήθειες 2025 .



Εικόνα: Χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης. Έλεγχος αιμάτωσης με πίεση στο ακροδάκτυλο.. Δημιουργός: Thailand2021. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capillary_refill_test_on_index_finger_pulp..jpg.

05.10 — Επίπεδο συνείδησης και νευρολογική παρατήρηση

Η γρήγορη εκτίμηση της συνείδησης μπορεί να περιγραφεί με απλή δομημένη κλίμακα ανταπόκρισης και, όταν χρειάζεται, πιο αναλυτικά με GCS. Παρατηρούνται επίσης κινητικότητα, ομιλία, συμμετρία προσώπου και οξύτητα μεταβολής συμπτωμάτων.

SOS · Συνείδηση: AVPU ή κατάλληλη κλίμακα, κόρες, νέα εστιακά σημεία και γλυκόζη όπου ενδείκνυται.

Θεωρία & κατανόηση

Η γλυκόζη αίματος είναι χρήσιμη μέτρηση σε ορισμένες διαταραχές συνείδησης, σύμφωνα με την εκπαίδευση και τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Ένα νευρολογικό εύρημα αποκτά σημασία όταν καταγράφεται μαζί με χρόνο έναρξης ή τελευταία φορά που ο ασθενής ήταν καλά.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Ο χρόνος εμφάνισης νευρολογικών συμπτωμάτων είναι κρίσιμη πληροφορία.

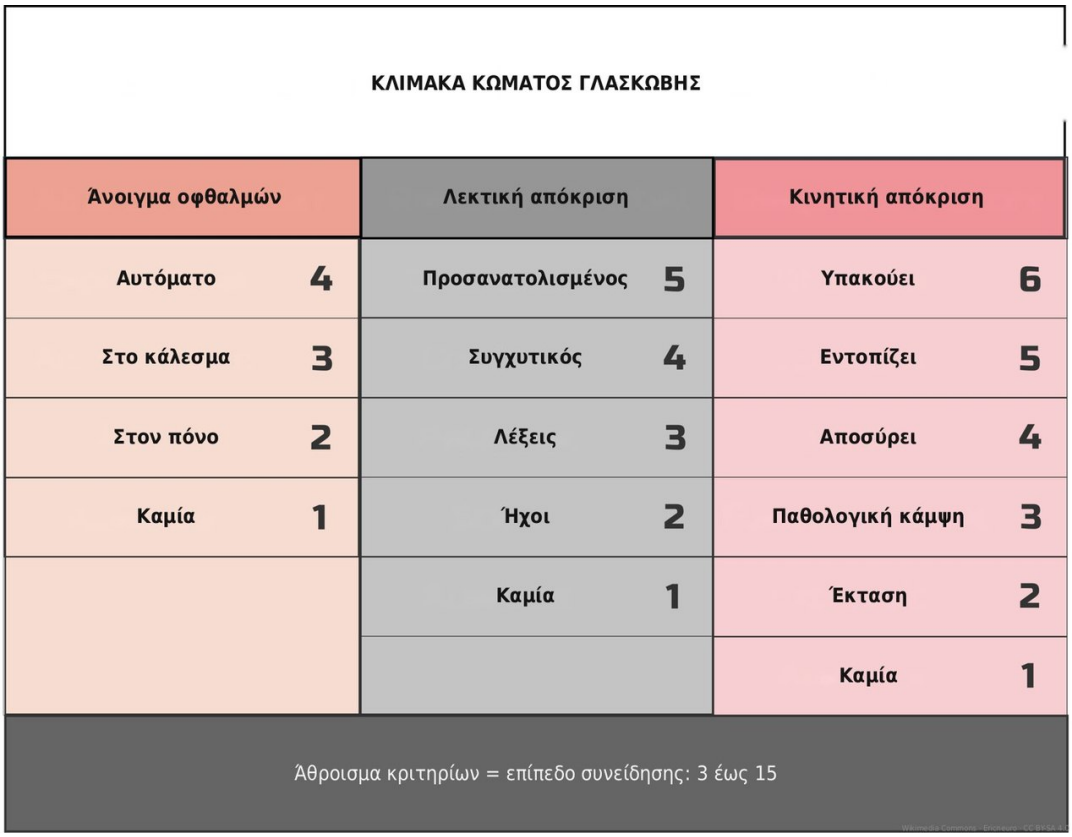
Γιατί καταγράφουμε πότε ο ασθενής ήταν τελευταία φορά καλά;

Επειδή ο χρόνος βοηθά στην επείγουσα αξιολόγηση και στην επιλογή κατάλληλης αντιμετώπισης.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η αξιολόγηση D αφορά ανταπόκριση, προσανατολισμό, συμμετρία κινήσεων και άλλες βασικές νευρολογικές παρατηρήσεις. Η AVPU βοηθά στη γρήγορη περιγραφή ανταπόκρισης, ενώ η κλίμακα Γλασκώβης έχει συγκεκριμένα επιμέρους στοιχεία. Κανένα σκορ μόνο του δεν αποκαλύπτει την αιτία διαταραχής συνείδησης. Η μεταβολή σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις αποτελεί κρίσιμη πληροφορία.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Κλίμακα κώματος Γλασκώβης (GCS). Άνοιγμα οφθαλμών, λεκτική και κινητική απόκριση· άθροισμα 3–15.. Δημιουργός: Ericneuro. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escala_de_Coma_de_Glasgow_-_ECG.png.

05.11 — Ζωτικά σημεία — μεθοδολογία και τεκμηρίωση

Στα ζωτικά σημεία περιλαμβάνονται συνήθως αναπνευστική και καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία και κορεσμός οξυγόνου όπου ενδείκνυται. Η σημασία τους εξαρτάται από ηλικία, κλινική εικόνα και διαχρονικές μεταβολές.

SOS · Τα ζωτικά καταγράφονται με ώρα και επαναλαμβάνονται· η τάση μετρήσεων συχνά έχει μεγαλύτερη σημασία από μία τιμή.

Θεωρία & κατανόηση

Η σωστή μέτρηση απαιτεί κατάλληλη τεχνική, θέση και συσκευή. Ένας ασυνήθιστος αριθμός πρέπει να ελεγχθεί σε συνάρτηση με την κατάσταση του ασθενούς και, όταν είναι δυνατό, να επιβεβαιωθεί. Η ώρα κάθε μέτρησης καταγράφεται ώστε να αναγνωρίζεται η εξέλιξη.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Μια διαδοχική τάση ζωτικών μπορεί να είναι σημαντικότερη από μια μεμονωμένη τιμή.

Γιατί σημειώνουμε την ώρα κάθε μέτρησης;

Για να παρακολουθούμε την εξέλιξη και την ανταπόκριση του ασθενούς.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η συστηματική καταγραφή περιλαμβάνει ώρα, τιμή, συνθήκες μέτρησης, αλλαγές και τυχόν περιορισμούς. Τα ζωτικά σημεία δεν χαρακτηρίζονται αυθαίρετα «καλά» χωρίς ηλικία, κλινική εικόνα και ιστορικό. Τα

ασύρματα ή φορητά όργανα χρειάζονται κατάλληλη χρήση και επαλήθευση ασυνήθιστων ενδείξεων όταν είναι εφικτό. Τεκμηριώνουμε και την κλινική εικόνα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Μέτρηση πίεσης με χειροκίνητο πιεσόμετρο. Σφυγμομανόμετρο και στηθοσκόπιο κατά την τεκμηρίωση ζωτικών σημείων.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/15-1-performing-a-general-survey.

05.12 — Λήψη ιστορικού — δομή SAMPLE

Σε ασθενή που μπορεί να επικοινωνήσει, το ιστορικό περιλαμβάνει συμπτώματα, αλλεργίες, φάρμακα, προηγούμενα νοσήματα, πρόσφατη λήψη τροφής ή υγρών και γεγονότα πριν από το επεισόδιο. Το SAMPLE αποτελεί μνημονικό βοήθημα για τη συστηματική συλλογή αυτών των πληροφοριών.

SOS · SAMPLE: Symptoms, Allergies, Medications, Past history, Last oral intake, Events.

Θεωρία & κατανόηση

Οι πληροφορίες από μάρτυρες ή συνοδούς μπορεί να είναι σημαντικές όταν ο ασθενής δεν επικοινωνεί. Η λήψη ιστορικού δεν πρέπει να καθυστερεί κρίσιμες ενέργειες. Οι απαντήσεις καταγράφονται με ακρίβεια και δεν αναδιατυπώνονται ως βεβαιότητες όταν προέρχονται από αβέβαιη μαρτυρία.

Βασικό σημείο για επανάληψη

S: συμπτώματα · A: αλλεργίες · M: φάρμακα · P: προηγούμενο ιστορικό · L: τελευταία πρόσληψη · E: γεγονότα.

Τι σημαίνει το A στο SAMPLE;

Allergies — αλλεργίες.

Σε βάθος — επεξήγηση

Το SAMPLE είναι μνημονικό για Signs/Symptoms, Allergies, Medications, Past history, Last oral intake και Events. Λειτουργεί ως υπενθύμιση, όχι ως άκαμπτο ερωτηματολόγιο που προηγείται κάθε επείγουσας παρέμβασης. Το περιεχόμενο συλλέγεται από τον ασθενή, συνοδούς ή διαθέσιμα αρχεία με επίγνωση των περιορισμών αξιοπιστίας.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Μελέτη ιστορικού πριν την εκτίμηση. Ο φάκελος και οι πληροφορίες του ασθενούς ως μέρος του SAMPLE.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/4-2-data-collection-and-documentation.

05.13 — Εκτίμηση πόνου και OPQRST

Η διερεύνηση πόνου μπορεί να οργανωθεί με τα χαρακτηριστικά έναρξης, επιδείνωσης/ανακούφισης, ποιότητας, εντόπισης/αντανάκλασης, έντασης και χρόνου. Το OPQRST είναι εκπαιδευτικό μνημονικό για τη συστηματική ερώτηση αυτών των στοιχείων.

SOS · OPQRST: Onset, Provocation, Quality, Radiation/Region, Severity, Time — δομημένη εκτίμηση πόνου.

Θεωρία & κατανόηση

Η ένταση του πόνου είναι υποκειμενική και μπορεί να εκτιμηθεί με κατάλληλη κλίμακα, όπως 0–10, όταν είναι εφαρμόσιμο. Ο σοβαρός πόνος δεν είναι από μόνος του συγκεκριμένη διάγνωση. Συνοδεύεται από γενική εκτίμηση και τεκμηρίωση των σχετικών ευρημάτων.

Βασικό σημείο για επανάληψη

OPQRST οργανώνει την περιγραφή του πόνου, δεν επιβεβαιώνει διάγνωση.

Γιατί εξετάζουμε αν ο πόνος αντανακλά σε άλλη περιοχή;

Επειδή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κλινικής περιγραφής και αξιολόγησης.

Σε βάθος — επεξήγηση

Με το OPQRST οργανώνουμε περιγραφή έναρξης, παραγόντων που προκαλούν ή ανακουφίζουν, ποιότητας, περιοχής/αντανάκλασης, έντασης και χρονικής εξέλιξης του πόνου. Η ένταση είναι υποκειμενική και δεν αντικαθιστά την εκτίμηση άλλων ευρημάτων. Σε ασθενή που δεν μπορεί να επικοινωνήσει χρειάζονται κατάλληλες μέθοδοι παρατήρησης και περαιτέρω κλινική αξιολόγηση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Κλίμακα πόνου με πρόσωπα. Αριθμητική κλίμακα 0–10 με εικόνες προσώπων.. Δημιουργός: Belbury. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wong-Baker_scale_with_emoji.png.

05.14 — Επανεκτίμηση και ασφαλής διακομιδή

Η εκτίμηση δεν ολοκληρώνεται στο πρώτο σύνολο ζωτικών σημείων. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μετά από χειρισμό ή με την εξέλιξη της νόσου. Γι’ αυτό επαναλαμβάνεται η συστηματική εξέταση σε διαστήματα που καθορίζονται από τη βαρύτητα και τα πρωτόκολλα.

SOS · Η επανεκτίμηση και η έγκαιρη διακομιδή είναι συνεχής διαδικασία, ιδίως σε ασταθή ασθενή.

Θεωρία & κατανόηση

Η επιλογή μονάδας υποδοχής, η επικοινωνία και η καταγραφή είναι μέρος της φροντίδας. Το πλήρωμα μεταφέρει με ασφαλή τρόπο τον ασθενή και τον παραδίδει με σαφές ιστορικό, χρονική αλληλουχία, ευρήματα, παρεμβάσεις και αλλαγές.

Βασικό σημείο για επανάληψη

Εκτίμηση → ενέργεια → επανεκτίμηση → επικοινωνία/παράδοση.

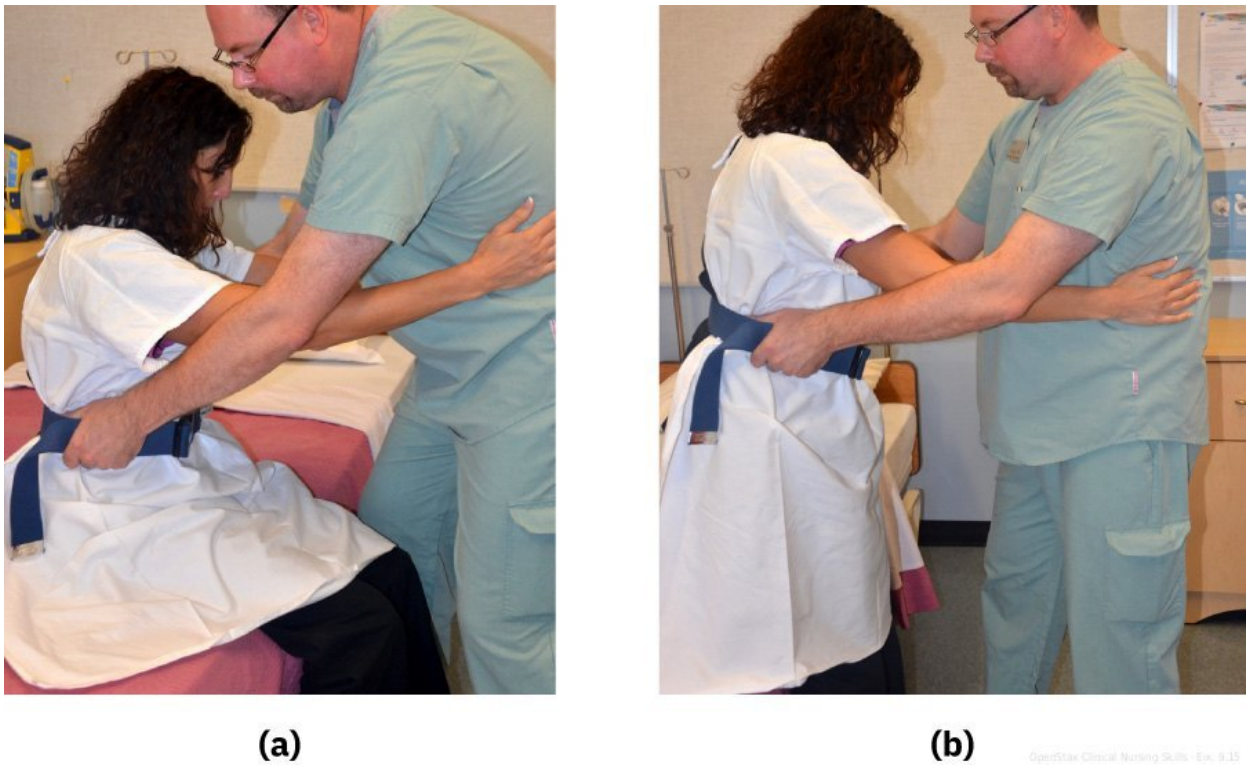
Πότε πρέπει να επαναληφθεί η εκτίμηση;

Όταν αλλάζει η εικόνα και κατά τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα του πρωτοκόλλου.

Σε βάθος — επεξήγηση

Η επανεκτίμηση γίνεται όταν αλλάζει η κατάσταση, μετά από ενέργειες ή σε κατάλληλα διαστήματα βάσει πρωτοκόλλου. Κατά τη μεταφορά εξετάζεται ξανά η ασφάλεια εξοπλισμού και ασθενούς. Στην παράδοση μεταφέρονται οι αρχικές και νεότερες μετρήσεις, σημαντικά γεγονότα και παρεμβάσεις. Η έγκαιρη αναγνώριση επιδείνωσης είναι εξίσου σημαντική με την αρχική εκτίμηση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Μεταφορά με ζώνη βάδισης. Ασφαλής μετακίνηση με στήριξη και σωστή στάση.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/9-3-transferring-patients.

06 · Βασική Αγγλική Ορολογία Προνοσοκομειακής Φροντίδας

06.01 — Ζωτικά σημεία – vital signs

Airway = αεραγωγός, Breathing = αναπνοή, Circulation = κυκλοφορία, Pulse = σφυγμός, Blood pressure = αρτηριακή πίεση, Oxygen saturation = κορεσμός οξυγόνου, Respiratory rate = αναπνευστική συχνότητα. Οι αγγλικοί όροι εμφανίζονται στην οθόνη συσκευών, στη βιβλιογραφία και σε διεθνή πρωτόκολλα· ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει τη σωστή ελληνική τους απόδοση.

SOS · Vital signs = ζωτικά σημεία· respiratory rate = αναπνευστική συχνότητα· oxygen saturation = κορεσμός O_2.

Αναλυτική κατανόηση

Οι συχνότεροι αγγλικοί όροι μετρούνται και γράφονται με σωστές μονάδες: heart rate (καρδιακή συχνότητα), respiratory rate (αναπνευστική συχνότητα), blood pressure (αρτηριακή πίεση), oxygen saturation (κορεσμός O_2), body temperature (θερμοκρασία). Η φράση “rate” μόνη της δεν προσδιορίζει ποια παράμετρο μετρήθηκε.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Σε διεθνή επικοινωνία προτίμησε πλήρη σαφή όρο και αριθμό με μονάδα, όχι ασαφή συντομογραφία.

Πώς αποδίδεται «αναπνευστική συχνότητα» στα αγγλικά;

Respiratory rate.

Σε βάθος — επεξήγηση

Injury σημαίνει κάκωση, examination εξέταση, complaint αναφερόμενο σύμπτωμα και findings ευρήματα. Οι λέξεις δεξιά/αριστερά γράφονται right/left, ενώ η διαφορά pulse και heart rate χρειάζεται προσοχή ανάλογα με τη συσκευή και το συμφραζόμενο. Στην αναφορά εκφωνούμε σαφώς αριθμούς, μονάδες και ώρες, ώστε να περιορίζονται λάθη μεταφοράς.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Vital signs — ζωτικά σημεία. Μόνιτορ ζωτικών σημείων με αγγλική και ελληνική ονομασία.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/15-3-vital-signs.

06.02 — Συμπτώματα και ερωτήσεις

Chest pain = θωρακικός πόνος, Shortness of breath = δύσπνοια, Dizziness = ζάλη, Nausea = ναυτία, Allergy = αλλεργία, Unconscious = χωρίς συνείδηση. Η ερώτηση “Are you allergic to any medication?” σημαίνει «Έχετε αλλεργία σε κάποιο φάρμακο;». Η σαφής, σύντομη επικοινωνία είναι πιο χρήσιμη από σύνθετες εκφράσεις.

SOS · Chest pain = θωρακικός πόνος· shortness of breath = δύσπνοια· unconscious = χωρίς συνείδηση.

Αναλυτική κατανόηση

Το “shortness of breath” περιγράφει αίσθημα δύσπνοιας, το “chest pain” θωρακικό πόνο και το “dizziness” ζάλη. Άλλες χρήσιμες εκφράσεις είναι “When did it start?” (Πότε άρχισε;), “Do you have allergies?” (Έχετε αλλεργίες;) και “Are you taking any medication?” (Παίρνετε φάρμακα;).

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Σε επικοινωνία με περιορισμένα ελληνικά μίλα αργά, χρησιμοποίησε μικρές ερωτήσεις και έλεγξε ότι κατάλαβες τη σωστή απάντηση.

Τι σημαίνει “chest pain”;

Πόνος στο στήθος.

Σε βάθος — επεξήγηση

«Where does it hurt?» σημαίνει «Πού πονάτε;», «When did it start?» «Πότε άρχισε;» και «Are you allergic to any medicines?» «Έχετε αλλεργία σε φάρμακα;». Χρησιμοποιούμε σύντομες, κατανοητές ερωτήσεις και επιβεβαιώνουμε το νόημα. Η απλή μετάφραση δεν ισοδυναμεί πάντοτε με επαρκή επικοινωνία σε

επείγουσες καταστάσεις.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Pain — πόνος. Σωματικά σημεία πόνου και η αγγλική ορολογία.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/16-4-pain-assessment.

06.03 — Ασφάλεια και μεταφορά

Ambulance = ασθενοφόρο, Stretcher = φορείο, Seat belt = ζώνη ασφαλείας, Scene safety = ασφάλεια σκηνής, Handover = παράδοση ασθενούς, Emergency department = Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Προσοχή σε ψευδόφιλες λέξεις και συντομογραφίες: η σωστή μετάφραση πρέπει να εξαρτάται από το κλινικό συμφραζόμενο.

SOS · Scene safety = ασφάλεια σκηνής· stretcher = φορείο· handover = παράδοση ασθενούς.

Αναλυτική κατανόηση

Οι όροι “scene safety”, “stretcher”, “spinal precautions”, “handover” και “transport” μεταφράζονται ασφάλεια σκηνής, φορείο, προφυλάξεις σπονδυλικής στήλης, παράδοση πληροφοριών και διακομιδή. Η κατανόηση της ορολογίας δεν αντικαθιστά την εφαρμογή των τοπικών πρωτοκόλλων.

Σύνδεση με το έργο του διασώστη

Οι συντομογραφίες μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα· βεβαιώσου ότι όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο νόημα.

Τι σημαίνει “handover”;

Παράδοση κλινικών πληροφοριών και ευθύνης στην επόμενη ομάδα.

Σε βάθος — επεξήγηση

«Keep the area clear» σημαίνει «Αφήστε τον χώρο ελεύθερο» και «We are taking you to hospital» «Σας μεταφέρουμε στο νοσοκομείο». «Ambulance» είναι ασθενοφόρο, «stretcher» φορείο και «seat belt» ζώνη ασφαλείας. Για επικίνδυνες καταστάσεις η ομάδα εφαρμόζει τα επίσημα επιχειρησιακά πρωτόκολλα αντί για αυτοσχέδιες μεταφρασμένες εντολές.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Stretcher — φορείο. Φόρτωση ασθενούς· αγγλική ορολογία μεταφοράς.. Δημιουργός: BorghettiElia. Άδεια: CC BY-SA 4.0. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loading_of_patient.jpg.

06.04 — Ανατομικές κατευθύνσεις – English terms

Οι ανατομικοί όροι συχνά εμφανίζονται σε διεθνή εκπαιδευτικά κείμενα. Anterior σημαίνει πρόσθιος, posterior οπίσθιος, superior ανώτερος, inferior κατώτερος, medial έσω και lateral έξω. Right/left περιγράφουν την πλευρά του ασθενούς και όχι του παρατηρητή.

SOS · Anterior/posterior = πρόσθιος/οπίσθιος· medial/lateral = έσω/έξω· distal/proximal = άπω/εγγύς.

Θεωρία & κατανόηση

Proximal είναι πλησιέστερα στον κορμό ή στην αρχή δομής, distal πιο μακριά. Η κατανόηση των όρων επιτρέπει να διαβάζουμε διεθνείς οδηγίες χωρίς να αντικαθιστούμε την επίσημη ελληνική ορολογία στην επικοινωνία της υπηρεσίας.

Βασικό σημείο για επανάληψη

anterior/πρόσθιο, posterior/οπίσθιο, medial/έσω, lateral/έξω.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Για τις κατευθύνσεις χρησιμοποιούμε anterior = πρόσθιος, posterior = οπίσθιος, superior = ανώτερος, inferior = κατώτερος, medial = έσω, lateral = έξω. Το right και left αναφέρονται πάντοτε στον ασθενή. Εκπαιδευτική εφαρμογή: «pain in the right lower abdomen» αποδίδεται «πόνος στο δεξιό κάτω μέρος της κοιλιάς», όχι «αριστερά όπως το κοιτώ». Η σαφής πλευρά είναι κρίσιμη στην παράδοση περιστατικού.

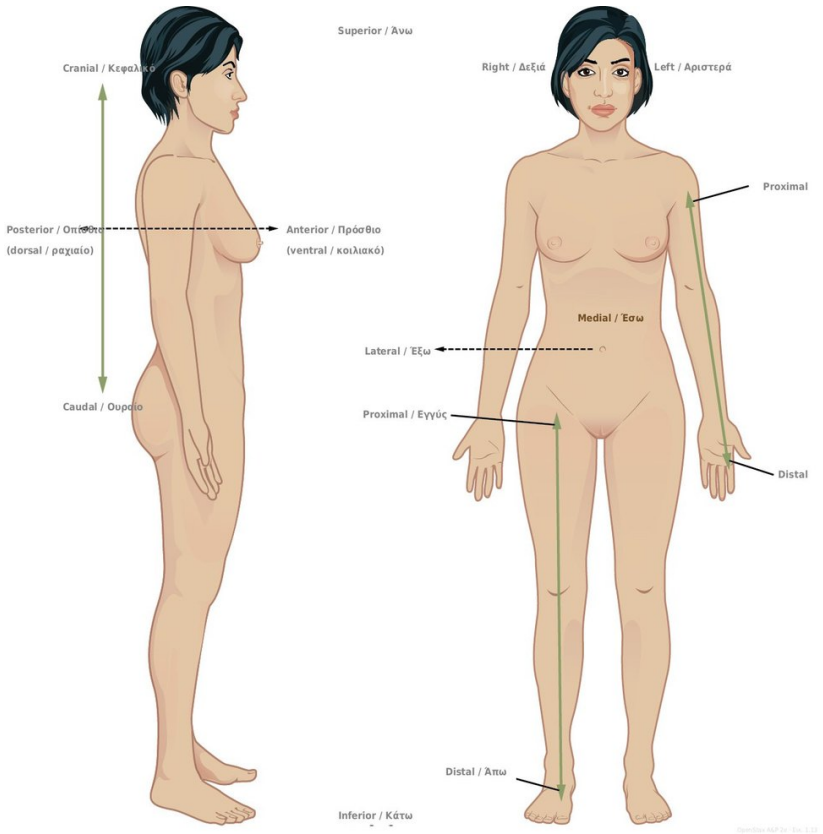
Πώς μεταφράζεται το distal;

Περιφερικό / μακρύτερα από το σημείο αναφοράς.

Σε βάθος — επεξήγηση

Anterior/posterior σημαίνουν πρόσθιος/οπίσθιος, medial/lateral έσω/έξω και proximal/distal εγγύς/άπω. «Left forearm» σημαίνει αριστερό αντιβράχιο και «right lower leg» δεξιά κνήμη. Οι ανατομικοί όροι είναι ανεξάρτητοι από το πού στέκεται ο διασώστης: αναφέρονται στο σώμα του ασθενούς.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Directional terms — ανατομικές κατευθύνσεις. Superior/inferior, anterior/posterior, medial/lateral, proximal/distal.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-6-anatomical-terminology.

06.05 — Οστά και αρθρώσεις – terminology

Skull σημαίνει κρανίο, spine σπονδυλική στήλη, rib πλευρά, sternum στέρνο και pelvis πύελος. Humerus είναι βραχιόνιο, radius κερκίδα, ulna ωλένη, femur μηριαίο, tibia κνήμη και fibula περόνη.

SOS · Humerus = βραχιόνιο· radius = κερκίδα· ulna = ωλένη· femur = μηριαίο.

Θεωρία & κατανόηση

Joint σημαίνει άρθρωση, ligament σύνδεσμος, tendon τένοντας, muscle μυς. Στην πρακτική περιγραφή, fracture σημαίνει κάταγμα και dislocation εξάρθρημα. Δεν ταυτίζουμε τις δύο έννοιες.

Βασικό σημείο για επανάληψη

femur/μηριαίο, tibia/κνήμη, fibula/περόνη.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Στην περιγραφή οστών, humerus είναι το βραχιόνιο, radius η κερκίδα, ulna η ωλένη, femur το μηριαίο και pelvis η πύελος. Joint σημαίνει άρθρωση και fracture κάταγμα. Παράδειγμα: «suspected fracture of the left forearm» σημαίνει «υποψία κατάγματος αριστερού αντιβραχίου». Ο όρος suspected δείχνει υποψία, όχι βέβαιη διάγνωση.

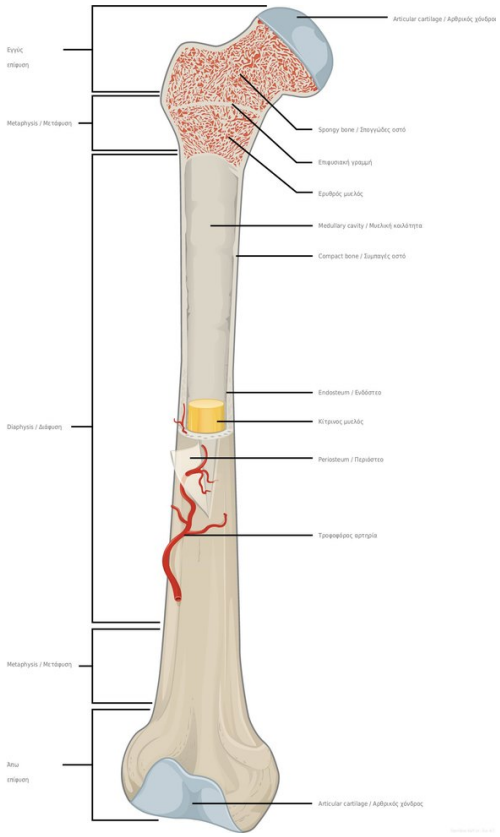
Πώς αποδίδεται στα ελληνικά το ulna;

Ulna σημαίνει ωλένη: είναι το οστό του αντιβραχίου προς την πλευρά του μικρού δακτύλου στη συνήθη ανατομική θέση. Δεν πρέπει να συγχέεται με την κερκίδα (radius).

Σε βάθος — επεξήγηση

Fracture σημαίνει κάταγμα, dislocation εξάρθρημα, joint άρθρωση, ligament σύνδεσμος και tendon τένοντας. Μια σύντομη περιγραφή μπορεί να είναι «Pain and swelling at the left ankle» — «Πόνος και οίδημα στον αριστερό αστράγαλο». Δεν χρησιμοποιούμε αγγλικό όρο που δεν γνωρίζουμε καλά για να αποφύγουμε λανθασμένη επικοινωνία.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Long bone — μακρύ οστό. Epiphysis, diaphysis, periosteum, medullary cavity.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/6-3-bone-structure.

06.06 — Αναπνευστικό σύστημα – terminology

Airway σημαίνει αεραγωγός, larynx λάρυγγας, trachea τραχεία, bronchus βρόγχος, lung πνεύμονας και diaphragm διάφραγμα. Inhalation και exhalation σημαίνουν εισπνοή και εκπνοή.

SOS · Trachea = τραχεία· bronchi = βρόγχοι· alveoli = κυψελίδες· diaphragm = διάφραγμα.

Θεωρία & κατανόηση

Ventilation είναι αερισμός, oxygenation οξυγόνωση, respiratory rate αναπνευστική συχνότητα και shortness of breath δύσπνοια. Οι όροι μοιάζουν μεταξύ τους αλλά δεν περιγράφουν πάντα την ίδια φυσιολογική διαδικασία.

Βασικό σημείο για επανάληψη

airway/αεραγωγός, ventilation/αερισμός, oxygenation/οξυγόνωση.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Airway είναι ο αεραγωγός, trachea η τραχεία, lungs οι πνεύμονες, breathing η αναπνοή, ventilation ο αερισμός. Διάκρινε «shortness of breath» = δύσπνοια από «no normal breathing» = απουσία φυσιολογικής αναπνοής. Οι δύο διατυπώσεις δεν είναι εναλλάξιμες. Σε εκπαιδευτική παράδοση συμπλήρωσε αντικειμενική περιγραφή της αναπνευστικής προσπάθειας και του χρόνου μεταβολής.

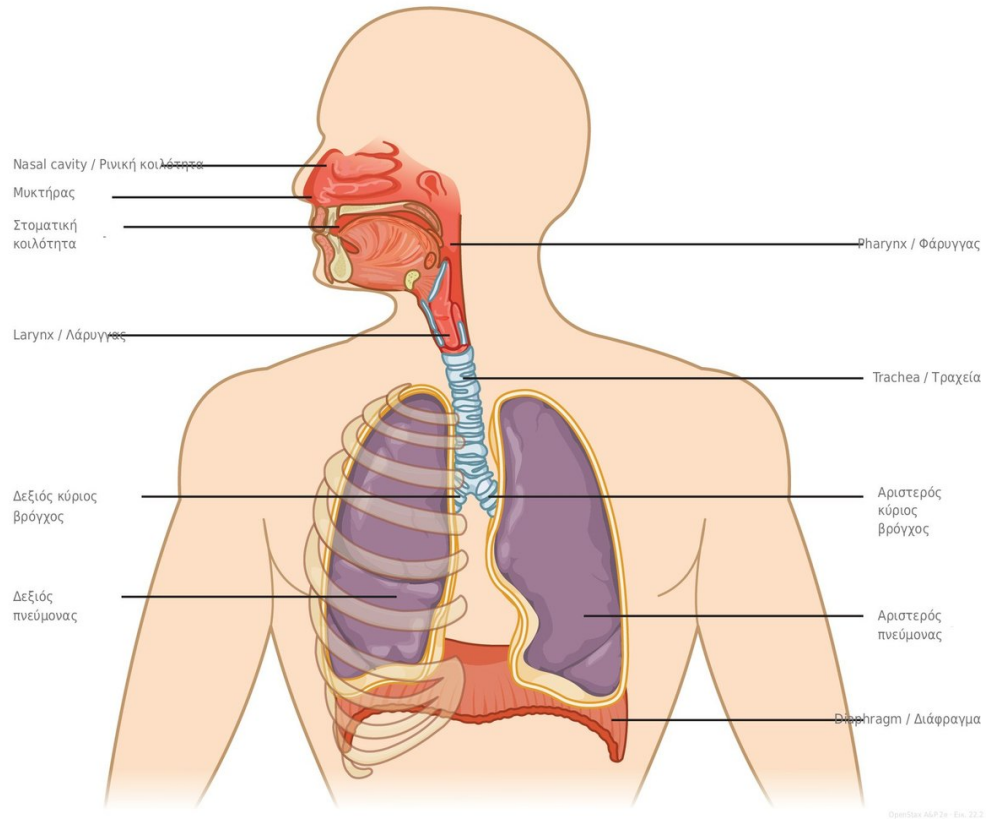
Τι σημαίνει respiratory rate;

Αναπνευστική συχνότητα.

Σε βάθος — επεξήγηση

Breathlessness ή shortness of breath σημαίνει δύσπνοια, wheezing συριγμός και cough βήχας. «He is breathing rapidly» σημαίνει «Αναπνέει γρήγορα». «Airway obstruction» είναι απόφραξη αεραγωγού και «oxygen saturation» κορεσμός οξυγόνου. Το «ventilation» αναφέρεται στον αερισμό, ενώ «oxygenation» στην οξυγόνωση.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Respiratory system — αναπνευστικό. Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, lung, diaphragm.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/22-1-organs-and-structures-of-the-respiratory-system.

06.07 — Καρδιά και κυκλοφορία – terminology

Heart είναι καρδιά, atrium κόλπος, ventricle κοιλία, artery αρτηρία, vein φλέβα, pulse σφυγμός και blood pressure αρτηριακή πίεση. Aorta σημαίνει αορτή, coronary arteries στεφανιαίες αρτηρίες.

SOS · Atrium = κόλπος· ventricle = κοιλία· artery = αρτηρία· vein = φλέβα.

Θεωρία & κατανόηση

Circulation σημαίνει κυκλοφορία, perfusion αιμάτωση και cardiac output καρδιακή παροχή. Στη διεθνή βιβλιογραφία cardiopulmonary resuscitation ή CPR είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Βασικό σημείο για επανάληψη

perfusion/αιμάτωση, blood pressure/αρτηριακή πίεση.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Heart σημαίνει καρδιά, pulse σφυγμός, blood pressure αρτηριακή πίεση, artery αρτηρία, vein φλέβα, circulation κυκλοφορία. «Weak pulse» αποδίδεται «ασθενής σφυγμός», ενώ «chest pain» σημαίνει «θωρακικός πόνος» και δεν ταυτίζεται με καρδιακή διάγνωση. Κατά την αγγλική αναφορά δώσε τιμή πίεσης, μονάδες όπου χρειάζεται και χρόνο λήψης.

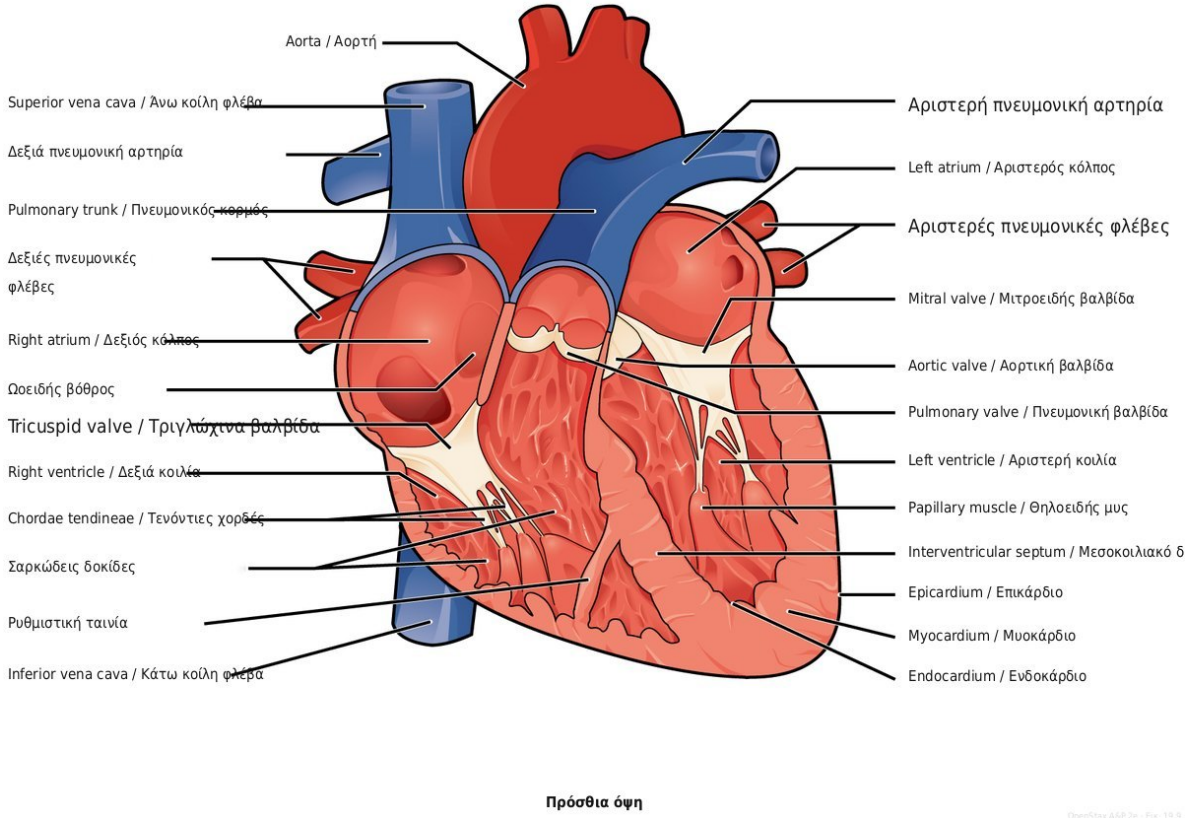
Πώς μεταφράζεται το cardiac output;

Καρδιακή παροχή.

Σε βάθος — επεξήγηση

Heartbeat σημαίνει καρδιακός παλμός, blood vessel αιμοφόρο αγγείο και chest pain πόνος στο στήθος. «Blood pressure is dropping» σημαίνει «Η αρτηριακή πίεση πέφτει». «Pulmonary circulation» και «systemic circulation» είναι πνευμονική και συστηματική κυκλοφορία. Ο όρος «cardiac arrest» μεταφράζεται καρδιακή ανακοπή και δεν είναι συνώνυμος του εμφράγματος.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Heart — καρδιά. Atrium, ventricle, valves, aorta, vena cava.. Δημιουργός: OpenStax, Anatomy & Physiology 2e (J. G. Betts κ.ά.). Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/19-1-heart-anatomy.

06.08 — Βασικά συμπτώματα – symptoms

Pain σημαίνει πόνος, chest pain πόνος στο στήθος, headache πονοκέφαλος, dizziness ζάλη, nausea ναυτία, vomiting έμετος και weakness αδυναμία. Fever σημαίνει πυρετός και cough βήχας.

SOS · Dizziness = ζάλη· nausea = ναυτία· weakness = αδυναμία· seizure = επιληπτική κρίση.

Θεωρία & κατανόηση

Consciousness είναι συνείδηση, confusion σύγχυση, seizure επιληπτική κρίση, fainting λιποθυμία και bleeding αιμορραγία. Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε complaint/κύριο ενόχλημα από objective finding/αντικειμενικό εύρημα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

symptom/σύμπτωμα, sign/κλινικό σημείο.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Dizziness σημαίνει ζάλη, fainting λιποθυμία, seizure επιληπτική κρίση, nausea ναυτία, bleeding αιμορραγία, fever πυρετός. Διαχώρισε την περιγραφή «patient reports dizziness» (ο ασθενής αναφέρει ζάλη) από «patient is unconscious» (ο ασθενής δεν έχει συνείδηση). Στην παράδοση δηλώνουμε σαφώς αν πρόκειται

για αναφερόμενο σύμπτωμα ή εύρημα εξέτασης.

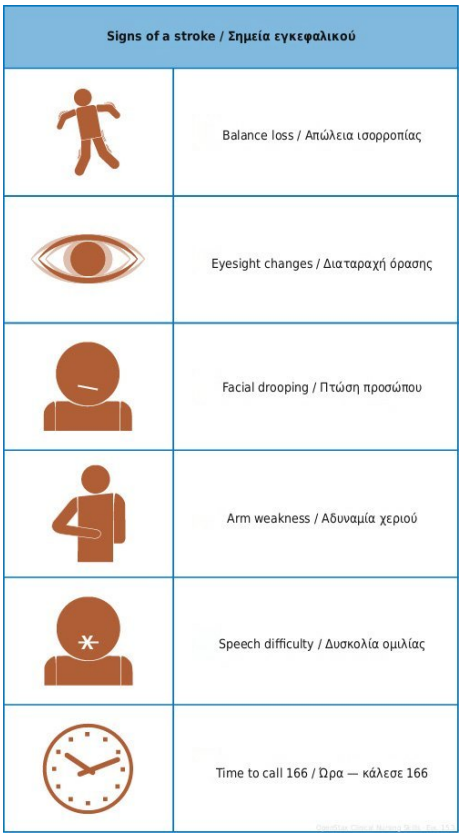
Τι σημαίνει ο όρος «dizziness»;

Dizziness σημαίνει ζάλη. Στην επικοινωνία με ασθενή χρειάζεται διευκρίνιση αν εννοεί περιστροφική ζάλη, αστάθεια ή τάση λιποθυμίας, γιατί πρόκειται για διαφορετικές περιγραφές συμπτωμάτων.

Σε βάθος — επεξήγηση

Weakness σημαίνει αδυναμία, numbness μούδιασμα, seizure επιληπτική κρίση/σπασμός κατά τα συμφραζόμενα και confusion σύγχυση. «Sudden onset» σημαίνει αιφνίδια έναρξη. «Fainting» αναφέρεται σε λιποθυμία, αλλά χρειάζεται προσοχή όταν περιγράφονται διαφορετικά είδη παροδικής απώλειας συνείδησης.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Signs of a stroke — σημεία εγκεφαλικού. BE FAST με αγγλική και ελληνική απόδοση.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή: https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/15-1-performing-a-general-survey.

06.09 — Αρχική εκτίμηση – assessment

Scene safety σημαίνει ασφάλεια σκηνής, primary survey πρωτογενής εκτίμηση, vital signs ζωτικά σημεία, history ιστορικό και reassessment επανεκτίμηση. Patient σημαίνει ασθενής και bystander παρευρισκόμενος.

SOS · Primary survey = πρωτογενής εκτίμηση· reassessment = επανεκτίμηση· vital signs = ζωτικά.

Θεωρία & κατανόηση

Emergency call σημαίνει επείγουσα κλήση, dispatcher χειριστής/διαβιβαστής και ambulance ασθενοφόρο. Η ακριβής αγγλική ορολογία βοηθά στην ανάγνωση εγχειριδίων, αλλά οι επικοινωνίες στο ελληνικό ΕΚΑΒ γίνονται με τα εγκεκριμένα τοπικά πρότυπα.

Βασικό σημείο για επανάληψη

primary survey/πρωτογενής εκτίμηση, reassessment/επανεκτίμηση.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Assessment σημαίνει εκτίμηση, responsiveness ανταπόκριση, airway αεραγωγός, breathing αναπνοή, circulation κυκλοφορία και reassessment επανεκτίμηση. Παράδειγμα: «reassessed after a change in breathing» = «επανεκτιμήθηκε μετά από αλλαγή στην αναπνοή». Η αγγλική φράση πρέπει να δείχνει τι πραγματικά ελέγχθηκε και να μην αφήνει να εννοηθεί παρέμβαση που δεν πραγματοποιήθηκε.

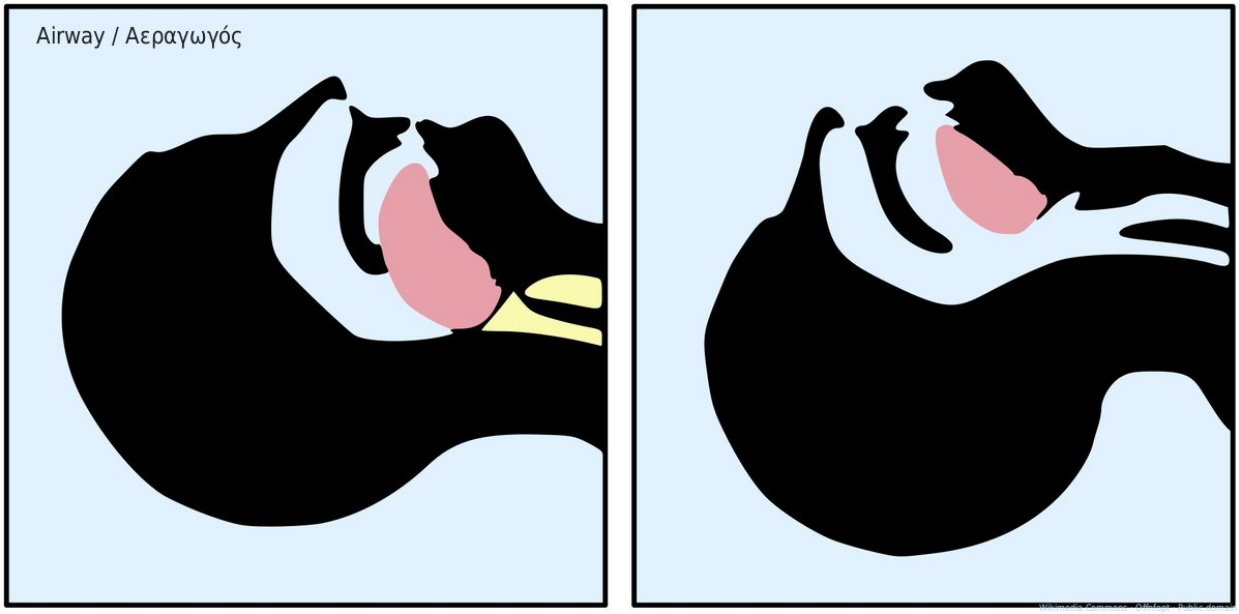
Πώς λέμε «ζωτικά σημεία» στα αγγλικά;

Vital signs.

Σε βάθος — επεξήγηση

«Are you taking any medication?» σημαίνει «Παίρνετε φάρμακα;». «What happened before the symptoms started?» σημαίνει «Τι συνέβη πριν αρχίσουν τα συμπτώματα;». «Medical history» είναι ιατρικό ιστορικό, «allergy» αλλεργία και «reassessment» επανεκτίμηση. Στόχος είναι να μπορεί ο σπουδαστής να κατανοεί και να συλλέγει βασικές πληροφορίες, όχι να αναλάβει ρόλο επαγγελματία διερμηνέα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: Airway — αεραγωγός. Απόφραξη αεραγωγού από τη γλώσσα.. Δημιουργός: Vassia Atanassova / Offnfopt. Άδεια: Public domain. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue_blocking_airway.svg.

06.10 — Μεταφορά και παράδοση – handover

Transport σημαίνει μεταφορά, transfer διακομιδή/μεταφορά κατά περίπτωση, stretcher φορείο, receiving hospital νοσοκομείο υποδοχής και handover παράδοση κλινικών πληροφοριών.

SOS · Handover = παράδοση κλινικής πληροφορίας και φροντίδας· receiving hospital = νοσοκομείο υποδοχής.

Θεωρία & κατανόηση

Mechanism of injury σημαίνει μηχανισμός κάκωσης, time of onset χρόνος έναρξης και treatment given θεραπεία/παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε. Η παράδοση πρέπει να μεταφέρει τους κρίσιμους χρόνους και ευρήματα χωρίς ελλείψεις.

Βασικό σημείο για επανάληψη

handover/παράδοση, mechanism of injury/μηχανισμός κάκωσης.

Διγλωσσική κατανόηση και εφαρμογή

Handover είναι η παράδοση ασθενούς, transfer η μεταφορά ή διακομιδή ανάλογα με το συμφραζόμενο, stretcher το φορείο και receiving team η ομάδα παραλαβής. Άσκηση: «The patient became less responsive during transport» σημαίνει «ο ασθενής παρουσίασε μειωμένη ανταπόκριση κατά τη διακομιδή». Πρόσθεσε την ώρα μεταβολής και τι ενημερώθηκε στο αρμόδιο προσωπικό, αποφεύγοντας ανεπιβεβαίωτες ερμηνείες.

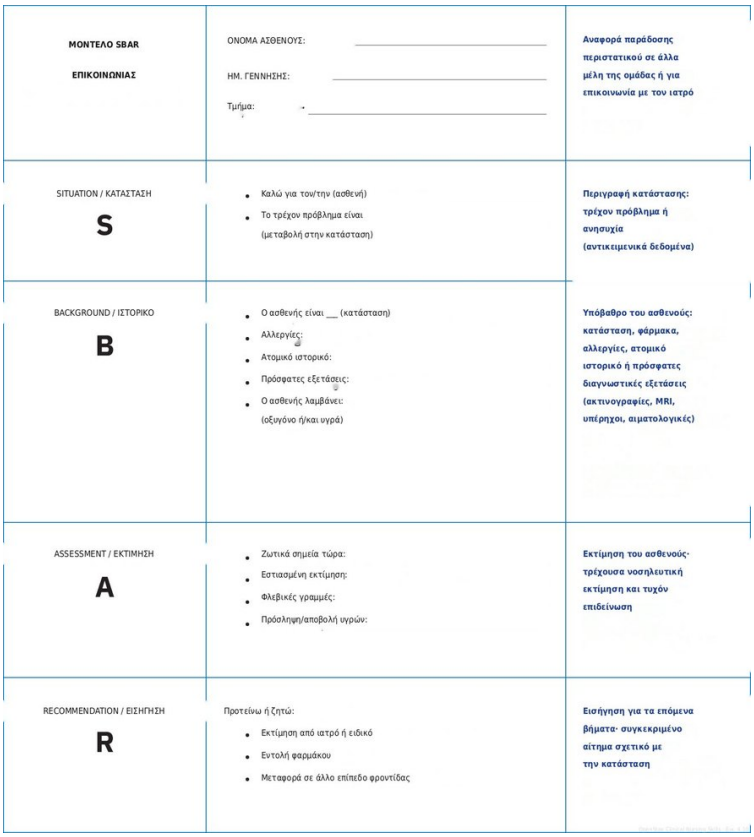
Πώς αποδίδεται το handover;

Παράδοση ασθενούς / πληροφοριών στο επόμενο επίπεδο φροντίδας.

Σε βάθος — επεξήγηση

«Handover» είναι η παράδοση ασθενούς και «receiving team» η ομάδα παραλαβής. Μια ασφαλής φράση είναι «These are the observations recorded during transport» — «Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διακομιδή». Μεταφέρουμε με σαφήνεια την ώρα κάθε μέτρησης. Εφόσον υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο, αναζητείται κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη σύμφωνα με το πλαίσιο του φορέα.

Πηγή προγράμματος: Επίσημος οδηγός κατάρτισης 2024 (περιγραφή μαθήματος, όχι πιστοποίηση των επιμέρους κλινικών ισχυρισμών).



Εικόνα: SBAR handover — παράδοση περιστατικού. Situation, Background, Assessment, Recommendation.. Δημιουργός: OpenStax, Clinical Nursing Skills. Άδεια: CC BY 4.0. Πηγή:

https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/4-2-data-collection-and-documentation.